

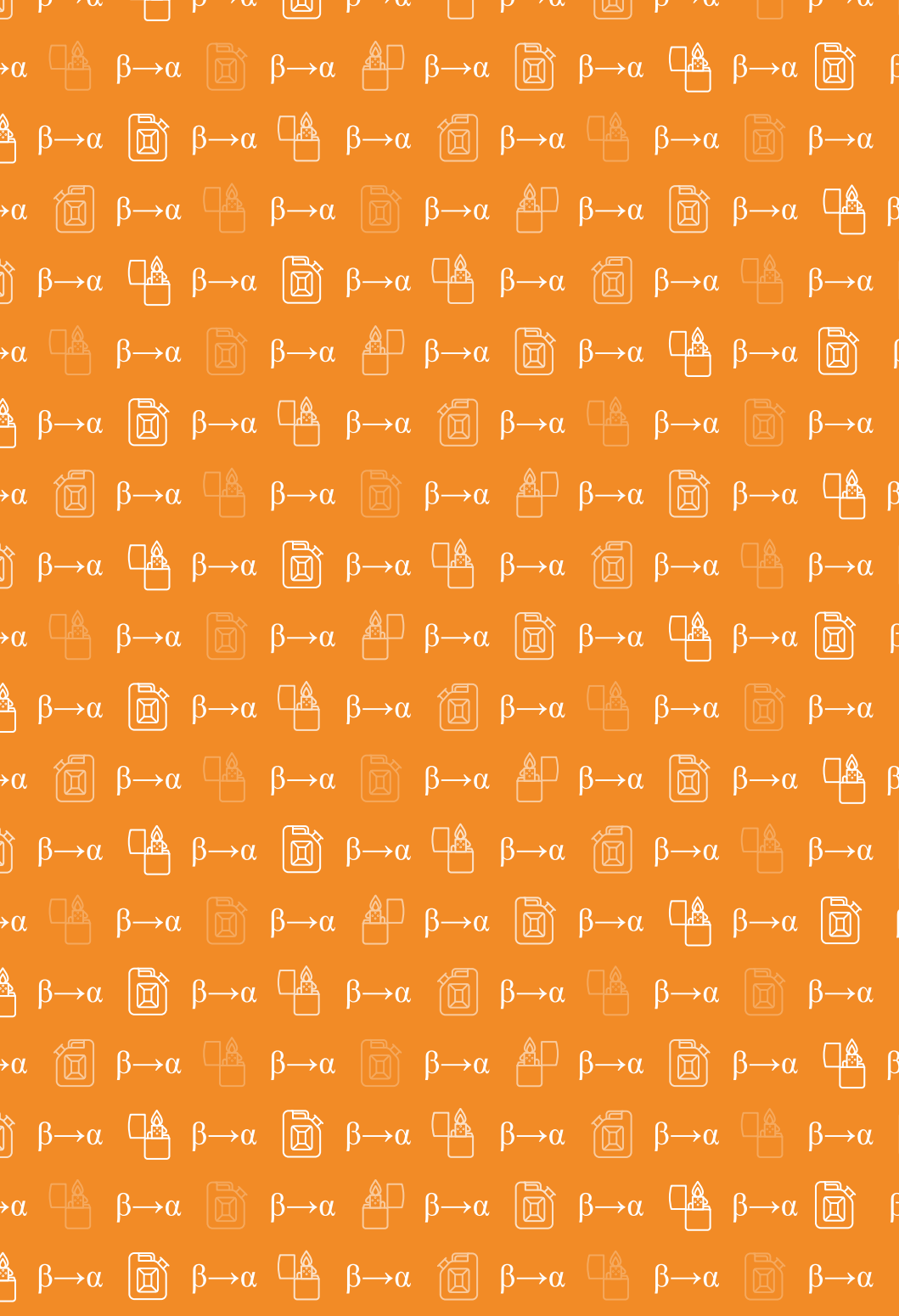


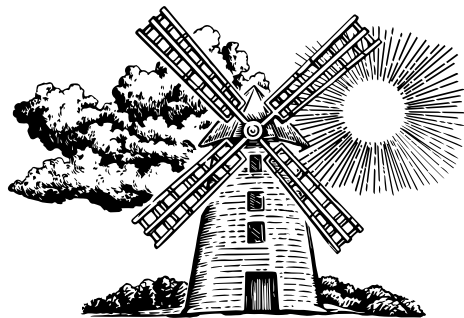
beta→alpha

Под редакцией  
Луки Николи

# Гореть вместе:

близость, истина и уязвимость  
в современном итальянском психоанализе





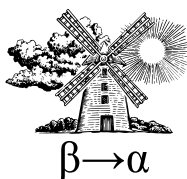
$\beta \rightarrow \alpha$



Под редакцией Луки Николи

**Гореть вместе:  
близость, истина  
и уязвимость в современном  
итальянском психоанализе**

Перевод с итальянского  
Оксаны Гончаровой



Москва  
Издательство Beta 2 Alpha  
2026

УДК 159.964.28

ББК 88.944.1

H63

- H63 Под редакцией Луки Николи. Гореть вместе: близость, истина и уязвимость в современном итальянском психоанализе / Перевод с итальянского О. Гончаровой. — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2026. — 256 с.  
ISBN 978-5-908131-02-5

Как работать с пациентом там, где «не хватает кислорода и жар почти нестерпим»? Как оставаться действительно рядом даже в неловких и непривычных ситуациях? Эта книга представляет собой сборник, в который вошли работы ведущих современных итальянских психоаналитиков и психотерапевтов, а также статья психоаналитика родом из России. Ключевая метафора — «гореть вместе» — означает готовность аналитика к созданию пространства, где возможна подлинная близость, к отважному столкновению с собственными ранами, к принятию обоюдной уязвимости и поиску эмоциональной истины в каждом контакте с пациентом. Авторы рассматривают аналитическую работу как процесс совместного пребывания и проживания с пациентом рождающегося в сессии опыта. Фокус смещается с интерпретации на сонастройку и живое, вовлеченное присутствие, необходимое для психической трансформации, которая производит глубокие изменения как в пациенте, так и в его аналитике. Клинические примеры иллюстрируют, как уязвимость аналитика и временный отказ от привычной аналитической позиции могут становиться частью поля, углубляя динамику взаимодействия в паре.

Издание служит практическим ориентиром и теоретическим мостом между итальянской и российской психоаналитическими традициями, предлагая смелую и глубоко человечную модель работы. Книга адресована психотерапевтам, психоаналитикам, психологам и всем, кто интересуется гуманитарным измерением психоанализа.

УДК 159.964.28

ББК 88.944.1

ISBN 978-5-908131-02-5

© Luca Nicoli, 2026

© О. Гончарова, перевод на русский язык, 2026

© М. Гусева, дизайн обложки, 2026

© Издательство Beta 2 Alpha, 2026

# Содержание

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Об авторах</b>                                                                         | <b>10</b> |
| <b>Введение: два мира, горящих вместе</b>                                                 | <b>13</b> |
| <b>Часть 1. Близость</b>                                                                  | <b>22</b> |
| <b>Будьте с пациентом там, где он есть: создание и поддержание аналитической близости</b> | <b>24</b> |
| В этой комнате нет никаких «нас»                                                          | 24        |
| Секретарша по имени Пеппер                                                                | 29        |
| Соппротивление/существование                                                              | 34        |
| Это не одно и то же                                                                       | 39        |
| Публичный образ, честь, достоинство и красота                                             | 42        |
| Враги близости                                                                            | 47        |
| Выводы                                                                                    | 50        |
| <b>Близость и ее интерпсихические эквиваленты</b>                                         | <b>52</b> |
| Близость                                                                                  | 53        |
| Основной пример психического эквивалента телесного состояния в анализе                    | 64        |
| Патологическая близость                                                                   | 66        |
| Близость... о чем это?                                                                    | 67        |
| Близость и либидинальные узы: между фиксацией и преданностью                              | 69        |

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Взгляд на пространство близости: аналитик и пациент в Поле</b>                                     | <b>75</b>  |
| Серджио: предпосылки к анализу                                                                        | 77         |
| Первые шаги в анализе                                                                                 | 79         |
| Турбулентности: теневые персонажи выходят на сцену                                                    | 82         |
| Воспоминания без памяти обретают возможность репрезентации                                            | 90         |
| Трансформируемость воспоминаний, которые существовали без памяти                                      | 95         |
| В заключение                                                                                          | 100        |
| <b>Когда вспыхивает страсть: аналитическая близость в сложных отношениях</b>                          | <b>102</b> |
| Плохая работа                                                                                         | 102        |
| Зар(О)ждение сессии: сколько страсти мы сможем пережить сегодня?                                      | 104        |
| Флорентийский стейк Бильбо Бэггинса                                                                   | 106        |
| Микрорепарации: как странствующие рыцари                                                              | 109        |
| Выводы: близость, истина и страсти                                                                    | 112        |
| <b>Часть 2. Истина</b>                                                                                | <b>115</b> |
| <b>«Я пришел сюда не для того, чтобы что-то менять»: психоаналитическая терапия в эпоху недоверия</b> | <b>118</b> |
| Общество Нарцисса                                                                                     | 118        |
| Неисследованная планета                                                                               | 120        |
| Сеттинг без обязательств                                                                              | 122        |
| Люди растут только тогда, когда их сновидят                                                           | 124        |
| На пути к терапевтической близости                                                                    | 126        |
| Меняться, не вовлекаясь в отношения                                                                   | 128        |



|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Мортиция, зрительница собственного желания                                                                                  | 132        |
| Сон о трупе                                                                                                                 | 133        |
| Неидеальное тело                                                                                                            | 136        |
| Заключение: только то, что неидеально,<br>по-настоящему живое                                                               | 138        |
| <b>Говорящие действия и совместная работа<br/>психиатрии и психоанализа в лечении<br/>эмоциональных срывов у подростков</b> | <b>141</b> |
| Введение                                                                                                                    | 141        |
| Примитивная психическая организация<br>и терапевтическая трансформация                                                      | 142        |
| Роза                                                                                                                        | 143        |
| Некоторые размышления <i>après coup</i>                                                                                     | 147        |
| Заключение                                                                                                                  | 150        |
| <b>Носки аналитика. Самораскрытие, границы<br/>и интерсубъективная игра</b>                                                 | <b>152</b> |
| Носки доктора Джекилла: любопытство<br>и эмоциональная вовлеченность                                                        | 152        |
| Между моноперсональной традицией<br>и интерсубъективным измерением                                                          | 154        |
| Сохраняя приватность аналитика: на метр позади<br>кресла                                                                    | 157        |
| Ненасыщенные реакции и ирония: инструменты<br>аналитического поля                                                           | 159        |
| Ложь и преходящие истины: игра с пылью                                                                                      | 161        |
| Заключение: носки, слезы и разделяемые<br>сновидения                                                                        | 166        |
| <b>Часть 3. Уязвимость</b>                                                                                                  | <b>167</b> |
| <b>Присутствие сквозь шум сирен</b>                                                                                         | <b>168</b> |

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Уязвимый аналитик: от мифа к реальному переживанию</b>                                                                | <b>175</b> |
| Война в аналитическом поле: неизбежные сложности и расхождения                                                           | 177        |
| Аналитик под бомбами: традиция, которая продолжает жить                                                                  | 180        |
| Заключение                                                                                                               | 182        |
| <b>Рождение дочери как «переломный» момент: непрерывность и катастрофические изменения в идентичности аналитика-отца</b> | <b>183</b> |
| Великая жертва аналитика                                                                                                 | 183        |
| Подобно вечному Кроносу                                                                                                  | 185        |
| Чтобы стать отцом...                                                                                                     | 187        |
| Лола                                                                                                                     | 189        |
| Два сна: «тот могущественный и загадочный доктор»                                                                        | 192        |
| Обсуждение: аналитическое отцовство                                                                                      | 194        |
| <b>Джим / Моррисон: нарциссическая рок-звезда / хрупкий нарцисс</b>                                                      | <b>197</b> |
| Рок и психоанализ: Джим Моррисон сталкивается с Нарциссом в себе                                                         | 198        |
| The Doors: альбом взглядов и объятий                                                                                     | 202        |
| <b>Предавая наш психоанализ? Популяризация психоанализа: от утраты до трансформирующего перевода</b>                     | <b>207</b> |
| Введение: сложность популяризации                                                                                        | 207        |
| «Предать» психоанализ, чтобы он мог жить                                                                                 | 211        |
| От реальности к повествованию: популяризация и трансформации                                                             | 216        |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Фрейд и меняющийся мир: опыт популяризации              | 222        |
| Заключение: утонченное и сложное путешествие            | 226        |
| <b>Заключительное слово: итальянский путь к счастью</b> | <b>228</b> |
| Счастье и возвращение                                   | 230        |
| Клинический материал: как путники перед костром         | 233        |
| Заключение: счастье и красота                           | 237        |
| <b>Благодарности</b>                                    | <b>239</b> |
| <b>Библиография</b>                                     | <b>241</b> |

## Об авторах

К участию в этом коллективном издании я пригласил тех коллег, с кем чувствую наибольшую близость в отношении стиля работы, теоретической и клинической позиции и уважения к человеческим судьбам. Для меня большая честь и радость делить с ними эти страницы, на которых мы излагаем наше понимание психоанализа.

*Стефано Болоньини* не нуждается в представлении, поскольку он возглавлял Международную психоаналитическую ассоциацию (IPA) и Итальянское психоаналитическое общество (SPI) и остается одним из самых известных итальянских психоаналитиков в мире. Для меня он главная теоретическая и клиническая опора. Его работы об эмпатии и интерпсихическом взаимодействии легли в основу моих размышлений о близости, приведенных в этом сборнике.

*Джанни Белья* — один из самых мудрых и добрых людей, которых вы можете встретить в своей жизни. Щедрость, с которой он делится рассказом о своем аналитическом путешествии вместе с пациентом Серджио, дарит нам одно из наиболее развернутых клинических опи-

саний модели поля, когда-либо созданных. Он является действительным членом SPI.

*Моника Бомба* — тонкий исследователь и глубокий клиницист, любознательный и неутомимый. Представленная ею работа демонстрирует, как опыт внимательного психоаналитика может оказать влияние и на клиническую практику в психиатрическом стационаре. Моника — ассоциированный член SPI и научный секретарь Миланского центра психоанализа.

*Полина Черкас* — единственная неитальянская участница этого сборника. Это жизнерадостная и талантливая молодая девушка, специалист по индивидуальному и групповому анализу. Она выросла и получила образование в Москве, а несколько лет назад эмигрировала в Израиль. Выслушав от нее лично историю работы «аналитика под бомбами» во время недавнего конфликта между Израилем и Ираном, я предложил ей сопроводить ее проникновенное свидетельство моими размышлениями об уязвимости аналитика.

*Витторио Гонелла*, чуткий детский психотерапевт и мой близкий друг, сочетает в себе способность к глубокому и заботливому слушанию с неподдельной страстью к рок-музыке. Его коллекция дисков поистине необозрима. Из множества его прекрасных текстов, в которых он объединяет рок-музыку и психоанализ, я выбрал для книги тот, который рассказывает об уязвимости такой культовой фигуры, как Джим Моррисон. Витторио состоит в Итальянском обществе психоанализа и психотерапии имени Шандора Ференци.

*Элена Морганти*, миланский психолог, проходящий обучение в Адлерианской школе психотерапии, на про-

тяжении года еженедельно совершала долгие поездки из своего города, где у нее напряженная работа и прекрасная семья, в мой кабинет в Модене, чтобы дышать очаровавшей ее атмосферой итальянского и международного психоанализа.

*Стефано Туньоли* — мой драгоценный друг, с которым нас на протяжении пятнадцати лет объединяет страсть к популяризации психоанализа. Организовав десятки семинаров, конференций и встреч с несколькими тысячами участников, мы выдвинули теорию, которая легла в основу популяризации психоанализа. Применяя модель поля к «популяризаторским сессиям», мы намерены проводить мероприятия, не только информирующие аудиторию, но и дающие возможность пережить опыт психоаналитического слушания. Стефано — ассоциированный член SPI.

# Введение: два мира, горящих вместе

Кто бы мне сказал четыре года назад, когда я только начинал сотрудничество с российскими коллегами, что сегодня я соберу вокруг себя самых близких друзей, тех, с кем разделяю страсть к психоанализу в Италии, и представлю их в книге, впервые опубликованной в России, а не в нашей стране.

Я не только не мог сказать ни слова по-русски, но и не был знаком ни с кем из вас, как не был знаком и с российским психоанализом, сформировавшимся под сильным влиянием французской школы и подхода, ориентированного на интрапсихическое измерение анализа. Речь идет о тонкой работе слушания другого, расшифровке бессознательных значений, скрытых в речи, реконструкции детских переживаний, которые продолжают действовать в переносе, серьезно ограничивая свободу пациента.

Этот важнейший вклад, унаследованный от Фрейда и поколений исследователей психоанализа, уже несколько десятилетий претерпевает процессы трансформации

и интеграции с другими наблюдательными вертексами, на протяжении истории отмечавшими развитие нашей дисциплины. В Италии на работу наших мастеров сильное влияние оказали идеи Ференци, Винникотта, Биона и множества аналитиков, ориентированных на исследование межличностных отношений. За последние сорок лет интенсивное обновление и интеграция теории и техники превратила итальянские психоаналитические центры в кузницы новых рабочих моделей. Фокус внимания коллег сместился с изучения субъекта на индивидуальное переживание ощущения себя живым вместе со своим аналитиком в творческих, питающих, новых отношениях.

Такие слова, как «отношения», «эмпатия», «трансформация», «я» и «личность», заняли центральное место в наших текстах, как и понятия «унисон», «разделяемое творчество» и «аналитическое поле».

В последние годы мы стали свидетелями эпохальных сдвигов: от работы *над* пациентом к работе *с* пациентом; от сосредоточенности на понимании пациента к возможности сновидеть его в процессе становления самим собой; от вопроса, *что* мы говорим пациенту, к вопросу, *как* мы это говорим.

И поэтому для меня стало крайне важным не только выбрать, чем именно из итальянского психоанализа поделиться с вами, но и найти способ донести это до вас. Я называю этот способ близостью. Близость — понятие, редко используемое в психоанализе, возможно потому, что Фрейд считал, что она уже подразумевается в аналитических отношениях, но полагал рискованным явно обозначать это из-за возможных семантических двусмысленностей. Тем не менее я думаю, что каждому ана-



литу хорошо известно, что глубинные трансформации в человеке невозможны без длительных и последовательных шагов к близости, без глубокого совместного переживания содержаний, одновременно и информативных, и эмоциональных.

Для меня близость означала встречи и совместную работу с коллегами из русскоязычного мира, привыкание к ударениям в именах и ритму речи. Она означала зарождение глубокой дружбы с ответственным редактором и переводчиками издательства Beta 2 Alpha, работу плечом к плечу над языковыми нюансами и культурными различиями. Она означала беседы онлайн и очно с сотнями коллег о наших способах слушать пациентов и интерпретировать клинический материал, дискуссии о русской культуре и современном мире, возможность разделить атмосферу кабинетов в Москве, Сочи, Екатеринбурге, в качестве любопытного супервизора заглядывать в онлайн-пространства, созданные для пациентов, находящихся вдали от своих аналитиков и разбросанных по разным странам — от Грузии до Израиля, от Турции до Украины, кавказских республик и Центральной Азии.

Только после знакомства с такими фантастическими персонажами, как Баба-яга, Чебурашка, Ежик в тумане, только после узнавания в клинических случаях теней советского прошлого или следов алкоголизма, который, словно чума, проникает во многие русские семьи, только разделив с коллегами переживания жизни, смерти и дружбы, коснувшиеся нас за годы совместной работы, я смог ощутить ту эмоциональную и культурную близость, которая позволила мне говорить с вами максимально искренне. Два мира, горящих вместе.

В кабинете анализа близость, о которой я говорю, отражается в умении *быть с пациентом там, где он сейчас находится*. Этот зов, ставший для меня очень важным, предполагает готовность настроиться на психическое функционирование конкретного человека, в конкретный день и в конкретный момент сессии, и принять неизбежность препятствий, с которыми мы столкнемся, — и давайте больше не будем называть их сопротивлением, потому что это единственный возможный способ выдерживать встречу с другим.

Сегодня утром моя российская коллега представила случай подростка, который пришел на сессию, крича от невыносимой боли в ушах и закрывая их руками. Только после того, как терапевт перестала просить его рассказать о своей боли словами или нарисовать ее и согласилась просто быть рядом, молча, мальчику внезапно стало лучше. Терапевт перестала *сопротивляться* (и тут я себе противоречу) желанию «быть аналитиком» и позволила себе просто присутствовать рядом, плечом к плечу, чтобы впитывать, как губка, избыток криков и «текущей» боли, затопивших юного пациента и кабинет коллеги.

Сколько раз мне доводилось обсуждать, способен ли другой принять нас (или не принять) как отдельных субъектов или хотя бы как живых существ! Иногда некоторые пациенты могут выносить наше живое присутствие рядом, только если мы исполняем роль функции или неодушевленного объекта. Вспомним предупреждение известного итальянского аналитика Джованни Дзаппароли, которое Стефано Болоньини цитировал в нашей беседе о психоанализе настоящего и его проблемах: «Если во время сессии тяжелый психотический пациент

хочет, чтобы мы были стулом, значит, мы должны быть стулом в этот момент» (Bolognini, Nicoli, 2022).

Если мы хотим сонастроиться с ранними состояниями психики, мы должны принять необходимость сочетания нашего привычного способа объектного функционирования с умением максимально адаптироваться к потребностям пациента<sup>1</sup>.

Пребывание в близости, как мы увидим на следующих страницах, процесс нелинейный и неоднозначный. Как и в повседневной жизни, ее враги всегда наготове: аутистическая потребность в изоляции, нарциссическое стремление к контролю, тревожное беспокойство, бегство от депрессии в маниакальность постоянно порождают моменты отчуждения — будь то микротрещины или долгие паузы — в любых человеческих отношениях. Эти остановки составляют часть естественной диалектики встречи/столкновения между собой и другим.

В этой книге клинические виньетки будут сопровождаться довольно лаконичными анамнестическими заметками. Слишком часто биографию используют для логического объяснения происходящего в сессии, как если бы смысл того, что разворачивается *здесь и сейчас*, мог быть исчерпан бессознательными повторами пациента; мы же, как авторы, наоборот, старались выделить то новое, что возникает в каждый момент аналитической встречи. Расставания и репарации представляют собой один из наи-

1 Здесь я хочу еще раз напомнить о разнице между потребностями и желаниями наших пациентов. Первые нельзя подвергать чрезмерной фрустрации, чтобы не рисковать эмоциональной стабильностью пациента. Вторые же, напротив, должны удовлетворяться с большой умеренностью и всегда ради того, чтобы содействовать здоровому развитию аналитических отношений.

более действенных способов, посредством которых психоанализ исцеляет способность пациента к установлению значимых отношений с самим собой и с другими.

В процессе анализа пациент и аналитик порой ощущают звучание новой гармонии между ними, благодаря которой они чувствуют себя живыми и подлинными. А потом мелодия распадается, и аналитической паре приходится тратить минуты, дни или целые месяцы в попытках найти гармоничный и *плодотворный* способ быть вместе.

Я использую слово «*плодотворный*», потому что близость обретает смысл (не сводясь при этом к искусственности, актерству или, что хуже, садомазохистской игре) только тогда, когда она способна приносить плоды. В моем понимании психоанализа таким плодом является максимально возможное совместное проживание эмоциональной истины этой встречи.

В этой книге я буду говорить об *истине* как о продукте поэтической способности психики и умения психики представлять себя и мир в символической форме, а также как о диалектическом процессе, в ходе которого эта поэзия психики возникает. Этот процесс — не что иное, как встреча сознательного и бессознательного, или встреча между собой и другим.

Согласно Сократу, мышление (*logos*) неизбежно рождается как диалог, то есть как встреча. Письма Фрейда к Флиссу, в которых отец психоанализа рассказывает о трудностях зарождения этой дисциплины, представляют собой пример того, как мысль возникает в ходе беседы. Более того, поскольку из их переписки сохранились только письма Фрейда, без ответов его друга, мне нра-

вится воображать, что Флисс был не столько реальным человеком, сколько вымышленным собеседником, разговоры с которым позволяли Фрейду продвигаться в разработке своих теорий.

Если Анна Франк, борясь за эмоциональное выживание в течение тех отчаянных месяцев в тайном укрытии, персонифицировала свой дневник, назвав его Китти, если потерпевший кораблекрушение герой Тома Хэнкса в знаменитом фильме «Изгой» сохранил свою психику здоровой, «оживив» напарника Уилсона, который был не чем иным, как волейбольным мячом, то почему бы не вообразить, что основатель психоанализа смог избежать чувства научной изоляции, к которой ощущал себя приговоренным, создав воображаемого собеседника?

Как выразился Огден, осмысляя концепции Биона, «для того чтобы мыслить наиболее тревожащие мысли, нужны две психики» (Ogden, 2008, p. 97). Следовательно, истина и встреча двух психик неразрывно связаны. Истина, которую невозможно передать, рискует или угаснуть, если ее не подпитывать, или, наоборот, сгореть, если не уменьшить пламя. Человеческая психика создана для существования в отношениях: нам суждено гореть вместе.

Третий элемент, входящий в название этой книги, *уязвимость*<sup>2</sup>, вызывает образ страдания, *vulnus*<sup>3</sup>, общего для обоих участников аналитической пары. При всей асимметрии ролей и ответственности человеческая участь пациентов и терапевтов подвергает их схожим моментам

2 По-итальянски *vulnerabilità*. — Прим. пер.

3 На латыни означает «рана», в метафорическом смысле «уязвимость». — Прим. пер.

уязвимости: болезни, семейные кризисы, крупные политические и социальные события разрушают иллюзию неуязвимости аналитика и возвращают его в пространство общей смертности.

Долгое время психоаналитические модели, ориентированные на нейтральность и воздержанность, пренебрегали аналитиком как личностью, подчеркивая прежде всего его функцию как инструмента аналитического процесса. Сегодня те из нас, кто работает в пространстве отношений или аналитического поля, не могут позволить себе игнорировать сопротивления и уязвимости, которые каждый раз привносятся аналитиком в сессию.

*Гореть вместе* означает совместно выдерживать натиск эмоций, с которыми оба участника аналитической пары приходят на встречу. Это означает признание того, что мы не только приносим облегчение страданию другого, но и бессознательно ищем у пациентов облегчения нашего собственного человеческого состояния. Остается надеяться, что чувство ответственности побудит нас заботиться о себе, не перегружая при этом аналитическую ситуацию.

Непрекращающийся и дорогостоящий труд личного анализа, супервизий, интервизий с коллегами необходим, чтобы стать и оставаться психоаналитиком. Мы не можем работать в одиночку без ущерба для терапевтической функции; поэтому мы вправе с уверенностью утверждать: «Чтобы стать аналитиком, нужно иметь хотя бы одного пациента и хотя бы одного коллегу» (Bolognini, Nicoli, 2022).

Сохранение аналитической позиции вопреки личной уязвимости — задача деликатная и редко упоминаемая

в классических руководствах. Именно современному психоанализу предстоит осмыслить и прояснить, каким образом мы можем глубже и теснее переплести наши эмоциональные усилия с усилиями наших пациентов, не обременяя их сверх меры.

То, что пациенты XXI века всё еще обращаются к психоаналитической терапии, связано с интенсивностью эмоций, которые их захлестывают и заставляют тратить время, энергию и деньги в отчаянной попытке найти того, кто убавит огонь и поможет им понять свои пылающие страсти, разделить с другим и передать. И поскольку вы все выбрали профессию психоаналитического психотерапевта, вам предстоит быть с ними именно там, где не хватает кислорода и жар почти нестерпим.

И напротив, бывают и другие клинические ситуации, в которых давние катастрофы заставили эмоциональный мир человека онеметь. Некоторые подростки кажутся недостижимыми для страстей: захваченные фантазиями, прячущиеся за непреодолимыми обессивными барьерами или одурманенные сенсорным гипервозбуждением, которое дробит их чувства на множество маленьких огоньков, не способных согреть. Некоторые пациенты словно обречены на жизнь без подзарядки. «Мой отец оставил мне часы с зарядом в три процента, но я не знаю, какое зарядное устройство к ним подходит», — так начал сессию молодой пациент несколько дней назад.

В таких ситуациях хронической ангедонии мы вынуждены одалживать наше сердце пациенту до тех пор, пока он не научится слышать тиканье собственного сердца, подобно Железному Дровосеку из «Волшебника страны Оз».

Многих из нас, однако, не обучали такому глубокому взаимопроникновению с пациентами: одно дело — глубокое, принимающее слушание, и совсем другое — одалживать нечто свое тому, у кого этого нет. Десятилетиями психоанализ предостерегал нас от того, чтобы делиться с пациентами чем-то принадлежащим нам. Именно поэтому эта операция настолько деликатна.

Мне хочется надеяться, что книга «Гореть вместе: близость, истина и уязвимость в современном итальянском психоанализе» станет для вас инструментом, помогающим оставаться рядом с пациентом в неудобных и непривычных ситуациях, которые будут неизбежно возникать на протяжении вашей профессиональной карьеры. Я верю, что представленные здесь тексты послужат вам стимулом, как безмолвные спутники, способствующие рождению новых клинических идей.

В то же время эта книга представляет собой момент встречи между вами и авторами, вложившими в свои работы весь накопленный психоаналитический опыт, всю человечность. Это мост, соединяющий далекие страны, где звучат чужеземные акценты и используются разные алфавиты. Это деликатное посредничество, которое, как мы надеемся, позволит сблизить разнородные культуры и истории благодаря общей страсти к нашей любимой дисциплине.

Таким образом, «гореть вместе» — это не только описание того, что ежедневно происходит в наших аналитических кабинетах, но и приглашение никогда не переставать разделять с вашими коллегами страсть к психоанализу и исцелению человеческой души.



# Часть 1. Близость

# Будьте с пациентом там, где он есть: создание и поддержание аналитической близости

*Лука Николи*

## **В этой комнате нет никаких «нас»**

«Чтобы помочь Франческе справиться с этим состоянием постоянной тревоги, мы рассмотрим ее отношения с эмоциями, которые ее переполняют...»

«Мне кажется очевидным, доктор, что в этой комнате нет и не будет никаких “нас”. Здесь только я и вы, или я ошибаюсь?»

Приступая к теме установления аналитической близости и препятствий, встречающихся на этом пути, я не мог не вспомнить один из самых забавных (с сегодняшней точки зрения) диалогов, которые у меня случались в связи с этим вопросом. Франческа, молодой и очень талантливый математик, пришла в терапию, не-

смотря на множество опасений и внутренних противоречий, по причине агорафобии, заметно ограничивающей ее жизнь. В ходе совместной работы мы пришли к пониманию того, как постоянное симбиотическое использование Франчески ее матерью превратило саму идею близости в угрозу, которой нужно всеми силами избегать.

Для меня поучительным аспектом в нашем взаимодействии стало осознание того, что я ожидал, что пациентка намного ближе ко мне, чем это было на самом деле. Измерение «мы» предполагает способность к близкому сосуществованию, способность вовсе не очевидную, когда исходная среда не позволяет индивиду просто существовать, а вынуждает его лишь реагировать — из-за препятствующего и преследующего первичного объекта или из-за его отсутствия и эмоциональной неосвязаемости.

Понятие близости стали исследовать в психоанализе только в последние десятилетия: быстрый поиск в архивах PER<sup>4</sup> по слову *intimità/intimacy* показывает экспоненциальный рост его употребления в текстах и названиях работ, который особенно заметен с 1980-х годов и еще больше — с 2000-х.

По изначальной задумке Фрейда, суть психоанализа заключалась в интрапсихическом исследовании пациента, которое должно было быть максимально объективным. Определенная клиническая близость была заложена в самом характере отношений аналитической пары, но не становилась центром внимания, если только

4 *Psychoanalytic Electronic Publishing* — электронная научная платформа, предоставляющая доступ к ключевым журналам и книгам по психоанализу, психотерапии и смежным дисциплинам; широко используется исследователями и практиками как авторитетный архив классических и современных психоаналитических текстов. — *Прим. ред.*

не проявлялась в искаженных и крайних формах, как перенос и контрперенос.

Именно с развитием биперсональных, реляционных, интерсубъективных и полевых парадигм интерес психоаналитиков стал смещаться в сторону способности участников аналитической пары настраиваться друг на друга, чтобы дать место эмоциональным трансформациям, присущим аналитическому процессу.

Мельтцер (Meltzer, 1986) утверждает, что задача психоанализа состоит в том, чтобы трансформировать природу аналитических отношений, изначально договорную, в отношения близости, включающие эмоциональный опыт, который способен стимулировать психический рост посредством длительных усилий по контейнированию и символизации переживаемых эмоций.

Значимые эмоциональные и творческие шаги пациента и аналитика навстречу друг другу — онтологическое измерение психоанализа, по определению Огдена (Ogden, 2019), — требуют от клинициста умения приостанавливаться и поддерживать в живом и действующем состоянии пространство встречи, которое способствует этим шагам и оберегает их, — то есть аналитическую близость.

С клинической точки зрения, понятие близости нельзя считать достигнутым раз и навсегда. Слова «мы достигли близости» звучат как старое доброе «и жили они долго и счастливо» из сказки, которой убаюкивают детей, но они ничего не рассказывают об эмоциональных бурях, собственных любым человеческим отношениям. Как и другие понятия, такие как сеттинг, перенос, эмпатия, близость может быть очень полезным инструментом, если только не пытаться превратить ее в нечто зафиксированное, ове-

щественное. Если же она, напротив, остается динамичным, изменчивым и непреднамеренно приходящим измерением, она может показывать состояние аффективной проницаемости аналитической пары в каждый момент времени.

Близость формирует ту область контакта, которая позволяет нам заставить внутренние струны пациента вибрировать от наших комментариев или интерпретаций. Она представляет собой совместно проживаемое состояние относительной внутренней свободы, более проницаемое для предсознательных и бессознательных коммуникаций, которые делают возможными процессы субъективации, сновидения<sup>5</sup> и переваривания переработанных травм.

И наоборот, мы сразу же понимаем, что очень далеки от этого счастливого, а потому весьма шаткого измерения, когда в ответ на наши искренние и страстные интервенции слышим: «И что?»

Если другой не знает, куда ему девать наш вклад, нам ничего не остается, как сделать вывод: мы далеки от того, чтобы дать ему нечто действительно ценное. «Нечто меньшее, чем интерпретация», — сказал бы Стерн и его коллеги (Stern, et al., 1998). Иногда, как в случае Франчески, который я привел в самом начале, пациент находится вовсе не там, где мы представляли: он функционирует на более регрессивном уровне или защищается от вторжений преследователя; в других случаях именно аналитику трудно задержаться на пороге на то время, которое необходимо,

5 Мы используем слова «сновидеть», «сно-видение» и «сон»/«сновидение» в зависимости от контекста. Сно-видение передает идею Бюна о сновидческой активности как базовой психической функции, непрерывно действующей как ночью (сновидения), так и днем (мысли, эмоции). — *Прим. ред.*

как Генриху IV было трудно стоять на коленях в Каноссе<sup>6</sup>, или же аналитик избегает соприкосновения с собственными болезненными ранами и шрамами. С точки зрения поля, есть области, которые пока необитаемы или охраняются свирепыми призраками, и аналитическая пара вынуждена держаться от них подальше, пока не появится возможность осторожно их исследовать.

Цель этой работы — поразмышлять о том, как даже в самых невозможных, казалось бы, случаях можно продвинуться вперед, если согласиться начать с позиции, крайне далекой от нашей привычной аналитической рабочей ситуации.

Вместе с доктором Каппа, почти реальным собеседником, с которым я буду обсуждать настоящий клинический случай<sup>7</sup>, мы постараемся добраться до мистера Тони туда, где он эмоционально находится, выдержать замкнутость его переживаний и оттуда помочь ему прожить вместе — и сновидеть — всё то, что осталось непрожитым, травматичным, запретным и застывшим в его психике.

6 Этот эпизод произошел в январе 1077 года перед замком графини Матильды Каносской в Северной Италии. Во время политической борьбы между папой Григорием VII и императором Генрихом IV последний, чтобы добиться отмены отлучения от церкви, был вынужден перенести унижение, простояв на коленях в снежную бурю три дня и три ночи перед воротами замка.

7 Когда мысль становится диалогом, она разворачивается, приобретает широту и новые вертексы наблюдения. Мы видим это в сократических диалогах Платона, в письмах Фрейда к Флиссу, в его постоянных обращениях в эссе к своим предполагаемым оппонентам или собеседникам. Я хотел бы упомянуть клинические семинары Бiona (Bion, 1973, 1974, 1978, 1985) и трилогию *A Memoir of the Future* (Bion, 1975, 1977, 1979), а также недавний диалог Огдена с мастерами психоанализа (Ogden, 2012). Сегодня *in between* (в пер. с англ. «происходящий между») характер этого значения, в высокой степени реляционного и интерсубъективного, привел к тому, что ряд коллег стали оформлять научную работу как интервью или беседу (Ogden, 2013; Ferro, Nicoli, 2017; Lütz, Kernberg, 2020; Nicoli, Bolognini, 2022).

Эта работа вдохновлена длительной супервизией, которую мы ведем с блестящим коллегой, чье имя я не назову для защиты конфиденциальности пациента, о котором пойдет речь. Любопытство, вопросы и сомнения коллеги дали мне возможность неоднократно прояснять и уточнять, как с ним, так и наедине с собой, мои гипотезы о построении и поддержании аналитической близости. Поэтому я захотел воспроизвести диалогическую природу мышления в тексте, введя персонажа Каппа, который выступает как своего рода интересубъективный третий, возникший в ходе нашей работы над темой близости.

## Секретарша по имени Пеппер

**Каппа:** Со мной связался мистер Тони, очень обеспеченный предприниматель, молодой, амбициозный и уверенный в себе. Решительный и энергичный, он обращается за терапией онлайн после того, как другие специалисты потерпели неудачу. Он сделал странное заявление: «Я больше не беру женщин-врачей». Он так и сказал, словно его предыдущие терапевты были женщинами, с которыми он занимался сексом. «Теперь я хочу обсуждать всё с мужчиной, как мы делаем это в рамках бизнеса».

Он называет себя гением, кем-то вроде Железного человека, но по ночам его мучают кошмары. В детстве он стал жертвой сети педофилов; он рассказал, что они творили с ним ужасные вещи, подвергали его пыткам, словно в фильме ужасов, и эта травма по сей день остается для него крайне мучительной.

На первую сессию Тони не явился и не предупредил меня. Через час после назначенного времени он написал,

что перепутал дни и что поручил Пеппер, своей личной секретарше, заниматься его встречами, чтобы избежать дальнейших накладок.

Мы встретились с ним на следующей сессии, но через пару недель он снова не пришел; вскоре после этого он написал мне, что забыл о встрече, так как в ту ночь не спал из-за кошмаров. Я ответил, что мы сможем поговорить об этом на следующей сессии, чтобы вернуть его к регулярным встречам. Через час я получил e-mail от Пеппер с сообщением, что нам придется перенести две следующие встречи.

Мне кажется очевидным, что секретарь выступает в качестве элемента сопротивления для пациента, чтобы он мог избежать неприемлемых для него отношений зависимости. Как только ситуация становится сложной или неопределенной, на сцене возникает Пеппер. Я хотел бы, чтобы она покинула поле боя, чтобы я мог поговорить с Тони напрямую об оплате, о пропущенных сессиях и прочих аспектах работы. Можете ли вы мне помочь?

**Лука:** Первый из возможных подходов — объяснить Тони, что важной частью работы является совместное управление всеми аспектами терапии между вами, в том числе теми, которые считаются бюрократическими. Такое соглашение было бы не поддающимся обсуждению предварительным условием лечения и частью того, что подпадает под критерий анализируемости пациента (Zetzel, Meissner, 1973; Etchegoyen, 1991).

Второе, не менее корректное, возможное решение — интерпретировать пациенту его сопротивление развитию отношений близости с незнакомым человеком, которому доверяется столько власти. Можно сказать что-то вроде:



*«Тони, я понимаю, тебе может быть тесно в отношениях, где нас только двое, в слишком близких отношениях. В прошлом другие люди эксплуатировали тебя, пользуясь своим положением. Однако столкновение со своими страхами — это необходимый шаг к преодолению твоих кошмаров».*

Понимаю, в качестве интерпретации это звучит слегка по-школьному, и такая интерпретация не в моем стиле. На самом деле, я думаю, что вербальная интерпретация поведения имеет интерпретативную функцию только в том случае, если пациент функционирует на эдипальном уровне. В противном случае она будет понята в соответствии с более примитивными кодами: как запрет, выговор или уступка (Nicoli, 2020). Пациент может понять, что какие-то вещи *не следует делать*, но глубинной причины этого понимать не будет. Такая интервенция рискует оказаться слишком смелой на столь раннем этапе отношений и может усилить у пациента потребность защищаться от аналитика, например путем прекращения сессии.

**Каппа:** Вы хотите сказать, что есть и третье решение?

**Лука:** Давайте представим, что Тони решил дать имя своей руке, которой он подписывает банковские переводы и электронные письма, и назвал ее Пеппер. Что в этом плохого? Это странно, я согласен, но не думаю, что это проблема, которую нужно решать с ним немедленно, как считаете?

**Каппа:** Вы, наверное, шутите?

**Лука:** Я предлагаю рассматривать Пеппер как персонажа аналитического поля, назначенного представлять Тони в его отношениях с внешним миром. В данный момент она необходима. Пациент настолько боится оказаться в отношениях близости с женщиной, что нашел

аналитика — тщательно выбирая из рекомендаций — на другом краю света и привел с собой третье лицо.

**Каппа:** Я понимаю, что любому запросу об аналитической помощи свойственна амбивалентность, но не заходит ли это слишком далеко? Если доверия нет ни на грош, разве такие отношения не обречены на провал? Мы рискуем лишь потерять время и лишит Тони надежды на перемены посредством аналитического лечения.

**Лука:** Если вы не хотите рисковать, чтобы не столкнуться с заведомым провалом, вам лучше сразу проверить Тони на анализируемость. В противном случае придется начинать анализ с неудобной и крайне необычной позиции, как в рассказе Ферро про пациентку, которая заняла его кресло вместо того, чтобы лечь на кушетку: «Я мог бы сделать тысячу вещей, предложить семь тысяч самых разных интерпретаций; но, не колеблясь ни секунды, я лег на кушетку, и так мы провели еще несколько месяцев анализа: она позади, в моем кресле, а я на кушетке» (Ferro, Nicoli, 2017, p. 122).

Речь о том, чтобы попытаться построить отношения, подходящие для Тони в данный момент, с учетом его нынешней способности предъявлять себя, чтобы ему не пришлось прибегать к чрезмерному искажению собственного селф. Конечно, важно, чтобы при этом вам не приходилось чересчур искажать свою профессиональную идентичность, потому что подражание Ферро или вашему супервизору означало бы отказ от вашей собственной аутентичности и спонтанности, что сильно отличается от частичной, питающей идентификации (Bolognini, Nicoli, 2022). Если вы чувствуете, что способны экспериментировать в таких условиях, вы можете продолжить работу вместе с Тони

и его секретаршей, наблюдая за возможными трансформациями персонажа Пеппер (Ferro, 2009).

**Каппа:** Мне вспоминается ваш рассказ о пациенте, который во время пандемии не хотел оставаться дома и участвовал в сессии, прогуливаясь по парку, или история о женщине, которая разговаривала по телефону из ванной комнаты, пока дети ждали ее в гостиной (Nicolì, 2021).

**Лука:** Все эти сцены и множество других, о которых мы с вами могли бы рассказать друг другу, показывают новые модальности встреч, ставшие возможными благодаря технологиям и расширению контекстов применения психоанализа. Если ребенок не может войти в кабинет, многие коллеги соглашались начать сессию в прихожей или на лестнице.

Что-то подобное можно попробовать с пациентами, которые не способны принимать слишком большую инаковость. Мы говорили об этом со Стефано Болоньини, который привел слова своего коллеги Дзаппароли: «Если во время сессии тяжелый психотический пациент хочет, чтобы мы были стулом, значит, мы должны быть стулом в этот момент». Перевод: если пациент, явно тяжелый пациент, не терпит, что вы по сравнению с ним одушевленное, отдельное, автономное существо или, еще хуже, что вы способны на него влиять, и если вы хотите, чтобы он был рядом и чтобы началась какая-то форма психического сосуществования, вы должны согласиться стать неодушевленным инертным объектом в его полном распоряжении (точно как стул), без амбиций протагонизма любого рода»<sup>8</sup> (Bolognini, Nicolì, 2022, p. 76). Такие ситуации побуждают нас принимать пациента там, где он пребывает,

8 Цитируется по книге: Фрейд и меняющийся мир. Психоанализ современности и его проблемы. Москва: Beta 2 Alpha, 2024. — *Прим. ред.*

и заставляют задуматься, насколько далеко мы готовы отойти от своих привычных координат, чтобы встретиться с ним там, где он *есть*.

## Соппротивление/существование<sup>9</sup>

**Каппа:** С тех пор, как мы вместе работаем, я понял, что в Италии всё функционирует по-другому, но мой супервизор сказал бы в этом случае, что это сопротивление и что его следует интерпретировать.

**Лука:** В случае с Тони выбор аналитика за океаном сам по себе говорит об очевидном сопротивлении, выраженном в подчеркнутой форме и подкрепленном использованием секретаря в качестве посредника, но в то же время здесь можно увидеть и надежду, поскольку бóльшая близость была бы для него немислимой.

Если рассматривать соотношение фигуры и фона, как в гештальт-изображениях вроде вазы Рубина (где наблюдатель может увидеть либо белую вазу, либо два черных профиля), то и сопротивление, увиденное с разных вертексов, приобретает совершенно разные значения. Соппротивления пациента воспринимаются как таковые, если мы исходим из представления об идеальной терапии: пациента, который не способен к свободным ассоциациям, отыгрывает, атакует сеттинг или терапевта, мы воспринимаем как доаналитического, сложного пациента. С такой перспективы сопротивление следует выявлять и интерпретировать как можно скорее.

Однако если мы поставим себя на место этого пациента, то увидим человека, который пытается коммуници-

ровать с помощью тех средств, которыми он располагает: действия, конкретный язык, проективные идентификации. В этом смысле сопротивление становится формой существования, единственной формой, в которой он может по-настоящему быть с кем-то вместе, защитой самой возможности аналитической встречи.

Как повторял наш болонский маэстро Джино Дзуккини, «пациент выполняет свою работу — быть пациентом!» Он злит нас, отдаляется, преследует, чтобы указать нам путь к своему скрытому «я», используя свои защиты как след из хлебных крошек, по которому мы можем идти за ним. Это пациент, которого нужно найти и в то же время надежно защитить (Winnicott, 1965; Ogden, 2018a), и мы должны с уважением отнестись к этой физиологической амбивалентности, если хотим, чтобы пациент позволил себе быть таким, какой он есть, а не просто реагировал на нас (Winnicott, 1963).

**Каппа:** На прошлой неделе Тони подключился к сессии из дома: был виден угол его гостиной, а позади Тони — картина с устрашающим роботом. Пациент довольно долго рассказывает мне, как сильно он занят, сколько он зарабатывает. Он хотел бы уйти на пенсию и посвятить себя бейсболу, своей страсти. Тони быстро пересказывает мне сон, в котором он сталкивается с главарем<sup>10</sup> банды, который... (этническая принадлежность Каппы). Потом он говорит, что посмотрел последний фильм про Железного человека: у того несокрушимые доспехи и лазеры гораздо мощнее, чем в предыдущем фильме. Я жду, слушаю его, в то время как он, не задер-

10 В итальянском главарь — *il capo*, фамилия его аналитика — *Карра*. — Прим. пер.

живаясь больше ни на сне, ни на фильме, рассказывает дальше.

Пока он говорит, он крутит в руках бейсбольную биту.

Он добавляет, что теперь путешествует меньше, чем делал это несколько месяцев назад, и потом умолкает. Я спрашиваю, каково ему дома, но, как обычно, ответа нет. Он никогда по-настоящему не отвечает. Тони рассказывает о своем прекрасном доме, полном предметов искусства: всё в его жизни просто потрясающе. Но это не анализ, и я понятия не имею, чем я тут занимаюсь. Чувствую себя просто ничтожеством, муравьишкой.

Мне кажется, Тони может уволить меня хоть сегодня. Собственно, как после каждой нашей встречи. Жду, что Пеппер отменит следующие встречи. Может быть, она прямо сейчас это и делает, пока мы с вами тут разговариваем. Иногда у меня появляется впечатление, что она убийца, готовая ликвидировать меня по приказу своего босса. Две недели назад она написала, чтобы отменить встречу, назначенную на следующую неделю. А в пятницу отменила ту, что должна была быть через две недели.

Для Тони зависимость означает разрушение, а Пеппер просто выполняет свою миссию. Скажите, Лука, какой во всём этом смысл?

**Лука:** Великолепно! Вы выдерживаете крайнюю неустойчивость терапевтических отношений, которые буквально висят на волоске — или даже на связи через Wi-Fi, — а это необходимое условие для того, чтобы можно было надеяться достичь в будущем близости.

**Каппа:** Я не знаю, смогу ли выдерживать дальше. Меня переполняет тревога, я боюсь провалиться, я предпочел бы покончить со всем этим... с терапией, разуме-

ется. И ведь все мои пациенты такие. Вот Энакин<sup>11</sup>, про которого я вам рассказывал, мальчик с РАС: его родители только и ждут, как бы от меня избавиться; Медуза, которая постоянно комментирует мою обувь и посещает бар напротив, из-за чего я чувствую себя преследуемым. Вы не понимаете: я боюсь, что не буду ощущать себя настоящим аналитиком и растеряю всех своих пациентов!

**Лука:** Я понимаю. Первые годы в нашей профессии бывают особенно трудными, потому что требуется время, чтобы ощутить, что наш метод лечения действительно влияет на психическое здоровье людей. А до этого приходится жить в сомнениях, тем более что у нас нет строгого протокола или инструкции, чтобы ей следовать.

С другой стороны, в таких ситуациях, как те, что вы описали, когда по разным причинам трудно совместно переживать отношения питающей близости, единственный способ очистить аналитическое пространство от ужаса, убийственной ярости, мщения и отчаяния — это выдерживать проективные идентификации, мишенью которых вы становитесь, и выйти из этого испытания живым.

Чтобы позволить Тони ощутить, что он может выжить в отношениях с другим мужчиной и не погибнуть при этом, аналитик должен стать не просто вогнутым, но микроскопическим, словно муравьишка, которому грозит опасность быть раздавленным бейсбольной битой, или убитым лазерами робота, или уничтоженным старательной секретаршей.

В данный момент ваша задача как аналитика заключается не в том, чтобы стать главным героем, который

11 Он же Дарт Вейдер, персонаж вселенной «Звездные войны», отец Люка Скайуокера. — Прим. пер.

блестяще умеет интерпретировать, а в том, чтобы контейнировать избыток насилия и ярости, прожить его и переварить. И для этого есть я, я играю роль алказельцера. В каком-то смысле я ваша секретарша. Сегодня нам нужно поддержать вашу способность сновидеть кошмары Тони (совершать бессознательную работу над ними) и, почему бы и нет, ваши страхи тоже: «придет психопат и разрушит меня навсегда». Тогда завтра вы сможете сосуществовать в очищенном пространстве.

**Каппа:** Хорошо, но как мне определить, происходит ли на самом деле эта бессознательная работа по контейнированию?

**Лука:** Неспособность Тони сновидеть, обрекающая его на травматические кошмары, которые не являются снами (Ogden, 2003), и на избегание любой близости в отношениях, уступила место начальной нарративной репрезентации. Вместе с ним вы сняли своего рода фильм, в котором стало возможным защищаться. Он делает это неосознанно, потому что роботизированные доспехи защищают его от страха встречи, в то время как вы чувствуете за вас обоих. Если б вы не чувствовали этого страха, это стало бы проблемой, потому что означало бы, что вы вооружились теорией и техникой против (переноса)<sup>12</sup> ужаса, который вызывает у вас безоружная близость.

Бион сказал бы, что в таком случае вы стали бы слишком Каппой, вместо того чтобы позволить себе стать<sup>13</sup> O<sup>14</sup>,

12 В оригинале *contro(-transfert)* — контр(переноса). — Прим. пер.

13 Бион под «стать другим» понимает способность быть как можно ближе к эмоциональному опыту другого.

14 Речь идет о бионовском понятии O, но обыгрывается схожесть с цифрой 0. — Прим. ред.



нулем, которым вы ощущаете себя сегодня. Иными словами, вы были бы слишком собой.

## Это не одно и то же

**Каппа:** Я понимаю, о чем вы говорите, но должен же быть какой-то предел проявлениям сопротивления, которые можно принять: хирург ведь не сможет устроить операцию в гараже! Точно так же психоанализ выработал проверенный десятилетиями теоретический аппарат и технический инструментарий, который гарантирует определенный контроль над непредсказуемым множеством переменных и бессознательных компонентов, задействованных в аналитическом процессе. Нельзя же постоянно начинать всё с нуля.

**Лука:** Наоборот, мучительная судьба аналитической сессии как раз в этом и состоит — в необходимости каждый раз начинать с нуля, или с О, понимаемого как предельная эмоциональная реальность (Bion, 1970; Grotstein, 2004).

Принять условия нестабильного и неустойчивого сеттинга, когда пациент может участвовать в сессии удаленно, из дома или из гостиничного номера, или находясь в другом часовом поясе, как и присутствие секретарши Пеппер, как и игру с бейсбольной битой по видеосвязи, — это совсем не очевидный выбор. Можно выйти за рамки знакомого и привычного сеттинга, чтобы добраться до пациента туда, где он находится, но это всегда риск.

Кроме того, терапевтом, как участником аналитических отношений, тоже управляют бессознательные мотивы, которые невозможно предвидеть заранее. Мы не хотим показаться недружелюбными? Не хотим фру-

стрировать пациента? Мы хотим особых отношений с этим пациентом, отступив от правил? Работа без памяти и прежде всего без желания — вот идеальный ориентир. Мы должны принять реальность наших желаний и смириться с тем фактом, что невозможно априори определить наши бессознательные побуждения. Наивно думать, что они не имеют особого значения.

Именно неопределенность переменной «бессознательное аналитика» принудила классический психоанализ довести принцип абстиненции до максимума, пусть и ценой восприятия его как ригидного. Мы можем на время оставить концепцию абстиненции за скобками, при условии, что впоследствии внимательно рассмотрим, что происходит в сессии, опираясь на такие понятия, как разыгрывание<sup>15</sup>, проективная идентификация и контридентификация, расширенный контрперенос. Мы должны принять тот факт, что мы игроки, лишь частично осознающие суть игры и практически не видящие ее глубинных процессов. Давайте забудем о позиции нейтральных судей.

Более того, даже неукоснительное соблюдение технических мер предосторожности, которым нас учили, не освобождает нас от необходимости постоянно сталкиваться с вопросом, как мы принимаем пациента. Сеттинг и техника не вечны. Уже несколько десятилетий мы обсуждаем возросшую нарциссическую хрупкость населения, а также тяжесть современных патологий, состояний внутренней пустоты и пограничных состояний. Вот почему то, как мы принимаем пациентов, ничуть не менее важно, чем то, что мы им говорим (Nicoli, Bolognini, 2022): истина, кото-

рую мы предлагаем в качестве пищи, становится таковой лишь в той мере, в какой она соответствует способности другого ее принять. Вот почему необходимо рассматривать встречу с учетом интересубъективных, реляционных и ин-терпсихических аспектов (Bolognini, 2004a; Nicoli, 2022).

Кроме того, социально-культурные рамки, в которых мы все существуем, меняются непрерывно, и сегодня быстрее, чем когда-либо, поэтому мы не можем относиться к протекающим в нас процессам как к чему-то неизменному. За последние двадцать лет способы общения по телефону и через мессенджеры изменились настолько, что в наши дни молчание аналитика в ответ на сообщения пациента, которое раньше рекомендовали многие преподаватели психоанализа, может быть воспринято пациентом как непонятная закрытость, а не как профессиональная и закономерная отстраненность. А сегодня, с распространением онлайн-терапии, рамки возможного сеттинга продолжают расширяться.

**Каппа:** Да, но тот факт, что пандемия благоприятствует дистанционной терапии даже здесь, у нас, не означает, что пациенты могут делать всё, что им вздумается, как ни в чем не бывало!

**Лука:** Меня заинтриговала ваша позиция. Мне кажется, вы отождествляете решение предоставить пациенту определенную свободу действий с игнорированием эмоционального и реляционного смысла происходящего. Я же думаю, что, наоборот, мы должны признать, что это *не одно и то же*.

Мы можем выходить за привычные рамки, но мы должны ясно понимать, что это не одно и то же, и важно помнить об этом предупреждении постоянно и сверяться с ним. Пеппер — это не Тони, с этим мы согласны, но то,

как мы воспринимаем этого персонажа и как используем его в аналитическом поле, имеет значение.

Если мы позволим этой защищающей фигуре стать чем-то само собой разумеющимся, пренебрегая коммуникативным значением сцены, мы в итоге сместим наш аналитический центр тяжести назад, потеряем равновесие: как утверждает Чивитарезе (Civitarese, 2018), если мы не можем вынести за скобки материальную реальность, всё становится плоским и бесплодным. Пеппер — это реальная секретарша из плоти и крови, и она представляет сопротивление, от которого следует избавиться.

Однако если не позволить таким пациентам проявлять себя с их предосторожностями, которые стали для них единственным способом выживания, мы практически оставим их за дверью или примем лишь частично. Но если же мы дадим Пеппер войти в поле, то сможем стать свидетелями ее постепенной трансформации.

## **Публичный образ, честь, достоинство и красота**

**Каппа:** Знаете, последние несколько недель происходит что-то странное: когда я общаюсь с Пеппер, я представляю, что говорю с Тони. Я поздравил ее с Новым годом, как если бы это был он. Должно быть, это как-то изменило ситуацию. Тони сказал мне, что ему уже три месяца не снятся сны. Он не назвал их кошмарами, как раньше.

На прошлой неделе Пеппер сообщила мне, что из-за длительной поездки встречи, назначенные на две ближайшие недели, отменяются. Так что во время сессии я сказал Тони, что получил сообщение от Пеппер, и знаете, что он

ответил? «Забудьте про секретаря, мы с вами встретимся, как договорились, я и вы».

**Лука:** Вы согласились на крайнюю асимметрию в отношениях, доверяя супервизии и аналитическому методу, и благодаря этому поле стало более проницаемым для новых трансформирующих нарративов. Вы легитимизировали существование Пеппер: вместо того, чтобы воспринимать ее как вторгающуюся в ваши отношения, как ошибку, которую нужно исправить как можно скорее, вы приняли ее как неизбежную составляющую ваших встреч. Именно благодаря этому принятию она стала не такой необходимой.

Легитимизировать состояния «я» пациента, которые он сам и его первичные объекты считают незаконными, неправильными, безумными или виновными, означает способствовать ощущению полноты его существования (Ogden, 2019). Пациент осознаёт, что у него есть право иметь телесные состояния, мысли и чувства как свои личные и подлинные, что ему не нужно проносить их контрабандой через расщепления, отчуждения или другие формы искажения идентичности.

Оставаться с Пеппер, не изгоняя и не интерпретируя ее, означает идти путем *лизиса*<sup>16</sup> защит, а не *кризиса* (Bolognini, 2015), пребывая в состоянии трансформирующего ожидания, как предлагает Винникотт (Winnicott, 1969). Так вы позволили Тони избавиться от какой-то части той мощной защиты, которую он возвел из-за ужасающей тревоги аннигиляции. Теперь он сможет начать признавать тот факт, что он является частью пары, и не испытывать при этом страха.

16 Медленное растворение бактерий под воздействием бактериофагов или антибиотиков. — Прим. пер.

**Каппа:** Спустя два месяца задержки Тони наконец-то оплатил мои услуги. Он спросил, получил ли я деньги. «Если не поступят в течение дня, — добавил он, — скажите мне!» Кажется, он хочет уберечь наши отношения от своих нарциссических защит. Наши отношения становятся терапией, и он это чувствует. Он начал рассказывать мне о своей семье, о которой раньше никогда не упоминал. Он сказал, что полностью прекратил общение со своей матерью после того, как однажды во время семейного обеда она поставила его в неловкое положение: спросила, не хочет ли он обезболивающую свечку от своей хронической головной боли. Это было слишком унижительно.

После этой сессии я ждал письма от Пеппер, и, конечно же, оно пришло незамедлительно: она отменила следующую сессию.

**Лука:** Когда Тони ослабляет свои защиты роботизированного супергероя, нарциссические по природе, ему приходится сталкиваться с опасностями, которые несет в себе близость: быть увиденным другими и, возможно, подвергнуться осуждению, презрению, зависти и насмешкам. Такие атаки на «я», именно в тот момент, когда человек наименее защищен и наиболее уязвим для стыда и смущения, приводят к «потере лица», лишают достоинства, изгоняют человека из его круга, если не из всего человеческого сообщества. Стыд, в отличие от вины, не предполагает искупления.

Сцена с семьей Тони ярко иллюстрирует эту угрозу в виде взламывания личных границ, посягательства на его *стыдливость*. Это слово, которое не часто используется в психоаналитической литературе, имеет огромное значение: оно указывает на совместно разделяемую за-

щиту близких контактов. Оно утверждает необходимость проявлять уважение к каждому человеку, к целостности его «публичного образа, чести, достоинства и красоты» (Zucchini, 2014, p. 377) и к его самым близким отношениям. Более того, без стыдливости не может возникнуть никакой близости, потому что само отсутствие защиты приводит к нарушению сакральности «я». Слово «сакральный» я использую в светском смысле, в знак глубокого уважения, которого заслуживает глубинная идентичность каждого человека. Речь идет о потребности быть признанным в своей подлинной сути, не выставляя ее на показ (Winnicott, 1963; Ogden, 2018b). Только из этого опыта тайны может родиться радость быть найденным (как в игре в прятки), быть вместе, радость от того, что другой видит тебя и сновидит тебя, — без страха при этом быть сожранным или искалеченным в контакте с объектом.

**Каппа:** Спустя несколько недель произошло кое-что необычное. Тони рассказал мне, чем он занимается, чтобы разбогатеть: всё такое грандиозное, он такой гениальный, и так далее. Сорок минут длился этот непрерывный поток слов и наконец иссяк. Тони огляделся и сказал: «Можно задать вам вопрос?» Я ответил, что он может спрашивать о чем угодно.

Он предупредил, что никогда раньше не задавал вопросов терапевту, а затем добавил: «Что, по-вашему, произошло за последние месяцы?»

Он напомнил мне ребенка, который никогда ничего не просил у родителей. Я сказал, что это серьезный вопрос и он заслуживает серьезного ответа. Мне не хотелось откладывать всё это на следующую сессию, поэтому я дал несколько обобщенный комментарий: «Могу

сказать, что кое-что изменилось: что-то успокоилось. Вы стали больше спать, кошмаров стало меньше».

«Это правда», — сказал он серьезным голосом.

«Знаете, — добавил я, — иногда просто нужно немного времени».

«Окей, — задумчиво заключил он, — увидимся в пятницу».

Я возразил: «Я знаю, что вы не придете...».

«Нет-нет, я приду».

**Лука:** Когда Тони смог испытать аналитическую близость, он позволил себе отказаться от всемогущества и всезнания. Он стал человеком, чтобы не быть одиноким богом. И в таком качестве он обратился к объекту, задав о себе вопрос, рискуя быть осмеянным, обвиненным или отвергнутым. Переход от нарциссического измерения к более объектному стал легче благодаря чувству близости, которое Тони постепенно смог испытать с другим человеком, гибким, с умеренной субъектностью (Fabozzi, 2019).

Другой решающий аспект в этом переходе к более полной близости в отношениях — это *ход времени*. Нарциссический пузырь существует, как правило, вне временных рамок, потому что без вклада извне индивид склонен к поддержанию гомеостаза. Именно отношения с другим, с их постоянной прерывностью и совместным участием в процессах субъективации, способствуют восприятию «до» и «после», прошлого и будущего. Объект отражает нас, помнит о нас, сновидит нас в нашем становлении. Сближения, отстранения, угрозы оставленности, вмешательства превращают близость в место встречи, которое непрерывно переопределяется эмоционально, что позволяет нам писать роман собственной жизни благодаря по-



стоянной связи с другими. «Я могу ощущать себя живым только в чьих-то глазах, — пишет Чивитарезе. — В этих глазах я должен отражаться так, чтобы я мог почувствовать себя счастливым, по сути — любимым» (Civitarese, 2018, р. 132).

## Враги близости

**Каппа:** На одной из последних сессий Тони рассказал, что у него сильно болела голова, но он не смог найти врача, который бы его принял, и поэтому он хотел бы, чтобы у него был доктор, доступный в любое время.

Я ответил ему несколько неожиданно для самого себя: «То, что я сейчас скажу, может показаться немного странным, но мне пришло в голову, что, возможно, помимо более доступных врачей вам хотелось бы также, чтобы мы с вами встречались чаще, чем раз в неделю». Представьте мое удивление, когда он отреагировал так: «Если б вы ничего не сказали, я, возможно, сам бы сказал что-то в этом роде через несколько месяцев. Иногда мне кажется, что между сессиями проходит слишком много времени, и было бы лучше, если б мы могли пойти глубже».

Он хотел, чтобы я сразу же подобрал время для еще одной встречи, но вместо этого я предложил ему всё обдумать и не спешить с воплощением этой идеи в реальность. Мне не хотелось, чтобы наши сессии стали одним из тех желаний, которые можно немедленно исполнить за деньги. Я решил, пусть у него будет время просто побыть со своим желанием.

**Лука:** Но вы сами хотели бы встречаться с ним дважды в неделю?

**Каппа:** У меня нет свободных часов, и даже если бы я постарался кого-то перенести, чтобы найти время, это потребовало бы от меня слишком сильного напряжения. Не знаю, готов ли я работать с Тони интенсивнее, чем сейчас.

**Лука:** Кажется, мы пришли к тому, что перевернули изначальный вопрос с ног на голову: *а как насчет анализируемости самого аналитика?*

Я имею в виду, что и Пеппер, и защитные стратегии избегания, к которым прибегал Тони, чтобы держаться подальше от переживания близости с вами, защищали вас обоих. Так что говорить об анализируемости, с определенной точки зрения, значит указывать на ограничения данного аналитика относительно его способности сосуществовать с пациентом внутри труднопроходимых ситуаций.

Враги близости вездесущи: страх перед жадным стремлением к обладанию со стороны пациента, который регрессирует и боится быть покинутым; истощение, вызванное постоянной угрозой прекращения сессий пациентом; эдипальные и/или гомосексуальные фантазии соперничества, которые пронизывают аналитические отношения более симметрично, чем нам бы хотелось. Подобное непрерывное переплетение эмоциональных состояний протагонистов аналитической сессии столь неразделимо, что объясняет современный интерес к реляционным, интерсубъективным и полевым моделям, которые помещают в центр внимания всю сложность встречи, а не вклад каждого из двух индивидов. Более того, сам термин «индивид», в латинском корне которого есть отсылка к *не-делимому*, подвергается радикальному сомнению со стороны мульти-

персональных вертексов, задействованных в этом процессе: сколько Каппы, сколько Тони, сколько интерсубъективного третьего (Ogden, 1994), сколько персонажей, порожденных перекрестными проективными идентификациями, содержится в *вашем* страхе перейти на две сессии в неделю?

Аналитик, испытывающий глубокую и контейнирующую близость со своим пациентом, переживает частичное лишение себя собственной индивидуальности, как будто он перестал быть собой в этот момент, чтобы «стать» тем, кем пациент не способен сейчас стать в полной мере.

В этой паутине аффективных нитей полезно возвращать себе богатство собственных ощущений, интуиции, *rêverie*, а также обращать внимание на сигналы, которые посылает само аналитическое поле, чтобы восстановить чувство «я» и одновременно осветить препятствия, мешающие свободной циркуляции эмоций в аналитическом кабинете.

**Каппа:** Сразу же после того, как мы поговорили с Тони о возможности второй сессии в неделю, когда я сказал ему, что мы можем подумать об этом, он поведал мне о своем младшем брате: «Знаете, я тут говорил с братом, и он почему-то считает, что я его конкурент. Конечно, это не так, но как-то раз он сказал, что я будто бы чувствую себя подавленным его успехом. А я рассказал ему о выходных, которые хотел бы провести с ним вместе». Это один из тех сигналов, о которых вы говорите?

**Лука:** Вот наглядный пример того, как возрастает ассоциативная проницаемость поля и улучшается сонастройка между вами. Ассоциация пациента об отношениях с братом выступает здесь как GPS-индикатор вашего положения в аналитическом поле (Civitarese 2005; Ferro, 2009;

Levine, 2013). Тони сигнализирует о существовании конфликта — хотя и отрицает его, — конфликта, с которым предстоит столкнуться. Он намерен выделить время для пребывания вместе, тем самым неявно признавая, что длительные отношения начинают становиться для него не только выносимыми, но и полезными для осуществления эмоциональных и реляционных трансформаций.

Близость, понимаемая как защищенное и защищающее реляционное измерение, способное контейнировать и стимулировать наиболее аутентичные и выразительные для «я» эмоциональные обмены, как сознательные, так и бессознательные, перестает быть пространством потенциального злоупотребления, от которого нужно защищаться. Это преимущественно дуальное состояние — и я согласен здесь с Луизой Мазина (Masina, 2018), — в котором оба участника готовы к опыту сно-видения, не слишком обращены во внешний мир и доверяют друг другу. В аналитической паре, опирающейся на такое доверие, «мы» может становиться всё более устойчивым опытом совместного обогащения, субъективации и удовольствия.

## Выводы

В современной клинической практике, где приходится иметь дело с репрезентативными пустотами, поврежденными контейнерами, с отношениями, полными недоверия и нарциссизма, пациенты далеко не готовы к объектным и символическим отношениям. Если мы не хотим ограничиваться поверхностной, снисходительной и неэффективной терапией, нам необходимо помочь им со-

прикоснуться со своим глубинным «я», которое справедливо не желает быть выставленным напоказ.

Постепенная сонастройка наиболее ценных и подлинных сторон пациента и аналитика требует создания и постоянного поддержания интимной области взаимодействий — эксклюзивной, безопасной и проницаемой для психического и эмоционального обмена. Мы можем использовать имеющийся теоретический и технический инструментарий, чтобы помочь пациенту быть самим собой, не принуждая его к искажению своей идентичности ради участия в анализе. Это предполагает постоянную работу самоанализа, слушания и рефлексии над самим собой. Аналитик должен модулировать свою субъектность в сессии, свою объектную инаковость, должен брать на себя роль среды, функции, места в поле; должен выдерживать дискомфорт или страх перед слишком большой или слишком малой дистанцией по сравнению с той, к которой он привык; должен принимать регрессировавшие и конкретные функционирования до тех пор, пока не станет возможным наблюдать их эволюцию.

Эти болезненные, пугающие и дезориентирующие процессы — необходимое условие для того, чтобы воплотить в жизнь знаменитую рекомендацию Огдена (Ogden, 2005, р. 6 [с. 18]): *заново изобретать психоанализ для каждого пациента*. Чтобы этот призыв не звучал как модная и бессмысленная фраза, мы должны быть готовы отказаться от некоторых наших клинических убеждений и привычек, принимая моменты страдания и смятения. Это психоанализ, готовый принять частичные утраты и последующее возрождение, не искажая своей человеческой, когнитивной и терапевтической ценности.

# Близость и ее интерпсихические эквиваленты

*Стефано Болоньини*

Институциональные вопросы влияют на научное развитие дисциплины чаще, чем принято считать.

Вот уже несколько десятилетий одной из традиционных привилегий президента Международной психоаналитической ассоциации (IPA) является выбор темы конгресса IPA. И поскольку в ходе Конгресса 2017 года в Буэнос-Айресе эта честь выпала мне, после тщательного изучения современных тенденций в психоанализе я решил предложить тему «Близость», чтобы ее можно было исследовать и рассмотреть на международном уровне.

Сегодня я могу утверждать, что это был удачный выбор: не только из-за количества и качества представленных работ, но также из-за страстной вовлеченности, которую вызвала эта тема у участников. Предложенная тема высветила (и сделала предметом размышления) глубоко

разделяемое реляционное измерение, которое характеризует значительную часть современного психоанализа и которое постепенно интегрируется в классическую парадигму инстинктов.

Приведенные далее размышления основаны на замечаниях к моему вступительному докладу и тесно связаны с интерпсихической областью.

## Близость

Этимологические корни — это древние хранилища смысла, и их изучение всегда обогащает и проясняет мышление аналитика.

Слово *близкий*<sup>17</sup> происходит от латинского корня *intra* («внутри»). *Intimus* («самый внутренний», или «глубочайший») — это превосходная степень от *internus* («внутренний»), а *interior* («более внутреннее по сравнению с чем-то другим, но не самое внутреннее») является сравнительной формой.

Близость — это реляционное измерение, в котором внутренние миры людей могут коммуницировать друг с другом на *физиологическом* уровне, обмениваясь содержаниями, чувствами и мыслями. Младенцы с самого момента рождения испытывают всепоглощающую потребность во взаимообмене (телесном и психическом) с кем-то, кто может дать им всё необходимое для жизни и роста.

Физиологическая фаза слияния, прототип близости, является основополагающим этапом в отношениях матери и ребенка, абсолютно необходимым первичным опытом, который формирует способность к отношениям

17 В оригинале английское слово *intimate*. — Прим. пер.

и организует устойчивые и глубоко витальные состояния селф.

Мы заново открываем и воссоздаем условия, эквивалентные этому постепенному переходу от отношений *внутри матери* к *вместе с матерью*, на многих этапах терапевтического процесса, однако ключевое значение этих этапов не всегда получает должное признание как в клиническом, так и в теоретическом контексте.

На самом деле термины *симбиоз* и *слияние* (Mahler, 1968, 1972) до сих пор упоминаются в психоаналитической литературе преимущественно в патологическом ключе, главным образом в связи со спутанными, фиксирующими, паразитическими и более или менее скрытыми манипулятивными проявлениями; они не рассматриваются в физиологическом смысле (Pallier, 1990; Bolognini, 2002, 2008a; Fonda, 2000; Bonfiglio, 2018), то есть в отношении здоровых и необходимых, конституирующих и основополагающих аспектов, которые соответствуют потребностям развития и формируют специфическую структуру субъекта, его внутреннее наследие.

На теоретическом уровне комплексную и сбалансированную позицию, включающую различные потенциально позитивные (= необходимые) и негативные (= фиксирующие) аспекты слияния, выдвинул Пайн (Pine, 1990, р. 245), который в открытой формулировке охарактеризовал симбиотическую фазу как «критическое время для формирования тех моментов слияния (связанных с кормлением и засыпанием, когда младенец растворяется в теле матери), которые происходят в первые месяцы жизни».

Даже сегодня в некоторых клинических отчетах внимание уделяется не тому, что этот опыт слияния в свое время



не был полноценно пережит и поэтому способность должным образом его переживать во взрослом возрасте отсутствует; скорее, подчеркивается тот факт (который в большинстве случаев является очевидным следствием), что этот опыт ищут снова и безуспешно, с одержимой настойчивостью и способами, не соответствующими взрослому состоянию, как это часто проявляется — непреднамеренно — во многих тяжелых случаях психических расстройств.

На практике эта аномальная настойчивость в неуместном и тревожащем стремлении к слиянию иногда рассматривается в клинике скорее как проблема *сама по себе*, чем как признак лежащих в ее основе и существовавших ранее проблем, почти как если бы классическая психиатрическая феноменология брала верх над более комплексным психоаналитическим пониманием. Из-за этого возникают неблагоприятные ситуации, когда аналитик предполагает, что должен *заставить пациента понять* на логическом уровне Центрального Эго то, с чем ему следовало бы помочь пациенту вновь войти в контакт, прожить и хотя бы немного проработать репаративно на уровне переживания Селф.

В большинстве случаев подчеркивание нарушенного функционирования эго во время сессии лишь усиливает страх пациента перед самим собой и вызывает у него страх и гнев по отношению к терапевту, что ведет к последующему застреванию и дальнейшему нарушению работы эго, и так далее.

Поэтому в данной главе я хочу обратить внимание на реляционную *среду*<sup>18</sup>, в которой происходит большин-

18 В оригинале — *medium*. — Прим. пер.

ство эффективных аналитических обменов: на терапевтическую ситуацию, поддерживаемую регрессией, особенностями сеттинга и самим ритмом аналитической работы, ситуацию, которую мы называем «близостью» и которая закладывает основу для глубоких изменений во внутреннем мире и способе бытия наших пациентов.

Близость проистекает из нашего внимания к отношениям в той же мере, что и к влечениям. И особая компетенция аналитиков состоит именно в том, чтобы *распознавать — а где возможно, интерпретировать и прорабатывать —* глубинные соответствия, существующие *между влечениями, фантазматическими и реляционными элементами*, соответствия, которые неспециалисту трудно различить.

В отличие от других терапевтов, психоаналитики не сосредоточивают внимание исключительно на внешнем поведении и выразительных реакциях и не ограничиваются рассмотрением социальных феноменов или абстрактных концепций, как это свойственно социологам или философам. Работа с внутренней реальностью наших пациентов предполагает также глубокий и потенциально творческий контакт с нашей собственной внутренней реальностью и с общим для нас полем, которое мы создаем совместно с другим в процессе лечения (Baranger, Baranger, 1969; Ferro, 1994, 1995).

На мой взгляд, *то, как мы это делаем*, составляет суть самых вдохновляющих современных разработок в психоанализе.

Как постепенно становится важнее, чем *что*: объекты нашего исследования (бессознательные фантазии, воспоминания, страхи, потребности и желания) имеют

решающее значение в анализе; но *сложный путь*, с помощью которого мы можем добраться до них, обнаружить, вступить с ними в контакт, совместно прожить, переработать, репрезентировать и трансформировать их в аналитическом взаимодействии с нашими пациентами, сегодня имеет большее значение, чем когда-либо прежде.

То, как заботящийся взрослый обращался с младенцем, интрапсихически определяет и формирует первоначальный досубъектный и затем субъектный опыт человека, соответствующий впоследствии способу, которым эго будет вступать в контакт и обращаться с селф на протяжении всего своего существования.

Именно *способ*, пожалуй даже больше, чем содержание, во многом определяет различия между школами, стилями и техниками, которые сегодня сосуществуют и совместно участвуют в нашем общем научном, профессиональном и образовательном пространстве.

Помимо всех теоретических различий, близость, по сути, является измерением, которое рано или поздно характеризует большинство аналитических методов лечения: измерение, в котором основные функции, такие как постоянство объекта, контейнирование, холдинг, отражение, питание, совместное проживание опыта, рефлексия, взаимное признание, признание ценности предсознательного творчества и потока свободных ассоциаций, интерпретация и множество других, могут постепенно осваиваться и применяться.

Почти в каждом анализе достигается символическое соответствие ранним фазам первичных переживаний, это касается и формы отношений, и качества обменов.

Телесные обмены между внутренними мирами включают двунаправленные движения и переходы *изнутри наружу и извне внутрь*: эти взаимообмены могут быть питающими, эвакуационными, генитальными, они включают признание желания, потребности, функционального сопряжения на разных уровнях, оплодотворения, трансформации и так далее.

Этот витальный способ интимного взаимодействия продолжается на протяжении всего нашего существования, частично трансформируясь в повседневной жизни в постоянном скрытом и глубоко бессознательном поиске психических эквивалентов того, что было телесным на досимволических этапах развития; или наоборот, в попытке заменить недостающее (и в отношениях, и в чувстве селф) конкретными элементами в настоящем, в ходе внутреннего обмена с другим.

Психоанализ, помимо всего прочего, — это наука, которая изучает, истолковывает и порой использует эти процессы на интрапсихическом и интерпсихическом уровнях.

На самом деле люди всю свою жизнь ищут близости — более или менее конфликтным способом. Мы наблюдаем это в повседневном взаимодействии, слышим в текстах практически каждой песни, сталкиваемся с этим в драматической и напряженной форме в нашей клинической работе, когда потребности и защиты проявляются и постоянно конфронтируют друг с другом, колеблясь между открытостью и закрытостью, приближением и отдалением, контактом и отстранением.

Люди постоянно создают и разрушают *случайные микросимбиозы или слияния* — как правило, даже не подозревая об этом, — используя свои более или менее разви-

тые навыки для организации потенциала психического сопряжения на разных уровнях.

Как бы то ни было, им необходима некоторая доля совместно испытываемой близости, чтобы питать, насыщать кислородом и возрождать свой внутренний мир всё новыми способами; хотя часто они склонны сознательно отрицать эту потребность, особенно когда их структура защит направлена в сторону фантазий всемогущей самодостаточности, а также нарциссических антиобъектных внутренних установок (как это бывает, например, при анорексии или нарциссических расстройствах личности).

Естественное развитие обеспечивает наличие *проходов извне внутрь (и наоборот)*, образованных особыми тканями — *слизистыми оболочками*, функция которых — создавать промежуточную среду, в которой обмены могут происходить свободно, а вещества — без промедления переходить от одного субъекта к другому, при условии, что такой обмен желателен и принимается обеими сторонами.

Мой вклад в эту область состоял именно в выделении *психических эквивалентов этих межтелесных процессов* и их рассмотрении в контексте психоаналитического процесса, с неизбежными последствиями для теории техники.

Хочу обратить внимание: здесь мы оказываемся в контексте событий, которые выходят за пределы (хотя и важной) сферы привязанности, *поскольку речь идет именно об обменах внутренними содержаниями*.

Здоровая близость — это естественное измерение глубокого интерпсихического обмена в совместно проживаемой атмосфере, в которой каждый человек может

научиться чередовать первичные и вторичные процессы без страха или стыда, регулируя собственную регрессию в согласии с внутренней динамикой другого.

*Аналитик занимает идеальную позицию в интерпсихическом «пространстве», которое можно уподобить «слизистым оболочкам»: там, где интерпретации, акценты, конфронтации и (вербальные) взаимодействия могут оказаться полезными или вредными, действенными или бессильными, приемлемыми или недопустимыми, в зависимости от индивидуальных бессознательных интрапсихических предпосылок и того, как отношения развиваются в различных ситуациях; там, где переходы из «внутреннего» одного во «внутреннее» другого могут фактически открываться или закрываться, освобождаться или блокироваться, течь или пересыхать и застыть — независимо от сознательных намерений и теоретических убеждений аналитика.*

Конечно, нет никакой гарантии, что «близость» как таковая всегда означает что-то хорошее, учитывая возможность ее использования откровенно деструктивным или втайне извращенным образом, который может нанести вред или разрушить одного из участников или даже обоих. Обладание ключом, открывающим доступ к внутреннему миру другого, может привести к множеству различных открытий, процессов и результатов в зависимости от качества влечений двух субъектов и реального качества их внутренних объектных отношений.

Следовательно, существует риск того, что, достигнув определенной степени близости, аналитик может злоупотребить своей властью, пытаясь навязать пациенту преждевременную или неприемлемую для его психики

интерпретацию, скорее из лояльности к «ученому» Идеалу или супер-эго, чем из стремления настроиться на взаимную интонацию, учитывающую потребности и возможности самого пациента.

Такое может произойти в терапии, если естественный *эдипов треугольник* «Аналитик — Теория — Пациент» оказывается разбалансированным: например, когда пара «Аналитик — Теория» эквивалентна властной и исключаяющей родительской паре, что может препятствовать естественной близости между аналитиком и пациентом; или с *чрезмерно инцестуальной и симбиотической парой* «мать — ребенок / Аналитик — Пациент», где для Третьего/теории остается мало места или не остается вовсе, что приводит не столько к близости, сколько к переизбытку слияния и, как следствие, к промискуитетной спутанности.

На противоположном полюсе находится абстрактный идеал научной, *объективной* отстраненности (той самой *froidueur*<sup>19</sup>, которой желала и которую, возможно, даже рекомендовала Лоранс Кан (Kahn, 2014)), призванной защищать аналитиков от чрезмерной внутренней включенности, но способной помешать им откликаться как обычным целостным человеческим существам при контакте (или порой столкновении) с с многомерной сложностью внутреннего мира пациента.

Существует предел, за которым (само по себе похвальное) стремление к объективности вырождается *tout court*<sup>20</sup> в бессознательную защиту субъективности; так же

19 В пер. с фр. «холодность». — Прим. пер.

20 Французское выражение *tout court* означает «просто», «без всяких оговорок», «в прямом смысле». — Прим. пер.

как избыток субъективности, наоборот, может искажать понимание реальности.

Тем не менее мы знаем, что аналитические отношения ни в коем случае не являются нормальными человеческими отношениями из-за регрессии переноса у пациента и в связи с нашими собственными терапевтическими полномочиями и ответственностью.

Наша способность симметрично со-испытывать субъективность пациента, разделять (где необходимо) его состояния селф, частично становясь на его место, требует от аналитика четкой и устойчивой асимметричной внутренней позиции, которая остается открытой как для согласия, так и для взаимодополняемости, чтобы пациент мог проявлять свои внутренние сценарии в безопасных и творческих отношениях. Точно так же мы в том числе обязаны учитывать и исследовать опасности ложной, сбивающей с толку или потенциально разрушительной близости.

Как бы то ни было, можно утверждать, что без кропотливо выстроенной адекватной интерпсихической близости реальные изменения едва ли возможны, и анализ рискует остаться исключительно интеллектуальным упражнением, действующим лишь когнитивную деятельность коры мозга.

Однако замечу, чтобы не возникло недопонимания: меня интересует интимность так же, как интересовали эмпатия и *rêverie*; но я критически отношусь к *интимизму*, так же критически, как относился к *эмпатизму* и как отношусь теперь к потенциальному «*реверизму*».

Это имитационные научные вырождения, и любая попытка преднамеренно и деятельно создавать близость



обречена на провал, точно так же, как это произошло с эмпатией и *rêverie*.

Можно сказать, что мы не способны *решить* быть близкими: всё, что нам остается, это согласиться начать предположительно длительное и технически сложное психическое сосуществование с как минимум проблемным собеседником, опираясь на нашу выработанную способность к интеграции (прежде всего на уровне нашего *Профессионального Селф*) и на научную компетентность (прежде всего на уровне *Профессионального Эго*), чтобы пройти этот путь.

Но мы также знаем, что, как и в любом путешествии, постоянное психическое сосуществование рано или поздно приведет нас к некой форме близости. Готовы ли мы и действительно ли открыты для этого утонченного приключения в отношениях, выходящих за рамки наших абстрактных и порой противоречивых идеалов?

В конечном счете, так же как эмпатия и *rêverie*, близость в анализе не может возникнуть по команде или по теоретическому указанию: обычно для этого требуется соблюсти ряд условий, которые кажутся простыми, но на самом деле весьма сложны, а также проделать совместную работу по созданию таких условий там, где они отсутствуют.

Кроме того, необходимо, чтобы хотя бы один из участников имел ранее непосредственный опыт интерпсихической близости в обычной жизни: теория мало что даст, если аналитик в личной жизни или в ходе профессиональной подготовки не испытал на себе в достаточной мере понимания, как и когда становится возможным переход чего-либо из внутреннего мира одного во внутренний мир другого.

## Основной пример психического эквивалента телесного состояния в анализе

Таблицы питания указывают, что ребенок любого возраста должен ежедневно получать определенное количество белков, жиров и углеводов.

Психоаналитическая техника, которая сильно различается от одной школы к другой, предлагала разные подходы к интерпретациям. За последние десятилетия многое изменилось, но трудно забыть некоторые известные случаи, когда пациентам давали интерпретации скорее на основе теоретических убеждений аналитика, чем исходя из его настройки на потребности, желания и защитную организацию пациента.

Выражаясь в эквивалентных терминах, в этих случаях от внутреннего ребенка ожидалось, что он будет *есть, даже когда не голоден*, даже если у него несварение или, еще хуже, болит живот (то есть даже тогда, когда он всё еще слишком перегружен и встревожен непереваренным внутренним содержимым, которое не может ни усвоить, ни эвакуировать).

В целом в некоторых супервизиях или клинических дискуссиях всё еще нередко встречается тенденция выносить суждение вроде «здесь отсутствует интерпретация», вместо того чтобы оценить, были ли созданы условия, чтобы предлагать ее пациенту.

Например, в отдельных супервизионных случаях очевидно, что аналитик, недостаточно знакомый с эвакуационными потребностями пациента (часто столь неблагодарными для чувства селф аналитика, поскольку

оно подвергается атаке и обесцениванию), склонен их обходить; и что он чувствует себя «аналитиком» только тогда, когда может сформулировать и применить свою интерпретацию (с уверенностью, что совершил ритуал правильно, подобно некоторым матерям, которые бездумно следуют таблицам питания, не учитывая сложного внутреннего состояния ребенка).

Принудительное введение содержания (например, интерпретации-суппозитория) в другого может быть эквивалентно телесному акту, который иногда является неуместным, а в отдельных случаях даже насильственным: оно не создает ничего *интерпсихического*, а скорее нечто *транспсихическое*, что может серьезно отдалить субъекта от какой-либо веры в то, что он способен разделить близость.

То же самое происходит на генитальном уровне при принуждении партнера без его желания, а тем более в случае изнасилования (*фаллос/штык*; Bolognini, 2014).

От аналитиков требуется понимание непрерывного глубокого потока *символической эквивалентности между телесным и психическим*, постоянная подстройка под него в ежедневном близком взаимодействии. Тогда они смогут избегать конкретизма символической эквивалентности и развивать совместную компетентность в распознавании того, *голоден ли (внутренний) ребенок, болит ли у него живот* и так далее. Таким образом, они заботятся о потребностях пациента, насколько это возможно, до тех пор, пока желание не проявится наконец в жизнеспособной, менее драматичной и острой форме.

## Патологическая близость

Говоря о глубоких взаимопроникновениях (выражение, которое так же легко вызывает как волнующие грезы о сексуальных контактах, так и другие идеализирующие и искупительные фантазии), следует помнить, что речь совсем не обязательно идет о чем-то хорошем, витальном и творческом: мы, например, знаем, насколько прочные и стойкие связи способны возникать в садомазохистических отношениях и как трудно их бывает разорвать.

Одна из проблем, с которой психоаналитики относительно часто сталкиваются в ходе лечения, на самом деле касается распознавания здорового или патологического характера связи: если на противоположных полюсах спектра отношений характеристики связи и тип близости достаточно легко распознать как витальные или разрушительные, то посередине располагается обширная *серая зона*, и ее гораздо труднее считывать и понимать.

Я имею в виду, например, все те отношения, которым свойственны высокая степень привязанности и привычная рутина, организованные вокруг конкретного совместного сосуществования, но в которых при этом не наблюдается ни значимого обмена внутренними содержаниями, ни взаимных трансформаций: отношения, в которых есть соприкосновение, но нет настоящего открытия внутренних каналов.

Если выразить это в телесных терминах, которые можно естественным образом перевести в их психические эквиваленты, то речь идет о следующем: это *соприкосновение «кожных покровов»*, где, однако, *«слизистые оболочки» внутренних отверстий остаются закрытыми*

*или пересохшими*; то есть сосуществование присутствует, но каждый остается внутренне *закрытым*. Может происходить *контакт*, но не *взаимообмен*. Присутствует привычная фамилльярность, но не близость в этимологическом смысле слова.

Многие браки, возникшие из страха перед одиночеством и одновременно наполненные страхом внутреннего контакта, устроены таким образом: это стерильные<sup>21</sup> психофизические союзы, в которых эквивалентность телесного и реляционного проявляется всецело и последовательно.

Аналитическим эквивалентом таких отношений является анализ, в котором пациент регулярно посещает сессии, говорит, рассказывает истории и вроде бы ассоциирует, но... абсолютно ничего не происходит! И такой анализ может тянуться годами, пока между пациентом и аналитиком не произойдет что-то, что откроет доступ к внутренним каналам — то есть к настоящей близости.

Формальная связь есть, но это не связь по своей сути (в буквальном смысле передачи физических или психических субстанций); *есть привязанность, но нет взаимодействия*.

«Внутреннее» остается исключенной и неприступной областью, а отношения — межличностными, а не интерпсихическими.

## Близость... о чем это?

Многие люди склонны ассоциировать термин «близость» главным образом с некой волнующей, эротической близостью.

21 В оригинале *white* (англ. — «белый»): брак, из которого изъяты сильные эмоции, страсть, конфликты, брак, лишенный окраски. — Прим. пер.

стью, что не обязательно верно ни по отношению к данной области, ни по отношению к глубине задействованных эмоций.

Однажды пациент рассказал мне о чувстве тревожного напряжения, которое не мог связать ни с одной разумной причиной.

Это довольно агрессивный, нарциссический мужчина, он с гордостью сопротивляется спонтанному контакту с любыми своими внутренними установками, которые не являются достаточно фаллическими. Тем не менее мы с ним знакомы уже много лет, неоднократно работали вместе в анализе, и в целом он опирается на мою уважительную близость. Позвольте также добавить, что он знает, что салфетки лежат на полке возле кушетки.

Я знаю, что он понимает, что я готов связать его нынешнее эмоциональное состояние с нашей предстоящей летней разлукой (сейчас июль), но я не собираюсь говорить об этом, поскольку чувствую, что в данный момент это прозвучит слишком очевидно и «как по учебнику», хотя я на самом деле думаю, что в этом есть некая правда. Через некоторое время ассоциации приводят его — я бы сказал, помимо его воли — к мыслям о смерти родителей, которых не стало несколько лет назад, особенно о смерти отца, с множеством конкретных воспоминаний о том дне и сильным эмоциональным откликом.

Пациент плачет и берет салфетку с полки. Я что-то произношу, чтобы показать ему, что я его понимаю. Пациент теперь открыто позволяет себе плакать и вытирает глаза салфеткой.

Это глубокий интерпсихический и интрапсихический переход, который несколько лет назад был бы невозможен.

Напряжение ушло.

Я понимаю, что можно поспорить, следует ли рассматривать приближающуюся летнюю разлуку с аналитиком как главный факт (а воспоминание о смерти отца — как своего рода защитное смещение от нашего текущего реляционного события), или же считать летнюю разлуку фактором переноса, создающим более значимую связь с чем-то еще более глубоким и важным для этого человека.

Здесь я лишь хочу подчеркнуть, что близость — это совместно создаваемое и создающее состояние, которое характеризует эту сцену, где *здесь и сейчас, там и тогда и везде и всегда* сосуществуют и взаимодействуют в безвременности анализа.

## **Близость и либидинальные узы: между фиксацией и преданностью**

На протяжении нескольких лет, исследуя человеческие отношения, я предпочитаю начинать с того, что работает достаточно хорошо, а не с патологии, и потом уже постепенно и трезво приближаться к контакту с болезненными областями разных ситуаций.

Опираясь на этот критерий, мне удалось обнаружить для себя один вроде бы очевидный, но всё же не полностью, аспект: в отношениях, где возникает близость, обычно легче установить стабильную связь.

Однако, как я уже говорил, взаимопроникновения могут происходить и в садомазохистических отношениях,

создавая исключительно прочные связи, которые нелегко разорвать.

Это также не означает, что близость сама по себе гарантирует связь, поскольку нам хорошо известны бесконечные реактивные переживания противостояния, атак на связь и отказа от взаимозависимости, что зачастую свойственно для проблематичного характера (и соответственно, проблематичных отношений) многих людей.

Тем не менее близость, которая открывает доступ к более глубоким областям Селф (в терминах телесной/психической эквивалентности), обычно создает исключительно благоприятные условия для установления устойчивых и эмоционально насыщенных отношений между теми, кто эту близость разделяет. То же самое происходит между матерью и ребенком, между партнерами в паре и — надеюсь, сравнение никого не шокирует — между собакой и ее хозяином, когда психическое сосуществование является прочным, постоянным, значимым и взаимовыгодным.

Народная традиция всегда культивировала обычай ритуального совместного совершения некоторых основных естественных действий (совместный прием пищи, питья, совместное пение, размещение гостей под одной крышей и так далее), что символизировало установление объединяющих дружественных отношений, предшествующих близости. Совместное выполнение этих конкретных действий олицетворяет совместное открытие внутренних каналов и создание регулируемых условий слияния. Институциональная формализация этих моментов декларирует намерение (пусть зачастую иллюзорное и нереалистичное, как мы знаем) установить прочные и долгие связи (союзы, мирения, совместное планирование, браки и так далее).



Связь и близость, понимаемые в широком смысле и выраженные в метафорических эквивалентах этих ритуалов, известных любому антропологу, на протяжении тысячелетий переплетались друг с другом с переменным успехом.

Давайте представим элементарную схематическую репрезентацию реляционного вектора.

Если мы нарисуем линию, соединяющую субъект и объект и задающую дистанцию между ними, то сможем также представить себе центр тяжести либидинальных и нарциссических инвестиций субъекта как смещающийся то ближе к самому субъекту, то ближе к объекту.

Общеизвестно, что есть люди, которые организуют себя автономно, удерживая центр тяжести на себе, в то время как другие (гиперзависимые) смещают его настолько, что он почти совпадает с объектом, к которому они чрезмерно стремятся. Другие (зачастую наиболее здоровые) помещают этот центр тяжести в промежуточную область, с возможностью движения в том или ином направлении в зависимости от того, как будут развиваться отношения.

В дуальных отношениях близость создает связь, когда центр тяжести инвестиций не удерживается субъектом на себе, а имеет возможность свободно смещаться, «скользя» между ним и объектом; когда субъект признаёт ценность отношений и испытывает благодарность к объекту как к источнику удовлетворения; и когда появляется способность заботиться (беспокоиться) об участии объекта.

Так создается здоровая связь между субъектом и объектом, а на более зрелых стадиях — между субъектом и другим субъектом.

Позвольте привести умышленно элементарный пример, который проще представить (по причинам, которые

вовсе не настолько же элементарны), чем прочие примеры межчеловеческих отношений: как и многие другие, я очень сильно любил свою собаку как *со-субъекта*, я долгие годы высоко ценил богатство, тонкость и глубину наших психофизических взаимодействий — звуков, движений, прикосновений, взглядов и действий/мыслей. Близость, рожденную и укреплявшуюся в ходе ежедневного сосуществования, мы оба ясно осознавали, каждый по-своему. Думаю, это главная причина, по которой мне никогда бы не пришла в голову мысль заменить мою собаку другой, возможно, более красивой, молодой или более эффектной. *Эта собака была моей собакой!*

Тем более это справедливо в отношении наших собственных партнеров, наших собственных детей, наших собственных друзей: подчеркиваю — *собственных*.

Близость, связь, принадлежность и преданность возникают естественным образом, когда всё идет достаточно хорошо.

Но мы также знаем от Фрейда, что отношения с собакой не имеют веса, так сказать, или, во всяком случае, их недостаточно: эти отношения избавляют нас от множества реляционных осложнений и фрустраций, поскольку собаки не амбивалентны и центр тяжести их инвестиций всегда смещен в нашу сторону.

Если же вернуться к нашей сугубо психоаналитической области, гораздо более сложной и тонкой, я хотел бы обратить внимание на одно довольно распространенное высказывание, которое нередко повторяют пациенты, когда анализ длится уже какое-то время.

Иногда в ходе сессии они вдруг заявляют, вроде бы невзначай, несколько небрежным, будничным тоном,

как будто случайно, посреди других мыслей: «Нет, я бы никогда не сменил аналитика... (пауза) можете ли вы представить?! .... Ведь мне бы пришлось тогда начинать заново и рассказывать мою историю целиком с самого начала!»

Это на первый взгляд простое предложение содержит целый мир коммуникаций, существующих в режиме невысказанной, непреднамеренной амбивалентности.

Поначалу кажется, что эта фраза подтверждает что-то позитивное в отношениях («Я бы никогда не сменил аналитика»), вызывая у аналитика приятное чувство благодарности за хорошую связь и за ее совместное переживание.

Но на самом деле такое предложение снижает значимость межсубъектной и межличностной связи, переводя фокус на прагматическую тему информации-знания (*аналитик как база данных*), что отнимает у отношений большую часть смысла. Аналитик предстает почти как чиновник или нотариус, который хранит у себя досье с важной для пациента информацией, добросовестно его оберегает, и на этом всё.

Самое забавное, что некоторые пациенты высказывают эту мысль в сессии с видом человека, уверенного, что другой (аналитик) с радостью тотчас же поймет, что они имеют в виду, что-то вроде: «Разумеется, я знаю, что вы понимаете, о чем я, и что мы оба прекрасно понимаем друг друга по этому вопросу, у нас одни и те же мысли, не так ли?» Возникает ощущение, словно пациент рассчитывает, что аналитик будет польщен таким единомыслием, предложенным ему тоном человека, сказавшего нечто умное, чем можно поделиться.

Иногда пациент, похоже, не улавливает, что первая, инстинктивная, контрпереносная реакция аналитика может быть только негативной — из-за разочарования от чувства, что его низводят до столь бюрократической и второстепенной роли.

Но если, как ожидается и как хотелось бы, аналитик преодолевает это первое фрустрирующее контрпереносное препятствие и осознаёт защиту пациента от признания собственного переживания интенсивной, глубокой, значимой — и, я бы сказал, необратимой — связи, которая соединяет его с аналитиком и выходит далеко за пределы функции *базы данных*, тогда всё меняется.

Аналитик может понять, что пациент задействует нарциссический бастион, который он возводит именно с целью не чувствовать всех последствий связи; или, в более легких случаях, что пациент начинает постепенно приходить к согласию со своим нежеланием сообщать аналитику что-то более глубокое и существенное.

Пациент бессознательно объясняет аналитику/Объекту — в этой странной, парадоксальной манере, одновременно избегающей и слегка пренебрежительной, — что он не предаст, что останется верен аналитическому процессу, потому что между ними уже сложилась связь, основанная на близости.

Но пациент также говорит ему, сам того не понимая, что эта близость всё еще не свободна от глубокого внутреннего сопротивления, что работа еще не завершена, поскольку пациент испытывает страх или стыд перед этой растущей близостью и перед той связью (привязанностью), которая почти неизбежно в итоге последует.

# Взгляд на пространство близости: аналитик и пациент в Поле

*Джанни Белья*

В этой работе я рассматриваю последовательные этапы восьмилетнего анализа, проходившего с частотой четыре раза в неделю. Мне хотелось бы показать — непосредственно в ходе сессии или через крупные ее фрагменты — мой подход к аналитическим отношениям как к одной из возможных и бесчисленных форм, которые может порождать Аналитическое Поле; поле я понимаю как многопространственную, многовременную структуру, оживающую при встрече аналитика и пациента.

В этом Поле могут появляться персонажи, носители эмоций, позволяющие инсценировать «часть бессознательного текста аналитического диалога [...] в поисках нарративного развития» (Civitarese, 2011, р. 74). Цель заключается в расширении истории, которая с помощью

разных диалектов и нарративных стилей способна трансформировать участвующих в ней персонажей.

Поле — это лаборатория, в которой протоэмоции трансформируются посредством непрерывной алфавитизации и совместного повествования, активируя способность к построению сновидений с помощью обмена *rêverie*.

Само повествование, в которое погружены два главных героя, превращается в «текущий и подвижный контейнер, позволяющий развиваться эмоциям и мыслям» (Ferro, 2020, р. 57), которые, благодаря постепенному переплетению друг с другом, становятся более мыслимыми, позволяя пациенту шаг за шагом интроецировать трансформирующую способность.

Трудно лучше Гротстейна описать роль аналитика, с его способностью к *rêverie*, в совместном конструировании Поля: «Аналитик, как мать по отношению к младенцу, впитывает боль пациента, становясь анализантом/ребенком (то есть “становясь” эмоциональным состоянием его психики) и позволяя этой боли стать частью самого себя. В своем *rêverie* он вызывает из собственного бессознательного репертуар личных переживаний таким образом, чтобы некоторые из них могли оказаться симметричными или созвучными еще неразличимым проекциям анализанта» (Grotstein, 2007, р. 57).

## Серджио: предпосылки к анализу

Серджио двадцать два года, он худощавый, подтянутый, его внешний вид продуман до мелочей: рваные джинсы, тяжелые армейские ботинки, на черной футболке выделяется красный коммунистический кулак с надписью

*Rage Against the Machine*<sup>22</sup>. Правое предплечье наполовину закрывает кожаный браслет. Голова выбрита, лицо напряженное, глаза ледяные, как у хаски.

Он встревожен, говорит многословно, четко и связно. Я позволяю своему разуму свободно блуждать среди властно возникающих образов: революция, борьба с системой, кулак, кровь, лед, собака, но всё это облечено в какую-то чересчур учтивую форму.

Он пользуется успехом, но никогда не имел ни романтических отношений, ни сексуального опыта, потому что каждый раз, когда он оказывался в интимной ситуации, он не мог добиться эрекции. Уже давно он избегает любых возможностей встречи, чтобы не столкнуться со стыдом, тревогой и фрустрацией. «Это несчастье меня рано или поздно уничтожит», — говорит он.

Безжизненным голосом он рассказывает о своей работе ремесленника, к которой еще год назад питал огромную страсть. С любовью и уважением отзывается о своем мастере: суровом и образованном человеке, знатке материалов и техники работы со стеклом. Мастер поддерживал его, учил, открывал ему целый мир знаний и интересных связей. С пятнадцати до двадцати лет Серджио жил «спокойной и полной энтузиазма» жизнью, но «счастливая пора» закончилась, когда мастер решил переехать во Францию, и он взял на себя управление мастерской.

Очень скоро его начинает подавлять чувство некомпетентности: он глушит себя кислотой, напивается. А за месяц до нашей встречи его «подобрали в канаве»

22 Калифорнийская группа, играющая в стиле рэп-метал.

после рейв-вечеринки и госпитализировали в психиатрическое отделение в состоянии спутанности.

Пока я слушаю его, меня на секунду выбрасывает в мгновенное переживание кошмара: мой друг Глауко уходит в штопор и падает вместе с парашютом<sup>23</sup>. В своей тревоге я отсутствую лишь мгновение, но уверен, что Серджио заметил мое «падение в канаву».

После некоторого колебания Серджио полностью меняет тему и начинает рассказывать о своем мире: о страстном увлечении музыкой хэви-метал, о любви к живописи начала XX века (ар-нуво — Климт — Шиле — Кокошка), о крайне левой идеологии. Его рассказ вызывает у меня любопытство и приятную увлеченность.

А теперь я хотел бы прокомментировать то, что происходит в Поле. Аналитик сосредоточен на слушании пациента, на собственных впечатлениях, он наблюдает, как на сцену выходят разные персонажи, составляющие первичный кастинг, но внезапно происходит эмоциональный надлом. Это надлом внутри Поля, он сам становится персонажем, скрытым в тени на сцене.

Серджио немедленно стремится вернуть меня к встрече, словно новорожденный, который заботится о собственной матери. Он пытается восстановить контакт, меняет тему, говорит непринужденным тоном о живых и увлекательных вещах.

Я воспринимаю свой уход в штопор как момент насильственного вторжения бета-элементов, не переводимых — пока не переведенных — в мысль. Это сгусток

23 В реальности всё обошлось не так уж плохо: двумя неделями ранее Глауко попал в турбулентность, которая дестабилизировала купол. Ему хватило умения и удачи, чтобы избежать штопора.



немыслимости, вызывающий визуальную вспышку, пиктограмму, где сгущаются эмоции падения/надлома, возможно, тесно связанные с качеством первичной материнской связи.

## Первые шаги в анализе

Первый год анализа в основном проходит мирно, в атмосфере взаимного интереса и понимания. Серджио обретает больше пространства и уверенности, и ему удается лучше организовывать свою работу. Алкоголь и наркотики — только по выходным: «В выходные я отрываюсь по полной».

В качестве примера привожу фрагмент сессии: сегодня понедельник, я возвращаюсь к работе после недельного перерыва.

**П. (пациент):** Извините, я немного опоздал. Неделя выдалась отвратительная, работал с картоном для витража по новому заказу, и ни один размер не подошел. Гений<sup>24</sup> сейчас в Японии, и как мне без него работать? Я уже говорил: или ты рядом, или нет, но нельзя бросать меня вот так, я не знаю, как теперь решить эту проблему... на этапе выполнения мне нужно постоянно быть в контакте, на каждом шагу может возникнуть проблема... теперь он хочет, чтобы пламя на витраже шло от насыщенного темно-красного внизу до бледно-зелено-желтого вверху, с градацией оттенков.

24 Так Серджио с иронией и раздражением называет художника, создавшего эскиз работы, которую он, как ремесленник, теперь должен выполнять.

Но знаете ли вы, сколько расчетов и проб мне придется делать, чтобы сбалансировать разные металлы в процессе плавки стекла? ...не говоря уже о священнике, который заходит, когда пожелает, стоит там и болтает, однако когда мне нужно снять мерку и он должен держать рулетку, он исчезает... он ведь должен быть всегда на месте, нет? Иначе какой из него священник?

**А. (аналитик):** Вот бы священник был доступен 24 часа в сутки, как *TotalBar*<sup>25</sup>, да?

**П.:** (смеется) Точно! Да, там всегда кто-то есть! Просто удивительно, какая разная там бывает публика в зависимости от времени суток.

**А.:** Если просидеть там за столиком целый день, столько всего можно увидеть.

**П.:** Я иногда захоживаю туда по утрам позавтракать, и там сидят школьники, которые прогуляли уроки, потом люди приходят на обеденный перерыв, но ночью там намного интереснее, туда идут после кино или, уже под утро, после клуба. Всегда найдется кто-то, сидящий в одиночестве, а если ты тоже один, можно перекинуться парой слов.

**А.:** В этом баре найдется место для самых разных людей [...]

**П.:** К счастью, картон под витраж сделали с запасом, и его не надо переделывать, только придать форму, священник тоже это отметил и сказал, что если я буду делать работу прямо на месте и если мы договоримся, он мне поможет, так даже лучше... витраж получится шикарный.

Совсем не трудно прочитать между строк содержание этой сессии, проходящей в атмосфере обоюдной гармонии: гневный протест из-за трудностей, возникших в связи с расставанием, дистанция, которая аннулируется при появлении образа *TotalBar*, превращенного в совместно созданном нарративе во вместилище множества самых разных персонажей, которые воплощают бесконечный спектр живых эмоций, приятных или болезненных.

Я определяю фигуры, вовлеченные в наше взаимодействие, как *персонажей с высоким уровнем алфавитизации*, потому что они обладают выраженным качеством трансформирующей пластичности и внутренней склонностью к совместному конструированию в Поле.

Это тот случай, когда Поле сигнализирует о том, что аналитик и пациент движутся в тех областях психики, где уже есть репрезентативность, возможна символизация и достижим легко читаемый нарративный взаимобмен: пациент разговаривает с аналитиком, а аналитик чувствует себя включенным в дискурс пациента.

Я думаю, именно в этой атмосфере возникают первые и самые легкие из бесчисленного количества нитей, которые затем сплетаются в нарративное полотно, соединяющее их «связью, предоставляющей всё большую способность к контейнированию» (Ferro, 2020, p. 58), что впоследствии позволит присоединить нити, лежащие глубже, оборванные нити.

Именно это постепенное сплетение нитей создает и расширяет эмоциональное поле, в котором могут происходить бессознательные взаимодействия и оживать совместные фантазии, внутри «нарративного потока, способного вмещать и создавать новых персонажей» (Ferro, 2020, p. 58).

Однако я не могу игнорировать коммуникацию по поводу выходных, высказывание, которое Серджио не стал разворачивать и которое заставило меня почувствовать себя исключенным, подобно тому, как и я словно бы исключаю его во время перерывов в анализе: «В выходные я отрываюсь по полной». Я воспринимаю это как появление в Поле неисследованной области, нового персонажа, осязаемого и закрытого.

И поэтому, как мне кажется, будет правильнее сказать, что между нами существует возможность хорошей сонастройки, при условии, что некоторые критические области пока останутся отделенными, в ожидании, когда в Поле возникнет для них пространство.

## **Турбулентности: теневые персонажи выходят на сцену**

Ближе к середине второго года анализа он встречается на рейве Алине, которая в очередной раз сбежала из реабилитационного центра и «стала бродяжничать». В анамнезе у нее неоднократные госпитализации в психиатрическое отделение и зависимость. Серджио влюбляется в нее до беспамятства, с удивлением обнаруживает, что он желанный любовник, о чем с гордостью мне рассказывает. Но вскоре в отношениях появляется всё больше агрессии и они стремительно разрушаются: вспышкам бешеной страсти каждый раз предшествуют бесконечные ссоры. Поведение Алине крайне нестабильно, она соблазняет его и яростно атакует, затевает опасные драки, предает и унижает его. После нескольких месяцев этой пытки она уходит от него и не возвращается, исчезает бесследно.

Мощные эмоциональные перепады отражаются в Поле. Я думаю о пламени на церковном витраже: теперь эта застывшая в стекле репрезентация неистовых эмоций приходит в движение, растекается, огонь касается живого тела, и я вижу на кистях и предплечьях Серджио ожоги, следы неосторожного обращения с плавильным материалом и печью.

В Поле теперь происходит тот самый «отрыв по полной», который характеризовал его выходные. Циклон «Алине» открыл каналы/соединения с элементами знания, для которого нет ни словесного воплощения, ни репрезентаций, ни образов.

Состояние Серджио ухудшается: он злоупотребляет кокаином и крэком, он запутался, не ест, не спит, не может, не работает, выглядит совершенно больным, на сессиях я чувствую от него неприятный запах, он пропускает встречи и не оплачивает их. Становится очень сложно поддерживать способность к диалогу и мышлению, как в самом Серджио, так и в нашей аналитической паре.

В первичном интервью он сказал: «Я ничего не помню о своем детстве, это для меня черная дыра». Теперь черная дыра обретает силу и глубину в Аналитическом Поле как «экзистенциальное переживание небытия, отсутствия смысла, как хаотический беспорядок и пустота» (Grotstein, 1994, p. 187). Утрата Алине подвергает его/нас риску падения в эту *черную дыру*, где теряется и селф, и объект.

Я представляю, что мне нужно защитить и спасти «Алине», затонувшую, зависимую, отчаянную и дикую часть, которой никогда не находилось места в первичной среде Серджио-ребенка. Я хорошо понимаю, какой раз-

рыв происходит в мышлении Серджио, который видит, как эта лазейка в его жизни сперва появляется, а потом исчезает в небытии черной дыры. Поэтому я стараюсь фантазировать вместе с Серджио об Алине, следовать за ним в его фантазиях, гипотезах и поисках, в его ностальгических и гневных воспоминаниях.

Идет месяц за месяцем, Серджио иногда в приподнятом настроении, а иногда мрачен и молчалив. В моменты волнения он пылко зачитывает длинные замысловатые тексты, написанные между нашими встречами.

Мы отбываем долгое заключение в этом Поле-Клау-струме, которое ощущается мной как упорное, всё усиливающееся *отыгрывание*, — чтобы затем его можно было трансформировать, прожить и сновидеть в наших отношениях.

На одну из сессий, проходивших в подобной атмосфере, Серджио пришел в футболке, и я заметил странные порезы по всей поверхности рук, местами покрасневшие и явно воспаленные. Я спросил, что случилось с его руками.

Он отвечает с живостью, которой я не замечал в нем уже несколько месяцев, он кажется удивленным и действительно включенным, как будто вышел из оцепенения: он хочет объяснить мне так, чтобы я действительно понял его. Я тоже удивлен и чувствую внутри себя какой-то особый трепет, который трудно выразить словами, некое физическое ощущение себя живым<sup>26</sup>.

26 Это знакомое мне с детства состояние, которое я заново обнаружил/пережил в анализе, вернув ему смысл, и я знаю, что оно связано с моим выходом из некоего столь же телесного «состояния мертвости», когда я был ребенком, которым я и остаюсь.

**П.:** Я делаю это уже какое-то время, но никто не замечает, потому что я ношу вещи с длинными рукавами, но сегодня слишком жарко, кожа раздражена. Похоже на то, что делала Алине, она же себя резала, правда?

**А.:** Отчасти похоже, но не совсем... мне кажется, тут что-то другое.

**П.:** Точно! Это случайно вышло, потому что меня бесили следы от ожогов и я стал работать над ними скальпелем, чтобы сделать их красивее... трудно выводить точные линии левой рукой, держать руку неподвижно, да и кожа воспаляется, сплошной бардак!

**А.:** Красивее в каком смысле?

**П.:** Вот эти линии, которые соединяют рубцы, должны образовывать веревочную сеть, а рубцы — это узлы, но я недоволен тем, как получается, это не то, что я хотел, видите? Вот правильные узлы, где «веревки» пересекаются.

**А.:** Веревки, узлы... не напоминает ли это рыболовную сеть?<sup>27</sup>

**П.:** Тогда эти шрамы — коряги и водоросли? ...Бертен проклинал всё на свете, когда коряга рвала сеть! ...Я так и не научился чинить сеть, а теперь Бертена уже нет... Он любил меня.

**П.:** Доктор, я переживаю... я уже несколько дней не могу дышать, а еще у меня инфекция, о которой стыдно рассказывать.

<sup>27</sup> В юности Серджио помогал пожилому рыбаку по имени Бертен. Между ними были грубоватые и в то же время теплые отношения. На сессиях он часто с ностальгией вспоминал о приключениях и разговорах на борту лодки Бертена. Рыбак стал важной фигурой его юности, и его персонаж часто возникал в анализе.

А.: Знаете, меня тоже уже некоторое время беспокоит ваше здоровье.

П.: Лука<sup>28</sup> хотел позвонить вам, но я был против, мне стыдно, что я докатился до такого, и что обо мне будут говорить... Мне ужасно стыдно, лучше б я умер, и всё!

А.: А что Лука хотел бы мне сказать?

П.: Он хочет с вами посоветоваться, потому что уже не знает, как подступиться ко мне.

А.: В прошлом Лука очень помогал вам, он волнует-ся за вас и любит вас.

П.: Я чувствую вину, которая на меня невероятно давит, и не могу об этом говорить, мне стыдно и я безумно злюсь, хочется выругаться (он всхлипывает, ворочаясь на кушетке).

А.: Давайте представим, что здесь сейчас Лука, Серджио и Белья, все вместе. О чем они могли бы поговорить, чтобы понять друг друга и помочь?

П.: Как это?

А.: Понарошку сделаем так: каждый скажет от себя?<sup>29</sup>

После некоторого колебания мы вступаем в необычный диалог, словно играем в *Playmobil*<sup>30</sup> (Серджио и Белья говорят о себе в третьем лице, дают слово Луке, меняются ролями). На сцену выходят отчаяние, половая инфек-

28 Лука — это старший брат, единственный эталон для Серджио.

29 Здесь я невольно использую выражение, которое часто употребляют дети в своих играх и никогда — взрослые.

30 Серия немецких игрушек-конструкторов с маленькими фигурками людей, животных и тематическими наборами для ролевых и сюжетных игр (домики, замки, машины, фермы и др.). — Прим. пер.



ция, злость к брату, который осуждает его и отчитывает, но также злость и разочарование Луки, моя собственная злость и разочарование по отношению к пациенту, также появляется Белья, который хочет избавиться от Серджио, но возникает и Бертен, который объяснил ему кое-что, что оставило в нем след.

Диалог между нами, ставшими персонажами из сказки / игры в *Playmobil*, позволяет свободно циркулировать эмоциям, слишком обжигающим, чтобы можно было соприкоснуться с ними непосредственно. Все горячо спорят, порой очень резким тоном. Я чувствую, как начинает распутываться что-то очень запутанное.

В конце сессии, в тот переходный момент перед выходом из кабинета, когда я обычно убираю с детьми игрушки и рисунки в ящик, Серджио просит, чтобы я позволил ему позвонить Луке по громкой связи, чтобы спросить, что он думает. Это напоминает мне, как я передаю ребенка родителям в конце сессии, и иногда ребенок хочет рассказать им в моем присутствии, во что мы играли, о чем говорили, или ведет их в кабинет показать свежий рисунок.

Я хотел бы рассмотреть подробнее это тонкое движение в аналитическом процессе. Я описал драматическую регрессию, которую понимаю не столько как состояние пациента, сколько как форму болезни Поля, возникающей, когда избыточное давление (исходящее из внутреннего мира или из внешней реальности) становится травмирующим и блокирует образование  $\alpha$ -элементов и функцию мышления/сно-видения. Я считаю, что долгий период унылого страдания, которое мы оба с трудом выносили (каждый в своей роли), был длительным процессом про-

явления в аналитическом Поле бессознательных элементов, не имеющих отображения и репрезентации.

В отличие от теорий, которые придают особое значение разыгрыванию и его использованию как «королевской дороги» к нерепрезентированному бессознательному (Sapisochin, 2013, p. 204), теория Поля ставит в центр *rêverie* аналитика и пациента как основной путь к ранее заблокированным воспоминаниям, «негативным зонам психики» или «памяти без воспоминаний» (Ferro, Civitarese, 2015).

В силу своей прерывистости по отношению к бытию память без воспоминаний и без слов прослеживается в теле, записывается в виде двигательных паттернов в недоступном бессознательном и имеет единственную форму передачи — не столько репрезентацию, сколько соматическое *проявление*.

Таким образом, «память» о травматических событиях может не появляться явно в виде сознательной исторической реконструкции, а выражаться *просто* как трансформация, через особую форму *rêverie*, в циркулирующих протоэмоциях, связанных с другими в Аналитическом Поле и в психике аналитика и пациента.

В Аналитическом Поле, функционирующем на примитивном и асимволическом уровне, *rêverie* могут проявляться не как эмоциональный унисон, но как соматический/сенсориальный/физический унисон (одно-момент-ность<sup>31</sup>, которая реализуется как «быть-одним-телом»).

В Аналитическом Поле, сжатом в этой болезненной двумерной структуре, «становится необходимым сновидеть происходящее, чтобы войти в контакт с кризисом

и дать ему первичную репрезентацию, которая сама по себе уже целебна. С точки зрения модели Аналитического Поля, телесные *rêverie* [...] являются способом инициировать первые трансформации в направлении мышления» (Civitarese, 2013a, p. 26).

Возвращаясь к сессии, я хотел бы последовательно описать ситуацию возникающего соматического унисона. Серджио демонстрирует свои руки → я осознаю, какую скрытую работу он проделал над собой за эти месяцы → от наблюдения я перехожу к пониманию того, на что я смотрю, то есть *вижу* Серджио (а не только его руки) → меня поражает один *факт* → во мне возникает сенсориальное/физическое *rêverie*: я вновь переживаю в своем теле извечное, *висцеральное* ощущение себя живым → и Серджио, со своей стороны, возвращается к жизни. На этом этапе *rêverie* принадлежит Полю.

Поле оживает, его вновь заселяют персонажи: Алине, сеть живого Бертена и Бертена, которого больше нет, коряги, которые рвут сеть, невозможность дышать, инфекция, Лука, Серджио, Белья, которые снова могут «играть». Поле расширяется, дышит, восстанавливает свою функцию наделения эмоций смыслом и снова открывает возможность для совместного конструирования смыслов.

В будущем сеть, вырезанная на его коже, подвергнется поразительным трансформациям.

Анализ продолжается, и Серджио постепенно приходит в хорошую физическую форму, заметно сокращая употребление наркотиков. Смена темпа приносит в анализ совсем другую атмосферу: в последующие месяцы в коммуникациях возникает внешний мир, работа, возвращение долгов и погашение кредитов. Серджио возоб-

новляет учебу и свои эксперименты с химией материалов, цветом и стеклом. Он совершенствует свою работу с печью и температурными режимами, вновь открывает удовольствие от чтения и охотно беседует на сессиях. У него появляются друзья, возникают короткие романтические связи. На пятом году анализа Серджио начинает встречаться с «девушкой, немного не такой, как я и те девушки, с которыми я обычно общаюсь», ее зовут Джулия, она преподает литературу старшеклассникам.

Отношения с Джулией сперва робкие, осторожные, но постепенно становятся глубокими и прочными. Джулия останется рядом с ним до конца анализа, став его спутницей.

## Воспоминания без памяти обретают возможность репрезентации

Мы приближаемся к концу пятого года, анализ продолжается без каких-либо потрясений. *Воспоминания без памяти*, «освобожденные» на той сессии о сети Бертена, блуждали по темным закоулкам Поля, никак не проявляясь, словно подземная река. Теперь они готовы всплыть на поверхность и продемонстрировать свою трансформацию и способность к репрезентации.

В понедельник утром Серджио приходит в крайнем волнении.

П.: Мне приснилось, что я болен, очень болен, что внутри меня что-то двигается, в животе и в груди, всё внутри двигается, словно там Чужой.

А.: Что-то чуждое и пугающее.

П.: Да, внутри меня была какая-то странная штука, жидкость, которая сгущалась, черная и токсичная, поднимающаяся откуда-то изнутри. Я ощущал, как она поднимается из ног, головы, рук, из пениса... всё собирается в области печени, и затем под кожей образуется большой темный пузырь.

А.: И что вы делали?

П.: Я не знал, что мне делать, во сне рядом никого не было. Я хотел позвонить вам... это было ужасно — я всё время хотел позвонить вам, но был в такой панике, что забыл, как пользоваться телефоном... жидкость была очень жгучей, и я подумал, что во мне что-то гниет, я был в ужасе, думал, что умру, если потеряю сознание... пузырь надувался всё сильнее, пока кожа не лопнула... полилась черная жидкость... и я вдруг проснулся (*замолкает*).

А.: Что вы об этом думаете?

П.: Мне было страшно, что эта жидкость разъест всё у меня внутри, что я сгнию заживо... как в фильме ужасов.

А.: И вокруг никого не было?

П.: Нет, Джулия тоже уехала, навестить родных. Я проснулся мокрый от пота, принял душ, а еще помастурбировал и выкурил косяк, чтобы успокоиться, но всё без толку, и я ждал, когда можно будет сюда прийти.

А.: Помните, какое-то время назад вам было очень плохо, кожа была порезана, из нее сочились кровь и гной?

П.: Да, Белья, вот уж было время! Тогда я тоже был уверен, что умру, но то был не сон, я думал, что уми-

раю на самом деле. Неужели сон намекает, что со мной снова случится такое? *(Он испуган.)*

*(Я задумчиво молчу.)*

П.: Белья, вы еще здесь?

А.: Да-да, я здесь.

П.: У меня глаза болят, я только что их открыл: оказывается, они с самого начала были зажмурены, а я даже не замечал.

А.: От страха?

П.: Да, это страх снова сойти с ума, страх, что вся моя нынешняя жизнь — всего лишь сон.

А.: И теперь, когда вы открыли глаза, что вы видите?

П.: Вижу потолок с росписью, на стене ковер, который мне нравится трогать.

А.: Ну вот, мы с вами здесь.

*(Наступает долгое приятное молчание; затем я решаю вернуться к сну.)*

А.: Я думал о вашем сне. Жидкость токсичная и пугающая, она может всё разжесть, однако она собирается в одной точке, чтобы найти выход. *(Снова долгое молчание, я слышу его размеренное дыхание.)*

П.: Я вдруг кое-что вспомнил из школьного периода. После неудачной инъекции у меня образовался абсцесс! Ягодица горела огнем, распухла, потом врач вскрыл абсцесс и откачал гной... боль была чудовищная, но иначе я б не выздоровел... Мама была очень нежна со мной, водила на перевязки и давала монетки, чтобы я купил себе фигурки.

Ночью я вижу сон: по моим венам перемещается что-то живое, и мне кажется, что это черви ползают у меня

под кожей, меня накрывают ужас и отвращение. Что мне теперь делать? Я умру! Как предупредить близких, попрощаться с ними? Нужно позвонить Марко<sup>32</sup>, он сразу же меня примет, как всегда заботливо, и выпишет мне средство против гельминтов, лекарство. Из маленьких порезов на моих руках и ногах медленно начинают выползать ряды тонких белых червей, сначала я чувствую дикий ужас, они продолжают выползать...но потом я замечаю, что как только они выползают наружу, то сразу погибают, и мне становится лучше.

Хочу подчеркнуть один важный момент: если два года назад Аналитическое Поле столкнулось с *кризисом* в очень конкретной форме, то сейчас (вольно переосмысляя мысль Винникотта) пациент приносит «*страх кризиса*» уже в максимально осмысленной форме (сновидение), в виде читаемой репрезентации, которая затем может трансформироваться внутри Поля посредством связей, которые она устанавливает с другими репрезентациями и персонажами. Мы можем поговорить о том, что происходило два года назад, во время *кризиса*, про потерю всех ориентиров, про то, как он ищет меня в моем молчании («Белья, вы еще здесь?»), и после того, как мы вновь встречаемся в сессии, он может открыть глаза и произнести фразу про свой «страх снова сойти с ума».

Позже, во время сессии, я лишь кратко пересказываю сон, чтобы его можно было разделить и сделать полным и активным участником в Поле: сон становится полноценным персонажем Аналитического Поля, и я могу обо-

32 Марко — мой близкий друг, специалист по инфекционным заболеваниям, мой товарищ со времен средней школы и медицинского факультета.

значить вместе с пациентом развитие, заложенное в его манифестном содержании («жидкость токсичная и пугающая, она может всё разжесть, однако она собирается в одной точке, чтобы найти выход»).

Я не даю этому сну интерпретации/объяснения, потому что не знаю, как сделать его более “а”, чем он есть, и еще потому, что моя интерпретация выдернула бы меня из той теплой и дружелюбной атмосферы, которую я глубоко переживаю с Серджио и за которую благодарен ему.

*Воспоминания без памяти*, высвобожденные два года назад благодаря соматическому *rêverie* и переживанию соматического унисона (быть-одним-телом), незаметно (так сказать, под кожей) работали в течение всего анализа.

Теперь Серджио может трансформировать сырые сенсориальные данные в «бессознательные элементы опыта, которые можно сохранить и сделать доступными... [что] подразумевает создание эмоциональных связей в процессе формирования сновидных мыслей», и способен «сновидеть свой эмоциональный опыт» (Ogden, 2005, p. 46 [с. 98]).

В заключительной части сессии недоступное ранее бессознательное содержание переплетается с памятью о матери, которая заботилась о нем, и с опытом того, что исцеление возможно.

Из моего сна я выбираю значение, полезное для статьи, которую я сейчас пишу: мне кажется, это момент заражения/смешения между аналитиком и пациентом и в то же время момент различения, благодаря онейрической работе, которая вызывает и переплетает переживания и объекты, принадлежащие внутреннему реляционному



оснащению аналитика и его жизненному и профессиональному пути.

Это нить Ариадны, позволяющая аналитику вернуться из лабиринта, потому что она обеспечивает переход от измерения слияния с *тем, что становится эмоциональным опытом пациента*, к дифференцирующей трехмерности.

Я также могу рассматривать этот сон как сновидение для нас обоих, сновидение между селф пациента и селф аналитика, где происходит процесс последующей переработки, который окажет эволюционное влияние на Аналитическое Поле.

## **Трансформируемость воспоминаний, которые существовали без памяти**

Следующие месяцы протекают вполне приятно, анализ давно уже обрел свое дыхание, Аналитическое Поле заселено старыми и новыми персонажами, и прежняя атмосфера смерти рассеялась.

За эти годы у нас обоих изменилась манера присутствовать в сессии, и теперь мы можем общаться и обсуждать разные темы на общем для нас языке, допускающем приятную и легкую иронию.

Серджио передает и принимает отсылки к тому, что между нами происходит, не нарушая сложившегося на данный момент унисона, «Белья» и «Серджио» существуют как два персонажа в Поле, каждый со своей свободой передвижения.

Приведу короткий пример из сессии, прошедшей перед долгим перерывом на летний отпуск.

А.: Серджио очень молчалив сегодня<sup>33</sup>.

П.: Ну не знаю... вообще-то, если уж хотите знать, я думал о том, что мне хотелось бы, чтобы Белья сказал что-нибудь, что-то примечательное.

А.: Примечательное?

П.: Ну да! Это необходимо (*молчание*).

А.: Белья должен сказать что-то примечательное... возможно, запоминающееся? Что-то, что звучит весомо.

П.: Да, точно! Примечательное, запоминающееся... фраза, которая останется в голове на время вашего отпуска.

В этот период много сессий проходит в фантазиях о будущем и в исследовании прошлого. Серджио и Джулия живут вместе, завели собаку, строят совместные планы на жизнь. Он переделывает свою мастерскую: организует широкую витрину (а не те вечно полуопущенные рольставни) и небольшое помещение, где клиенты и друзья смогут сесть и пообщаться, подальше от «огня, пламени, стекла и производственного беспорядка».

Мы примерно на середине седьмого года анализа, и порой я вижу признаки того, что мы приближаемся к завершению.

Уже какое-то время я замечаю, что он внезапно обрывает рассказ, а затем начинает говорить на совершенно другую тему, из-за чего я чувствую себя исключенным; негативных чувств это у меня не вызывает, скорее любо-

33 Пишется и произносится без запятой, от третьего лица: Серджио как персонаж.

пытство. Думаю, он отдает себе в этом отчет, потому что на одной из сессий он просит его извинить:

**П.:** Есть кое-что, о чем я не хочу вам рассказывать, я всё время об этом думаю, потому что трачу на это много времени, извините, я даже на сессиях об этом думаю, и это меня беспокоит... но не волнуйтесь, это не какая-то из старых моих проблем... просто я сейчас не хочу об этом говорить.

**А.:** Возможно, вы будете меньше беспокоиться, если станете думать, что это ваше дело, ваши собственные мысли, и что есть время размышлять о чем-то и есть время делиться этими мыслями с кем-то.

Вскоре после этой сессии он приходит в кабинет с тяжелым свертком, взволнованный и, кажется, смущенный.

| **П.:** Вот, я принес это вам, хотите взглянуть?

Похоже, подразумевается, что я знаю, что внутри. Я расчищаю место на столе. Он аккуратно снимает бумагу и пузырчатую пленку, и нашим взглядам предстает тяжелый блестящий предмет из стекла и металла (рис. 1). Серджио отходит в сторону и наблюдает за мной, а я молча рассматриваю его работу и прикасаюсь к ней. Затем он ложится на кушетку, а я сажусь в свое кресло, и мы некоторое время молчим. Этот предмет вызывает во мне сильный отклик, поначалу неприятный: в момент, когда он выложил сверток, первое *rêverie* было о том, что он принес мне сверток с тяжелым куском мяса, и затем в голове появились образы порезов на коже.

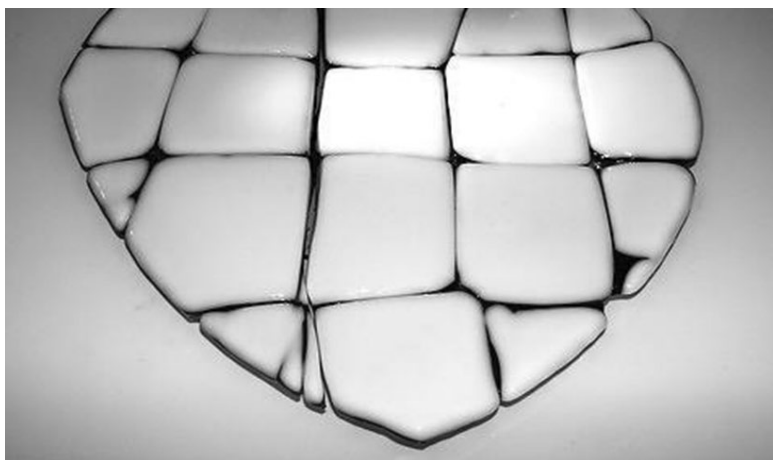


Рис. 1

П.: Так что вы скажете?

А.: Это интригует и производит сильное впечатление. Значит, это и есть тот загадочный объект?

П.: *(смеется)* Да. Я хотел с вами об этом поговорить, но тогда сюрприза бы не вышло, не так ли? Но мне интересно, имеет ли это смысл и почему я так одержим этим. Я потратил на эту работу кучу времени... думаю, это только проба, нужно отточить технику и тогда идти дальше.

А.: А в чем состоит идея, что это за проект?

П.: Я хотел сделать что-то вроде трещин в материале, стекло должно быть переливчатым, не прозрачным, и сквозь него можно только мельком увидеть то, что под ним... нижние стекла окрашены в красный, зеленый и синий, и это создавало трудности, когда они спекались вместе, а кроме того, тут есть металлические вставки, и с ними еще сложнее, потому что металл остывает

иначе, чем стекло... я сделал кучу проб, прежде чем мне удалось... но я хочу, чтобы все они там были... это переработанные детали, старое железо, которое я нашел... знали бы вы, сколько кусков откололось...

А.: Снизу черный и красный цвета и еще эти кусочки старого железа, которые в итоге остались внутри стекла и выглядят как пирсинг.

П.: Да, так и есть: это моя потрескавшаяся кожа, и черное, и вытекающая кровь, и железо, которое ранит.

А.: А какое у работы название?

П.: Я еще не решил. Думал о наркотиках... о крэке, но это не то.

А.: Крэк — наркотик, но также и звук, когда образуется трещина<sup>34</sup>.

П.: О! Это мне больше нравится, потому что крэк — только часть истории, кроме него есть и другие вещи... да, трещина есть, но я еще не уверен насчет названия.

Со временем Crack меняется, трансформируется (рис. 2, 3, 4, 5), кровоточащие порезы исчезают, раны затягива-



Рис. 2



Рис. 3

34 В пер. с англ. *crack* также «трещина». — Прим. пер.

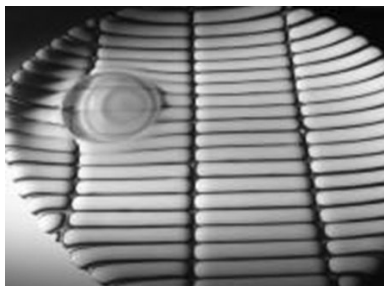


Рис. 4



Рис. 5

ются, но шрамы остаются. Предмет приобретает более художественную, образную форму и получает название Плонк, «звук, который издает стекло при остывании и который означает, что оно уже не расколется на куски».

Так Серджио репрезентирует свою историю, сновидя ее и трансформируя.

Эти эпизоды относятся к октябрю, а закончим анализ мы в июне следующего года, он занял восемь лет.

## В заключение

В этом тексте я умышленно опускаю множество данных, относящихся к истории Серджио и его реальной жизни, желая/стремясь содействовать свободному и личностному прочтению, которое ближе к О, чем к К.

Первичная среда, в которой рос Серджио, была тревожной и сбивающей с толку: с одной стороны, отношения с матерью, которая страдала тяжелым биполярным расстройством и часто пребывала в состоянии декомпенсации, с другой — отсутствие доступа к отцовской фигуре, способной устранить спутанность. Думаю, всё это

создало *черную дыру* в его переживании селф и, позволив Серджио выжить в физическом смысле, заморозило возможность развития его идентичности и его расцвет в жизни и отношениях.

Я хотел продемонстрировать медленное и постепенное формирование репрезентируемости воспоминаний без памяти, связанных с тяжелым и повторяющимся травматическим детским опытом.

Я также хотел показать, как важно слушать и ждать — с уважением к хрупкой идентичности и с чуткостью к изменениям эмоциональной атмосферы сессии, — чтобы вместе с пациентом искать опыт, который сможет развиваться, оттенок за оттенком, от чего-то недифференцированного и телесного к диалогу между двумя субъектами.

В рамках теории Аналитического Поля я подчеркиваю важность слушания и использования *rêverie*, особенно соматического, которое становится ключом к недоступным и творческим бессознательным областям психики. Я показываю, как содержания, став интегрированными и доступными, обретают возможность свободно циркулировать в бессознательном, развиваться далее в сновидении и в итоге даже находить художественное выражение.

# Когда вспыхивает страсть: аналитическая близость в сложных отношениях

Лука Николи

## Плохая работа<sup>35</sup>

Когда встречаются две личности, возникает эмоциональная буря. Если они вступают в достаточный контакт, чтобы осознавать друг друга, или даже достаточный настолько, чтобы не осознавать друг друга, создается эмоциональное состояние, порожденное соединением этих двух индивидов, и возникающее при этом беспокойство едва ли можно считать улучшающим положение дел, по сравнению с тем, что было бы, если бы они никогда не встретились. Но, поскольку встреча всё же случилась и буря поднялась, обе стороны могут решить «извлечь максимум из плохой работы».

Страсти, от слова *pathos*, — это бурные, полные страдания эмоции, и чтобы психика могла проживать их, не рискуя разрушиться, требуется необычайная способ-



ность к контейнированию. По словам Биона, чтобы мыслить самые немислимые мысли, нужны две психики. Нужны две психики, чтобы вплетать страсти в осмысленную канву и превращать их в источник личного опыта, который можно разделить.

Чтобы обладать трансформирующей силой, аналитический опыт должен не только приводить пациента к знанию чего-то о нем самом, но и вести его к опыту бытия самого себя вместе с другим человеком, который разделяет с ним свои репрезентативные, метаболические и сновидческие способности в отношении реальности.

При обсуждении клинического случая важно обращать внимание не только на пациента, но и на аналитика, и, в еще большей степени, на аналитическое поле, которое вплетено в отношения между ними. Это поле должно быть достаточно эластичным, чтобы выдерживать эмоциональные турбулентности, которые два главных героя приносят с собой и воспроизводят в возникающих между ними отношениях.

Это онтологическое измерение психоанализа, как его определил Огден, и оно обеспечивает основу для возможных эмоциональных и нарративных трансформаций человеческой психики. С более регрессивными пациентами, а также с теми, кто в начале анализа приходит с психосоматическим, или конкретным, или магическим мышлением, аналитик должен находиться в состоянии одно-моментности (Бион, Ферро), чтобы дать возникнуть той близости, которая необходима для обеспечения трансформирующего опыта.

Когда я говорю об аналитической близости, я имею в виду «ту область контакта, которая позволяет нам

заставить внутренние струны пациента вибрировать от наших комментариев или интерпретаций. Она представляет собой совместно проживаемое состояние относительно внутренней свободы, более пронизываемое для предсознательных и бессознательных коммуникаций, которые делают возможными процессы субъективации, сновидения и переваривания непереработанных травм» (см. первую статью данного сборника).

Многие пациенты редко испытывали удовлетворение от состояния близости: в своей жизни они переживали отвержение или насилие, когда позволяли другому вступать с ними в близкие отношения. Поэтому они выработали очень сильные защиты от вторжения: расщепление, рационализацию, нарциссические или шизоидные замыкания. Аналитику, чтобы быть принятым, приходится начинать с позиции, отличной от той, которой он бы хотел придерживаться: и не только в начале терапии, но и на каждой отдельной сессии, которая становится настоящей драмой, когда неизвестность внезапно врывается в аналитический кабинет.

## **Зар(О)ждение<sup>36</sup> сессии: сколько страсти мы сможем пережить сегодня?**

Начало сессии — это ее О, ее зарождение. Это похоже на зарождение жизни: живое существо не имеет другой формы, кроме той, которую получает, адаптируясь

36 В оригинале *l'(O)rigine*: внутри слова обыгрывается бионовское понятие О, абсолютная истина и предельная непознаваемая реальность, являющаяся изначальным источником для зарождения любого психического опыта (от англ. *origin*, хотя Блон прямо не расшифровывает О, в отличие от понятий К, L и Н). — Прим. ред.

к окружающей среде. Реакция среды постепенно задает направление, в котором будет развиваться жизнь, через постоянное отражение и означивание.

Точно так же первые реплики пациента — это зарожденные сессии: они несут в себе название самой сессии, которое открывает путь к бесконечным сценариям и бесконечным повествованиям в зависимости от того, какой отклик они встретят. Откликом может быть молчание, или вербальный ответ, или даже ощущение встречи или не-встречи с аналитиком. Начало и отклик на это начало во многом определяют то, как будет развиваться сама сессия. Сколько страсти мы способны пережить сегодня?

Эта проблема становится особенно серьезной во время онлайн-сессий, поскольку в такой ситуации пациент не испытывает той уверенности и осязаемости контакта, как при встрече в кабинете, когда физическое присутствие хоть как-то гарантирует, что оба сейчас находятся здесь (хотя, как мы знаем, физическое присутствие мало что говорит о психической способности к принятию).

Онлайн-сессия требует технических корректировок (вы тут? вы меня слышите?), которые отнюдь не нейтральны: наоборот, они обращаются к самым ранним аспектам каждого из участников аналитической пары (Nicoli, 2023b, сар. 6). Иллюзию того, что расстояние можно устранить с помощью цифровой связи, часто внезапно прерывает неожиданное *зависание* или резкий разрыв соединения. Такое случается довольно регулярно, когда интернет-подключение нестабильно, что нередко бывает в наших кабинетах, и поэтому зарождение (О) каждой сессии представляет собой не только сильное стремление к контакту, но и определенную готовность к тому, что понадобятся

некоторые необходимые настройки, прежде чем аналитическое оборудование сможет функционировать.

## **Флорентийский стейк Бильбо Бэггинса**

Я расскажу о случае пациента Бильбо Бэггинса, университетского преподавателя среднего возраста, живущего в нескольких сотнях километров от меня. Его родители были подавлены смертью другого своего ребенка, случившейся еще до рождения моего пациента, поэтому Бильбо никогда не чувствовал себя по-настоящему принятым. В подростковом возрасте он стеснялся своего тела, ощущал недостаток способностей. Он набрал вес и долго считал себя непривлекательным для сверстников, вплоть до совершеннолетия и первых поездок за границу, когда он почувствовал, что его замечают и ценят. Ум и усердная учеба привели его к профессиональному успеху. В настоящее время он уже несколько лет женат на коллеге, у них трое детей.

Он обратился ко мне два года назад из-за смутного чувства эмоциональной усталости; ему было трудно радоваться своей жизни и семье. В юности он проходил курс терапии и остался им доволен. Теперь он искал аналитика, который был бы менее серьезен, чем другие, кого-то, кто сразу вызвал бы у него симпатию. Мы договорились встречаться раз в неделю.

На сессиях он использует много технических терминов, из-за чего выглядит более образованным, чем я. Я часто ощущаю себя интеллектуально неполноценным, но рассчитываю на то, что если он выбрал меня своим аналитиком, значит, думает, что я могу дать ему что-то ценное. Меня немного раздражает эта постоянная интеллектуали-

зация, я предпочел бы чуть больше простоты в общении. «Говори, как ешь», — так принято у нас в Италии.

Бильбо звонит мне по Skype, и однажды звонок поступает на мой телефон, а не на планшет, который мы обычно используем для разговора. Поэтому я отклоняю вызов и тут же перезваниваю ему с планшета.

Бильбо отвечает на звонок и с хитрой улыбкой спрашивает: «Вы же не отвергаете меня, а?»

Я на мгновение задумываюсь о том, что Бильбо чувствует себя отвергнутым, но потом решаю не придавать этому слишком большого значения. Я не хочу сворачивать к теме покинутости и встречать пациента интерпретацией про отвергнутого ребенка, это было бы неуместно в данный момент. На самом деле меня раздражает этот мелодраматический тон, с которого началась сессия.

**А. (аналитик):** Нет, просто на телефоне не включается камера, я вас не вижу...

**П. (пациент):** Ну да, конечно, давайте свалим всё на *Techne*...

На *Techne*? Серьезно? *Techne* — это латинское слово, от которого происходят слова «техника», «технология». Я ощущаю раздражение из-за его пассивно-агрессивного брюзжания и того, как он моментально задействует интеллектуализацию. Между нами слишком много напряжения, поэтому я позволяю разговору продолжиться, чтобы обстановка немного разрядилась.

Бильбо упоминает, что ему очень понравилось то, как мы говорили в прошлый раз о еде, и рассказывает, что на День святого Валентина друзья пригласили их семью

к себе домой на скромный ужин. Кстати, у этих друзей есть дочь, которой интересуется сын Бильбо, Фродо. «Когда он ее видит, у него глаза становятся как сердечки, хотя он это и отрицает...»

**П.:** Мы пошли к ним, и скромный ужин состоял из двух килограммов флорентийского стейка, овощей и отличного вина.

Не удовлетворившись этим, Бильбо пускается в описание вина, его марки и оттенков букета.

Я размышляю об этом невероятном избытке еды. О чрезмерности. Всё это чрезмерно.

Затем Бильбо рассказывает о том, как он читал лекцию группе диетологов и тогда тоже почувствовал, что говорил чрезмерно много, как будто перекормил их. Он говорит: «Это же надо, перекормить группу диетологов...»

**А.:** Знаете, я ошибся. Я ошибся в начале сессии, потому что вы сказали, что чувствуете себя отвергнутым, а я, вместо того, чтобы признать, что вы могли так себя чувствовать, или что я мог сделать что-то не так, или что вы могли подумать, что я был чем-то занят...

**П.:** Да, чем-то более важным!

**А.:** Точно. Вместо этого я повернул разговор в другое русло, так что нам пришлось сделать длинный крюк, с кучей препятствий и разговоров о еде, вместо того, чтобы пойти по кратчайшему маршруту.

**П.:** Ну, радоваться сложно. У нас недавно была прекрасная поездка в горы, мы остановились на привал,

все разлеглись на солнышке, расслабились, а я постоянно повторял: «А что теперь? Что мы делаем дальше?»

## Микрорепарации: как странствующие рыцари

Сессия начинается с того, что потом станет ее центром, ее О. Аналитик, с помощью того, что в реляционной парадигме называется *разыгрыванием*, инсценирует родительское отвержение в самом начале жизни пациента, а также его детский протест. Этот протест, который не был услышан ни тогда, ни сейчас, придает началу сессии эмоциональное значение крайней инфантильной зависимости.

Но поле не готово контейнировать страстную ревность, заполняющую Бильбо после отвержения. Аналитик уподобляется родителю, на которого — после смерти ребенка — слишком рано обрушивается невыносимая зависимость, и поэтому он уходит в плоскость реальности. Это страх перед яростным инфантильным возмездием, перед собственной неспособностью контейнировать эмоции ребенка, жаждущего внимания. Уход в плоскость реальности вызывает сжатие аналитического поля. Как предупреждает Ферро в книге, которую мы написали с ним в соавторстве (Ferro, Nicoli, 2017), аналитик в первую очередь должен оплакивать реальность!

На самом деле реальность не питает психику пациента. Это способ уклониться от просьбы пациента о принятии, который поэтому сначала погружается в интеллектуальное измерение, а затем отправляется на поиски питания в виде огромного количества еды. Происходит

обрушение — с онейрического мышления к магическому, еда словно становится эквивалентом любви.

Бильбо таким образом забирает инвестиции из аналитических отношений, и аналитик чувствует себя отодвинутым в сторону. Он страдает, он потрясен, и он передает эти свои чувства полю посредством собственной альфа-функции: произошла ошибка соединения!

Говоря об «ошибке», аналитик делает две вещи: с онтологической точки зрения, он предлагает еще один шанс на репарацию. В то же время он предоставляет эпистемологический опыт, понимание того, как функционирует реляционное взаимодействие: «Я повернул разговор в другое русло, так что нам пришлось сделать длинный крюк, с кучей препятствий и разговоров о еде, вместо того, чтобы пойти по кратчайшему маршруту». Микро-репарации в ходе сессии — один из мощнейших терапевтических инструментов, которыми мы располагаем. Это постоянная регулировка положения руля велосипеда (тандема!), благодаря которой мы удерживаем направление. Если ехать на велосипеде, не поворачивая руль ни разу, упадешь уже через пару метров.

Идею ошибки, выраженную аналитиком, следует разбавить понятием корректировки маршрута, или постепенно прибавляющегося опыта. Первоначально слово «заблуждаться»<sup>37</sup> означало путешествовать без определенной заранее цели, как это делали странствующие рыцари в Средневековье. Это были не «заблудившиеся» герои, выбравшие неверную дорогу, это были исследователи.

37 Игра слов: в итальянском языке *errare* — это и бродить, и заблуждаться, *errante* — странствующий, блуждающий. — Прим. пер.



Исследование приводит к бастioniу (Baranger, Baranger, 1961/1962), возведенному из мудреных слов и целых тонн неперевариваемой пищи (бета-элементы), пока с помощью микрорепараций не удастся вновь выйти на дорогу к одно-момент-ности.

Это возвращение к встрече (связь контейнер — контейнируемое) позволяет пациенту вновь открыть для себя удовольствие от пребывания в сессии, *«продолжающееся бытие»*, о котором говорит Винникотт, — «все разлеглись на солнышке, расслабились...»

После того как поле дало репрезентацию драмы нежеланного ребенка и разрешило ее через сцену с привалом на солнышке, повествование продвигается вперед и приводит к вопросу о том, кем пациент хочет быть и какие отношения хочет иметь. Бильбо, мало сновиденный своими родителями, в отчаянии спрашивает, какая судьба ему уготована: «А я постоянно повторял: “А что теперь? Что мы делаем дальше?”»

П.: Как будто я постоянно в дефиците, постоянно на грани финансового краха... я понимаю, что всю жизнь мне приходилось обходиться самому, никогда никто не говорил мне: «Иди, сынок, я сам с этим разберусь! Иди спокойно». Хорошо, что сессии теперь такие длинные... но потом я сам себе говорю: «Давай, расслабься уже хоть немного! Ты же сидишь на самом краешке кресла!»

И в этот момент мне в голову приходит мысль: я должен дать себя съесть!

Оставить Бильбо здесь (или там), в этом долго тянущемся времени — возможно, слишком долго — и позво-

лечь ему чувствовать себя живым. Сейчас у него меньше нетерпения, чем у меня? Мы оба оказались в новой ситуации, довольно неловкой, и я пытаюсь выразить это словами...

А.: Где мне быть? Что сказать?

П.: Что я должен делать?

А.: Эх, прежде время летело, сессии шли сами собой, своим чередом. Что же делать теперь? Как встретиться?

П.: Вот именно, как встретиться? Вот в чем вопрос! Как быть, а не как действовать! Я должен научиться не судить. Отдыхать. Расслабляться.

У Бильбо урчит в животе, я не знаю, что сказать, но мне кажется, что он меня буквально вбирает в себя: как отца, как брата, как образ, словно он что-то в себя вкладывает... но в то же время всё это очень зыбко.

А.: Можно прислушиваться к урчанию в животе, думать, что с этим делать, как быть, вместо того чтобы набивать желудок и чувствовать лишь переполнение... которое заставляет не чувствовать вообще ничего. Вот и проясняется смысл того ужина на День святого Валентина: это был способ заполнить эмоциональный вакуум, очень пугающее ощущение!

## На сцене: драма Дня святого Валентина

После того как пациент восстановил свое состояние селф, не прибегая к проявлению подавленной эмоции через отреагирование, то есть переживая «продолжающе-

еся бытие», как говорил Винникотт, он восстанавливает потребность получать питание от аналитика. Это значит не поглощать тонны еды, а «есть аналитика»: и последний должен эмоционально согласиться быть съеденным. Если б я был женщиной, имеющей опыт грудного вскармливания, мне было бы проще представить идею быть съеденным, но не быть поглощенным: грудь создана для того, чтобы питать, не опустошая мать. Но я всего лишь мужчина.

Когда пациент может проживать опыт бытия самим собой, опыт быть хорошо накормленным, тогда он может, благодаря достижению большей близости, поделиться своими самыми подлинными чувствами.

**П.:** Во мне много злости на жену. И она никогда не проходит, я постоянно злюсь. Ее постоянно нервирует, что я не делаю какие-то вещи, а меня злит то, как она их делает.

**А.:** Злость удерживает вместе: не дает нам почувствовать скуку, боль или одиночество.

**П.:** Мы всё время на взводе, максимально на взводе, и нам не удастся встретиться.

**А.:** Не встретиться — это не всегда плохо. Потому что встреча — это риск.

**П.:** Может быть, нас уже ничего не держит вместе, кроме того, как нас видят дети, и того, как мы смотрим друг на друга их глазами. И это вызывает очень сильные эмоции.

**А.:** Да, возможно, быть вместе больше не получится, или для этого нужно стать другими, не такими, как сейчас, и быть готовыми меняться.

**П.:** Я понимаю, что не могу больше находиться в такой ситуации.

Когда близость предоставляет возможность для встречи, аналитическое поле расширяется и становится способным вместить самые бурные страсти. И так на сцене возникает «драма Дня святого Валентина»: злость из-за невыполненного обещания любви.

Бильбо всегда давал выход злости, которую испытывал из-за фрустрации своих потребностей, через работу и оральное удовольствие, не проживая ее и не давая ей репрезентации. Сегодня, благодаря «ошибке» в сессии и последующей репарации, он может признать, сколько злости вызывает отсутствие встречи.

В этой накаленной атмосфере я указываю Бильбо на то, что объект, вызывающий злость, — это объект инвестирования, тогда как отсутствие злости может вывести на поверхность спящую любовь, но также безразличие и отчуждение. Доверие в аналитических отношениях позволяет нам обозначить словами супружеский кризис: «может быть, нас уже ничего не держит вместе».

Я редко рассматриваю эти сообщения как исключительно переносные и не интерпретирую персонажей (например, жену Бильбо) как заместителей аналитика. Скорее, я воспринимаю этот материал как сновидение со множеством измерений. В аналитическом поле есть место, или модальность отношений, которую Бильбо называет «женой» и которая должна была быть вознаграждающей и поддерживающей, но вместо этого рискует оказаться лишь фикцией.

Цель анализа не обязательно состоит в том, чтобы наладить эти отношения (как это было бы, если бы жена

была нарративным альтер эго аналитика), а в том, чтобы вдвоем понять, что делать с этим способом быть вместе. Есть ли там еще страсть, где-то глубоко внутри? Есть ли тепло?

Или семья — это всего лишь декорации из папье-маше, поддерживаемые эмоциями «детей»?

И является ли такая близость, называемая «семьей», пригодной для жизни, или «я понимаю, что не могу больше находиться в такой ситуации»?

## **Выводы: близость, истина и страсти**

Как видите, вновь обретенная близость — и в отношениях с самим собой, и в отношениях с аналитиком — позволяет аналитическому полю вместить новые истины и новые нарративы. Я рассматриваю истину — которая, по словам Биона, есть пища для психики — как способность дискурса вмещать эмоциональное О отношений, без необходимости для аналитической пары скрывать или избегать ее.

Таким образом, близость — это измерение, в котором страсти не являются лишь «случайностями» (вещами, которые случаются, как сказали бы греческие философы). В этом измерении они не просто «импульсы в поисках судьбы», исходящие от «эго, которое не хозяин в своем доме», как считал Фрейд.

Это не молнии любви, поражающие несчастного влюбленного, как в комиксах, и не зачарованные стрелы Эроса-Купидона.

Страсти становятся психосоматическим выражением человека и его способа быть с другим. Это эмоциональ-

ная энергия в отношениях, которая позволяет нам чувствовать себя субъектами собственного опыта и рисует реальность как место, в котором стоит жить.

Для аналитика, исходя из моей практики психоанализа и психотерапии, страсть — это топливо внимания, любопытства и терпения, которое делает эту «плохую работу» волнующей и вознаграждающей.

## Часть 2. Истина

# «Я пришел сюда не для того, чтобы что-то менять»: психоаналитическая терапия в эпоху недоверия

*Лука Николи, Элена Морганти*

## Общество Нарцисса

В последние годы мы наблюдаем почти пятидесятипроцентный рост обращений в отделение неотложной психиатрической помощи подростков от двенадцати до восемнадцати лет, совершающих акты самоповреждения или предпринимающих попытки самоубийства (Bruni, 2021). Эта тревожная тенденция, по-видимому, усилилась после периода вынужденной изоляции, введенной в целях сдерживания COVID-19. Сложившаяся ситуация требует осмысления со стороны специалистов, а также внедрения служб, способных совместно разработать адекватные стратегии лечения и профилактики. На самом деле, в условиях системы государственного здравоохранения высокий и посто-



янно растущий поток обращений не позволяет ответить на все запросы, и некоторые из них перетекают в частные службы, которые, на мой взгляд, вынуждены пересматривать как собственные подходы, так и некоторые фундаментальные технические аспекты, например связанные с выстраиванием сеттинга и самого терапевтического альянса.

Прежде всего, в работе с пациентом мы не можем не учитывать ослабление объектных отношений, характерное для того исторического периода, который мы переживаем. Нашему обществу в целом свойственна нарциссическая атмосфера, из-за которой людям сегодня становится гораздо труднее, чем в прошлом, просить о встрече и выдерживать глубокий контакт с другим человеком. Ряд исследований, посвященных эмоциональному развитию молодого поколения, указывает на сильную нестабильность первичных отношений. Постоянная смена учителей и нянь, отсутствие устойчивых точек опоры во времени, особенно в нуклеарных<sup>38</sup> семьях и в условиях средних и крупных городов, препятствуют формированию доверительной связи с другим как с надежным объектом. Дети — а затем и подростки, и взрослые — приучаются с осторожностью держаться на расстоянии и не тянуться к объекту (понимаемому в психоаналитическом смысле как объект аффективных инвестиций), который завтра может исчезнуть. Как отмечает психоаналитик Стефано Болоньини (Bolognini, Nicoli, 2022), сегодня мы явственно наблюдаем общее смещение центра тяжести в отношении

38 Нуклеарная семья — социальная единица, состоящая из родителей (обычно мать и отец) и их детей, живущих вместе. В отличие от расширенной семьи, не включает бабушек, дедушек и других родственников. — *Прим. пер.*

ях в большей степени в сторону субъекта, чем в сторону объекта. По сравнению с несколькими десятилетиями назад всё чаще встречаются пациенты с выраженной нарциссической структурой, и этот фактор существенно влияет на способность выдерживать перипетии отношений, зависимость и взаимозависимость, особенно на начальном этапе лечения. В то же время постепенно ослабевает доверие к институтам, вследствие чего люди всё меньше готовы полагаться на медицинских работников.

## Неисследованная планета

Это ощущаемое снижение доверия к объектным отношениям, то есть к возможности иметь с другим значимые и надежные связи, делает особенно сложным и деликатным этап первичных консультаций и построения терапевтического альянса, который способствует плодотворному сотрудничеству.

Кроме того, нужно учитывать, что человек, как правило не обладающий специальными знаниями в области психологии и психотерапии, в наши дни находит в интернете огромное количество разрозненных и в основном поверхностных сведений — зато легко и быстро, — и это создает у него иллюзию того, что он способен самостоятельно оценить тяжесть собственного состояния, квалификацию нужного ему специалиста и наиболее подходящий терапевтический подход. Поэтому мне кажется, что сегодня намного важнее, чем когда-либо, разделять вместе с пациентом процесс диагностики и план терапевтической работы. Мы можем представить себе пациента как космонавта-исследователя, прилетевшего на чужую

планету, перед которым необходимо предстать как заслуживающая доверия фигура и сказать ему на межгалактическом, понятном ему языке: «Мы настроены мирно».

Только тогда другому будет легче согласиться на совместное путешествие, которое нередко оказывается весьма продолжительным. В отличие от прошлых времен, сегодня этот маршрут можно намечать постепенно, в ходе долгой и углубленной консультационной фазы, поскольку люди, приходящие к нам, зачастую не готовы сразу принять неопределенность срока терапевтического контракта.

Недавно одна синьора, связавшись со мной по телефону (что редкость в наши дни, поскольку первый контакт чаще происходит посредством асинхронных сообщений в мессенджере, и это дает собеседникам чувство большей дистанцированности), задала мне прямой вопрос: *«Доктор, сколько сессий понадобится, чтобы вылечить депрессию?»* Затем она добавила, что уже проходила терапию у врача, который лечил депрессию за десять сессий. Я спросил, помогло ли ей лечение, а она ответила: *«Не могу сказать, потому что я бросила терапию на четвертой сессии»*.

Всё чаще при встрече с запросом пациента ощущается атмосфера недоверия. Люди испытывают осязаемый страх оказаться в ловушке, и если есть чувство хуже, чем ощущение физической ловушки, то это, безусловно, ощущение психического застревания в отношениях, над которыми человек не имеет полного контроля.

## **Сеттинг без обязательств**

Мы часто слышим фразы вроде: *«Сходим куда-нибудь вечером? Без обязательств!»*, а потом за ними следует: *«Хо-*

*чешь продолжить встречаться, без обязательств?»* Коммерческие отношения тоже должны быть свободными: *«Приезжайте и протестируйте автомобиль, это вас ни к чему не обязывает!»* Ощущается потребность гарантировать абсолютную свободу, ничем не обремененную. Похоже, сама идея связи с другим стала восприниматься как ловушка, потому что она лишает нас полного контроля над собой и свободы в любой момент разорвать отношения с другим всего лишь одним кликом.

В клинической практике это выливается в такой запрос: *«Доктор, мне нужно просто поговорить, без обязательств»*. Основная предпосылка в том, что всё может происходить без обязательств, потому что люди явно боятся предложений, которые создают ощущение постоянства.

В таких условиях выстраивать сеттинг становится сложнее. Это подразумевает такое приглашение, которое позволит сблизиться, не слишком пугая при этом. Если раньше идея психотерапевтических отношений, в которых *«мы выделим столько времени, сколько потребуется, пусть даже годы, лишь бы вам стало лучше»*, давала ощущение комфорта без необходимости торопиться, то сегодня преобладает стремление как можно быстрее уладить вопрос с собственным психическим здоровьем, чтобы снова стать продуктивным и «нормальным».

Это нетерпение обусловлено двумя очень важными аспектами, которые тесно связаны друг с другом.

С одной стороны, это страх финансового характера: многие пациенты, бессознательно или даже явно, воспринимают психотерапевта как какого-то паразита, высасывающего деньги из их раненых сердец, и боятся впасть в одностороннюю и рискованную зависимость. *«Дорогой*

доктор, — мог бы сказать пациент, — *меня обманывали в детстве, надо мной издевались в более взрослом возрасте, и всё это были люди, которые вроде бы должны были обо мне заботиться; так почему же вы думаете, что я настолько глуп, чтобы довериться вам — незнакомцу, который делает странные вещи с моей психикой, неподвластные моему контролю?»* С другой стороны, любые вложения в собственный мир — финансов, эмоций или времени — воспринимаются в обществе с подозрением. Общество обесценивает психическую жизнь, отдавая предпочтение объективному, измеримому и «нормальному».

К этому добавляется тот факт, что многие молодые коллеги сегодня приходят в профессию, не пройдя углубленной личной терапии, из-за сопротивления, аналогичного сопротивлению других людей, и этот фактор поддерживает базовое, бессознательное неверие в психологические изменения, которые они сознательно предлагают пациентам.

Постепенное продвижение, позволяющее пациенту сначала попробовать сам процесс на вкус и шаг за шагом начать доверять, вместо того чтобы загонять его в ловушку неопределенности маршрута, может облегчить дело. В последнее время, к примеру, я заметил, что говорю взрослым пациентам то, что раньше оставлял для подростков: «Давайте начнем в сентябре и, возможно, к Рождеству мы сможем *подвести итоги*». С теоретической и технической точек зрения эта коммуникация не имеет никакого смысла, потому что в декабре не случится ничего такого, что отличалось бы от обычной записи на прием в январе. Но перспектива подвести *итог* создает впечатление, что можно будет остановиться. Что

можно будет сойти. Что мы в безопасном месте, где аварийные выходы четко обозначены.

## **Люди растут только тогда, когда их сновидят**

Если, с одной стороны, мы должны воспрепятствовать призраку обязательств, то, с другой стороны, должны откликнуться на потребность пациентов в контейнировании, в том, чтобы занять место в нашей психике и не быть забытыми. Многие мои пациенты поражаются тому, что спустя годы я всё еще помню имена их друзей детства или другие подобные детали.

Лучшим контейнером для другого всегда остается человеческое мышление. Как сказал поэт Данило Дольчи, «люди растут только тогда, когда их сновидят». И наша задача как терапевтов — сновидеть личность, которой может стать наш пациент, и предоставить ему достаточно большое пространство для трансформации, чтобы он смог сновидеть сам. Для этого потребуются наши аналитические, сновидческие и метакогнитивные способности.

В эпоху недоверия и объективности, когда даже сны утратили значение в общественном сознании, — как пишет автор комиксов Дзерокалкаре (Zerocalcare, 2013), «...они просто отходы бодрствования. Сон — это выгребная яма души!» — в эту эпоху мы, терапевты, и в частности психоаналитики, возвращаем достоинство внутреннему, интимному миру, душе, путешествию психики. И для этого, как предлагает Антонино Ферро, мы должны взять на себя обязательство мыслить *вместе* с пациентом, а не о пациенте (Ferro, Nicoli, 2017).

Как отмечает в своей статье Томас Огден (Ogden, 2019), современный психоанализ придает большую значимость, наряду с эпистемологической функцией метода, которая заключается в понимании и познании функционирования психики, онтологическому аспекту, подразумевающему эмоциональный опыт взаимодействия с другим. На его теоретическом языке это значит сновидеть пациента в его существовании, то есть совершать бессознательную, творческую<sup>39</sup> и поэтическую работу в опыте взаимоотношений с ним, помогая ему почувствовать себя полноценно живым в своем собственном бытии. Без такого рода аффективного опыта эпистемологические аспекты психотерапии оказываются значительно менее действенными. Чтобы терапевтическая работа была по-настоящему результативной, необходимо, чтобы пациенты ощущали нас как собеседников, способных предложить им новый опыт, в первую очередь опыт плодотворного проживания отношений.

Современная психоаналитическая психотерапия уделяет большое внимание нарциссической хрупкости и способности пациента выдерживать эмоциональную истину, то есть его способности вмещать эмоции, мысли и формы отношений, не эвакуируя их посредством отыгрываний или проективных идентификаций и не прячась за бронебойной системой защит, которая не позволяет эмоциональному материалу быть проработанным.

Здесь я имею в виду наиболее примитивные защиты, такие как расщепление и проекция, превращающие другого в фигуру, радикально отличающуюся от той, с кото-

39 Здесь используется греческое слово *poiesis* — процесс сотворения того, чего ранее не существовало. — Прим. пер.

рой человек сталкивается на уровне внешней реальности. Другой воспринимается не как надежный собеседник, а как тот, кто может обольстить и подчинить, и поэтому не заслуживает доверия как носитель истины.

## На пути к терапевтической близости

В целом истина — материя обжигающая и часто непереносимая, если предъявлять ее, не достигнув достаточной близости. Поэтому нужно очень внимательно отнестись к тому, как осуществляется коммуникация. Речь идет о дозировании той доли истины, которую может принять человек, находящийся перед нами (Grotstein, 2007; Nicoli, 2023b).

К примеру, пациент с психотическим функционированием обладает минимальной способностью принимать какую-то истину о себе, поскольку контакт с ней вынудил бы его столкнуться с глубокими психотическими тревогами.

В присутствии пациента с преимущественно пограничным функционированием мы должны тщательно оценивать любой аспект нашей коммуникации, который может быть воспринят как наше отчуждение, дистанцирование или возможная утрата нас самих, и это может спровоцировать тревогу, импульсивность и гнев. И наоборот, пациенты с выраженной способностью к контейнированию и с невротическим типом функционирования могут позволить истине занять больше пространства.

Мы можем представить себе, что нам приходится использовать кухонные прихватки, чтобы предложить пациенту такую дозу истины, с которой он сможет справиться, не отшатываясь и не обжигаясь.



Это требует существенных технических корректировок, например, меньше использовать сложные и структурированные интерпретации «из учебника» — они подходят для людей с достаточно развитой способностью к символизации и с невротическим функционированием, — предпочитая вместо этого интервенции эмоциональной алфавитизации. Возникающие в последние десятилетия нарциссические и пограничные патологии действительно требуют постоянного контакта в ходе сессии, чтобы можно было распознавать эмоции и надевать их именем и значением. Даже простые и обыденные, на первый взгляд, интервенции вроде: *«Боже мой, как же вам, должно быть, было страшно!»* или *«Это, безусловно, была сильная завистливая атака со стороны вашей сестры — думаю, что после этого вечер для вас был испорчен»* — помогают наиболее алекситимичным пациентам или таким, кто в основном защищается от контакта с самим собой, получить доступ к более богатой и сложной эмоциональной палитре собственного опыта.

В контакте с пациентами становится очевидным, насколько трудно сегодня многим людям оставаться в эмоциональном переживании, как в своем собственном, так и в переживании других. Эмоции часто эвакуируются мгновенно, прежде чем их можно будет пережить и интегрировать: они выбрасываются в социальные сети или разряжаются через импульсивные действия и патологические зависимости, выполняющие антидепрессивную функцию. Многие пациенты не в состоянии поддерживать контакт со своим внутренним миром, узнавать себя в нем и связывать это с каким-либо переживанием.

Первичная терапевтическая работа должна устранить то состояние подвешенности, которое можно определить как вечное настоящее (настоящее компульсивного скроллинга, тысячи чатов в реальном времени и работы 24/7), чтобы сформировать временную структуру — до и после, — необходимую для постепенного выстраивания терапевтической близости. Я определяю терапевтическую близость (Nicolì, 2023a) как совместно проживаемое состояние относительной внутренней свободы, более про- ницаемое для бессознательных коммуникаций и способствующее процессам субъективации, сновидения и переваривания переработанных травм.

## **Меняться, не вовлекаясь в отношения**

Рост тревожных расстройств заставляет нас как терапевтов вновь обратиться к понятию «негативной способности», о которой писал Уилфред Бион (Bion, 1970), — человеческой способности оставаться в *«неопределенности, тайне, сомнениях без раздражающего стремления постичь факты и причины»*. Важно помочь пациенту ослабить контроль над внешней и внутренней реальностью и позволить себе выдерживать неопределенность, не проваливаясь моментально в состояние тревоги.

Жизнь современного человека забита обязанностями, уведомлениями, контактами — очными и онлайн, он постоянно завален работой, и времени на переваривание и интеграцию эмоций остается всё меньше. Подобно импровизационному спектаклю, жизнь порой переживается как череда «фактов», происходящих где-то снаружи и разящих нас наповал: *«Меня бросил парень»*, *«Меня уво-*

лили», «Папа умер», «У нас с Джулией было свидание». Это события, приходящие извне, как черепица, падающая с крыши во время грозы, без прочной связи с эмпирическим селф (Bolognini, 1991). Возможностей для интеграции становится меньше (нехватка времени для воспоминаний и переосмысления собственной жизни, ожиданий на будущее...), это приводит к состояниям неспецифического возбуждения, к тревожному беспокойству и другим неприятным ощущениям, трудно репрезентируемым и очень расплывчатым. Нередко возникает чувство внутреннего сумбура — тревожного или депрессивного — при отсутствии внешних событий, которые могли бы его объяснить: *«Мне плохо, но я не знаю почему»*.

Эти переживания приводят в терапию людей с такими же запутанными и амбивалентными запросами: они хотят измениться, но не хотят вовлекаться в отношения. Неудивительно, что как только им удастся найти способ заглушить тревожное или беспокойное состояние, многие пациенты (можем сказать, нетерпеливые<sup>40</sup>) быстро отказываются от стремления узнать себя глубже. Они немедленно прерывают этот мимолетный контакт с собой и переключаются на другое.

Хотя верно говорят, что терапия начинается еще до сессии, на уровне ее психической репрезентации, также верно и то, что сегодня мы встречаем множество людей, которые довольствуются только самым контактом с терапевтом. Их намерение, похоже, состоит не в том, чтобы понять себя и тем более измениться, а чтобы всего лишь

40 Игра слов: *pazienti* также означает «терпеливые», *impazienti*, соответственно, «нетерпеливые». — Прим. пер.

почувствовать себя менее одинокими, пока не нахлынет раздражение от отношений с другим и с самим собой. Первая трудность, с которой мы сталкиваемся, заключается именно в том, чтобы заметить тот короткий момент контакта, который заставляет человека высказать свой запрос: зачастую сам факт его высказывания вслух уже, кажется, приносит достаточное удовлетворение. Понятно, что это удовлетворение мимолетное и иллюзорное, но в какой-то мере оно успокаивает. Словно человек говорит: *«Доктору я позвонил, но дальше не пойду. Я ведь не собираюсь действительно ходить на терапию!»*

Нечто в этом роде произошло несколько дней назад с одним коллегой: человек обратился к нему по совету своего лечащего врача, записался на прием, явился вовремя в назначенный день, уселся и сразу сказал, что хотел бы, чтобы его терапевтом была женщина.

Если бы мы смотрели на эту ситуацию только с точки зрения обычной реальности, консультация могла бы завершиться очень быстро. Однако тогда мы упустили бы возможность дать этому человеку точку опоры, за которую он мог бы ухватиться, чтобы получить необходимую помощь. Вместо этого мы можем рассмотреть его запрос в том виде, в каком он был сформулирован (то есть с явным сопротивлением терапии), как единственный способ этого пациента продемонстрировать нам свой внутренний мир.

Мы так привыкли говорить о реальности, что люди буквально цепляются за мысль о ней как за что-то объективное, внешнее, и интерпретируют каждый аспект своего повседневного поведения с рациональной точки зрения. Поэтому терапевту следует отложить в сторону эту

внешнюю реальность, понимаемую как конкретность коммуникаций, чтобы отыскать ту эмоциональную истину, которая мешает пациенту, сдерживает его и зачастую принуждает ходить по одной и той же узкой дорожке. Представим на мгновение, что мы обращаемся к сновидческой способности психотерапевта. Как предлагает Антонино Ферро (Ferro, Nicoli, 2017), применим формулу «Я видел сон о том, что...», трансформируя конкретные данные в символическое сообщение. *«Я видел сон о том, что я хотел бы встретиться с терапевтом-женщиной»*, — говорит нам пациент. Будет очень интересно поговорить с пациентом о том, с какой женщиной-врачом он хотел бы встретиться, какой он ее себе представляет, чего ожидает от нее...

Таким образом, терапевт должен обязательно открыться символическому измерению, как если бы то, что приносит пациент, было не чем иным, как началом фильма. Если пациент записался на прием к терапевту-мужчине, даже если он хочет на терапию к специалисту-женщине, значит, именно с этого нам и нужно начинать — с этой амбивалентности, которую необходимо исследовать; иначе консультация завершится, не добавив ничего нового к тому, с чего она началась.

Поэтому работа по установлению контакта, проведению беседы и психологической консультации становится такой непростой сегодня, ведь мимолетный контакт часто сменяется быстрым отдалением. От профессиональных навыков терапевта зависит, сможет ли он превратить этот микроконтакт в проблеск близости и удержать в достаточной мере открытым канал отношений, чтобы не дать пациенту сразу же отстраниться и уйти.

## **Мортиция, зрительница собственного желания**

Именно в такой ситуации я знакомлюсь с Мортицией, молодой женщиной, студенткой школы психотерапии. На первой сессии она долго рассказывает о стажировках, часах практики, которые нужно пройти для школы, о предыдущем опыте. Слушая ее, я задумываюсь, нужен ли ей терапевт или просто сертификат.

Я спрашиваю: «Вы действительно хотите заниматься психотерапией, или вы здесь потому, что это необходимо для учебы?» Предлагаю ей подумать об этом и даже подождать несколько месяцев, если нужно. Она уходит слегка разочарованной.

Вторая сессия начинается с того, что девушка внезапно задает почти провокационный вопрос: «Как можно быть уверенной, что собственный отец не домогался тебя в детстве?» Она произносит это с любопытством, без страха. Такое чувство, будто она хочет забросить приманку, чтобы посмотреть, как я отреагирую.

Боли нет, есть контроль. Пациентка, по всей видимости, стремится удерживать власть на аналитической сцене: привлекает внимание, интригует, но не раскрывается по-настоящему.

Я соглашаюсь взять ее в терапию, понимая, что нам с ней придется работать не на ментальном уровне, а на инстинктивном. Мортиция всегда опаздывает на десять минут. Это маленькая деталь, но она соответствует общей динамике: пациентка сама решает, когда приходить, сколько давать, сколько брать. Она всегда старается говорить какие-то правильные вещи

и изо всех сил пытается сама интерпретировать свое поведение.

## Сон о трупе

Спустя несколько месяцев Мортиция рассказывает сон: «Я одета как девушка начала XX века, со мной в комнате молодой Леонардо Ди Каприо. У изножья кровати с балдахинном стоит гроб, в нем лежит красивая мертвая женщина. Я закрываю дверь и предлагаю Ди Каприо заняться с ней сексом. Он сначала колеблется, но потом соглашается. Сцена меняется: теперь мертвая женщина лежит на кровати в объятиях Леонардо Ди Каприо. Они вместе курят сигарету, как сообщники, а я смотрю на них со стороны».

Пациентка связывает этот сон с предыдущей сессией, на которой мы говорили о ее матери. Когда Мортиция была маленькой, ее мать после развода с отцом приводила домой слишком много мужчин, и это длилось годами. Таким образом, как мать она была мертва, убита самкой внутри нее, «или, возможно, моей детской злостью», как предполагает Мортиция.

В этих рассуждениях о жизни и смерти, вине и удовольствии, о мертвом первичном объекте, на мой взгляд, слишком много психоанализа и слишком мало живых эмоций.

Вскоре после этого Мортиция рассказывает, что недавно проверяла телефон своего парня, подозревая, что он скрывает что-то насчет своей бывшей девушки.

Речь идет о контроле и ревности, но не касается главной темы — секса, которая висит в воздухе невысказанной, и поэтому я спрашиваю напрямую:

— А что насчет сексуальности, как вы ее ощущаете?

— С двумя моими последними парнями были проблемы: с одним они возникали время от времени, а с другим просто полный крах. С моим нынешним парнем всё началось с того, что я почувствовала к нему влечение. Это могла быть интрижка на одну ночь, но мы неплохо поладили и поэтому остались вместе. Поначалу я пыталась получать телесное удовольствие, не вовлекаясь эмоционально. Ну да, в итоге я попалась! Что ж, в таком случае лучше использовать дублершу. А если она еще и мертвая, вообще прекрасно, она ничего не чувствует!

Мортиция рассказывает, что во всех ситуациях всегда готовит себе путь к отступлению, чтобы иметь возможность спастись, если возникнут сложности.

— Иначе это было бы рискованно! Кто знает, что могло бы случиться, если бы я полностью погружалась в отношения.

— Вы могли бы потерять голову?

— Не знаю, но если бы я так включалась во все отношения, не представляю, как бы я из них выбиралась, а так я знаю, что до сих пор всегда спасалась.

В этом случае я предпочел не углубляться в интерпретацию сна, как если бы мы были двумя исследователями, наблюдающими внутренний феномен пациентки (мать, мужчины, исключенность). Это интересные, но понятийные аспекты, и они, как мне кажется, только подпитывали бы рационализацию пациентки — всё больше психолога и всё меньше просто незрелого ребенка.

Я решил расширить фокус нашего интереса и взглянуть на то, что Мортиция переживает сегодня, на роль



удовольствия и связи в аффективных отношениях: «Я всегда готовлю себе путь к отступлению!»

Есть еще один уровень сна, и я его не интерпретирую: это его значение в контексте переноса. Я мог бы сказать что-то вроде: «Даже здесь вы, как и во сне, готовите себе путь к отступлению, поскольку сидите в кресле и отказываетесь лечь на кушетку, где не сможете меня контролировать. Вы хотите держать меня под наблюдением, чтобы я не преподнес вам никаких неприятных сюрпризов, но в результате теряете контакт с собой». Это была бы корректная интерпретация.

Проблема вот в чем: кто именно выслушал бы ее? Боюсь, что я говорил бы с мертвой женщиной, а маленькая девочка, живая, но испуганная, пряталась бы в углу, считая себя еще более никчемной. «Я не знаю, как быть в анализе!»

Вот что я имею в виду, когда говорю о том, чтобы *«быть с пациентом там, где он есть»*.

Описание сцены или внутреннего процесса пациента само по себе не лечит, если в данный момент пациент не способен учиться на опыте. Если сон представляет собой хорошую сценографическую репрезентацию происходящего, нет необходимости немедленно исчерпывать его функцию, раскрывая его бессознательное значение. Сон можно удерживать в голове и использовать как карту, чтобы ориентироваться, где мы сейчас находимся. В данный момент я аналитик/Ди Каприо, который интеллектуально флиртует с мертвой частью пациентки: так поле защищается от пугающей встречи двух незнакомых людей, которые боятся того, что может произойти между ними. Но об этом говорить еще рано. Вместо

этого, мне кажется, лучше наблюдать за мертвой женщиной и маленькой девочкой и попытаться понять, чем занимается Леонардо Ди Каприо.

## Неидеальное тело

В следующие месяцы пациентка постоянно колеблется между двумя полюсами: молодая девушка-психолог, которая хочет выглядеть компетентной, и девочка, которая боится, что она никчемна. Однажды она приходит сердитой:

— Я хотела принести вам торт, но он не получился.

Я вспоминаю сон. Я всё еще не интерпретирую его, но использую для интерпретации.

— Идеальная пациентка с идеальным тортом.

— Да!

— Но ведь идеальное — это уже прошедшее, завершённое... (мертвое, добавляю я про себя). Если мы будем ждать идеальности, всё уже закончится. И я сегодня не попробую никакого торта.

— Но я его не выбросила. Я сама его съем.

Она лукаво улыбается. Ее неидеальный торт, как и ее собственная неидеальность, еще не может быть разделен с другим, но уже может вызвать улыбку.

Несколько недель спустя Мортиция опаздывает на двадцать минут. Она в ярости на себя, плачет, потому что сделала всё, чтобы приехать вовремя, но в последний момент всё равно задержалась.

— Наверное, внутри вас сейчас идет ожесточенная борьба, — комментирую я, чтобы обозначить, что вижу ее мучения.

— Я ничего не знаю о том, как проводить анализ, я ничего здесь не контролирую. Единственное, что я могу контролировать, — это опоздание, но если я опаздываю, то отнимаю что-то у себя самой.

— Похоже, вы увязли. Единственный способ не встречаться со мной по моим правилам — это вообще не встречаться со мной. Или же вам придется согласиться быть со мной, не зная, как это делается. Это вас пугает.

На следующую сессию она приходит вовремя. Возможно, впервые. Она хотела бы выбрать второго супервизора, но не уверена: «А что если я запутаюсь? Что если не буду знать, кого слушать?»

Я обсуждаю вместе с ней, как трудно найти свою идентичность психолога через выбор супервизоров.

— К сожалению, вас я не могу выбрать своим супервизором, доктор, — замечает она.

Я думаю: и правда жаль... Черт! Она меня соблазняет. Я молчу, осознавая риск превратиться в Ди Каприо, который занимается сексом с очаровательной мертвой девушкой-психологом, в то время как маленькая девочка стоит в углу и наблюдает за нами.

Повисает выжидающее молчание, затем Мортиция рассеянно сообщает о том, что ее мать начала терапию. Потом говорит о своем парне, который тоже начал терапию. (И я думаю, что, возможно, ей тоже нужен терапевт, а не какой-то начинающий супервизор).

— Я больше не знаю, о чем говорить, — заключает она. — Если я прихожу вовремя, времени остается слишком много...

— Это хорошо или плохо?

— Свобода может привести к тому, что я и люди вокруг меня будем выбирать не одно и то же.

— Если я изменюсь, — даю я голос одной из ее частей, — что со мной произойдет?

— Я хочу остаться такой, как есть. Я знаю, что тогда никакого безумия не случится.

Она замолкает, обдумывая эту новую перспективу. Затем тон ее голоса меняется, становится спокойнее: «Но если я позволю себе расслабиться, я, возможно, начну чувствовать больше. Мне страшно думать, что я словно под анестезией. А ведь я могу чувствовать и удовольствие».

### **Заключение: только то, что неидеально, по-настоящему живое**

В ходе этого процесса медленно формировалась терапевтическая близость: пространство, где пациентка могла позволить себе быть вовлеченной в отношения, не ощущая это как вторжение. Речь идет не о слиянии, а о возможности оставаться живой в отношениях, которые невозможно полностью контролировать. В случае с этой пациенткой неидеальность стала дверью, ведущей к ее витальности. В ее нарциссическом языке — языке контроля, имиджа и страха, что ее сочтут неправильной, — открылась лазейка, позволившая ей выдерживать свое незнание, неудачи, невозможность нравиться всем и всегда.

Современным людям необходимо в процессе лечения научиться проживать значимые объектные отношения, основанные на признании другого. Им нужен глубокий

реляционный опыт, позволяющий передавать содержания, необходимые для личностного роста, соединять внутренний и внешний миры, распознавать свои эмоции и наделять их значением.

Именно здесь психоаналитическая работа демонстрирует свою силу: с ее помощью люди меняются, позволяя себе вовлекаться в отношения, она восстанавливает бионовскую «негативную способность», то есть способность пребывать в неопределенности, не проваливаясь в тревогу. То, «как» люди пребывают в отношениях, не менее важно, чем то, «что» обсуждается в сессии (Nicoli, Bolognini, 2022). Поэтому, как подчеркивает Огден (Ogden, 2021), способ присутствия в сессии уникален для каждой аналитической пары и различается от пациента к пациенту, даже если аналитик остается одним и тем же. Для построения значимых отношений мы должны уметь сопоставляться также с отщепленными и диссоциированными частями и выдерживать столкновение с защитами, воздвигнутыми против реляционной близости, переживаемой как опасная ловушка.

В эпоху недоверия, когда многие люди, особенно молодые, страдают от панических атак на автостраде, где нет съезда, мы не можем выстраивать долгие терапевтические пути, игнорируя индивидуальные потребности и недоверие пациентов, но и не можем позволить себе срезать дорогу. Напротив, мы должны гарантировать им, что у них есть время и доступ к нам, чтобы они могли узнать нас и как людей, и как специалистов, оценить наши методы работы и развить доверие, необходимое для того, чтобы отправиться в это далекое путешествие-самоисследование, которое называется психотерапией и кото-

рое постепенно глубинным образом трансформирует человеческую личность.

Сегодня запросы многих пациентов на самом деле именно об этом, даже если они не осознают этого: о месте, где они могут быть, не контролируя всё вокруг. О месте, где можно сновидеть самих себя вместе с другим человеком.

Наша задача — сновидеть их живыми, а не идеальными.

Возвращать тепло их телам и отношениям, которые общество Нарцисса стремится забальзамировать.

И напоминать, в том числе и самим себе, что по-настоящему живое только то, что неидеально.



# Говорящие действия и совместная работа психиатрии и психоанализа в лечении эмоциональных срывов у подростков

*Моника Бомба*

## Введение

Подростки, поступающие в детско-подростковое психиатрическое отделение, нередко пережили или переживают эмоциональный срыв, для которого характерна утрата чувства экзистенциальной целостности.

Если отбросить диагностические ярлыки, эти подростки пережили глубокое эмоциональное крушение. С первой встречи они демонстрируют острую потребность в том, чтобы чужеродные ощущения в их телах — переживаемые как мучительное, дезинтегрирующее, абсурдное и пугающее присутствие — смогли трансформироваться в более выносимое телесное пространство,

где тревога рассеется, а переживания будут наделены аффективным значением.

Это подростки, прибегающие к суицидальным действиям, ограничивающие потребление пищи или проявляющие агрессию. Они словно бросают вызов жизни, которую не в силах выдерживать, находясь под властью «конкретного» мышления и зрительных, слуховых, проприоцептивных ощущений, которые пугают их так, словно они оказались в ловушке *телесного галлюциноза* (Bomba, 2023). Их дестабилизирует тело, переживаемое как чужое. Это состояние сопровождается тем, что можно описать как «конкретный язык», аффективно бедный и кажущийся пустым, негодным для осмысленной коммуникации. Именно эту особенность мы постараемся осветить в нашем клиническом описании после краткого общего введения.

## **Примитивная психическая организация и терапевтическая трансформация**

Когда мы наблюдаем примитивное состояние психики, мысли и чувства пациента кажутся фрагментированными, словно кусочки замороженного сенсорно-психического пазла. Однако при эффективной терапии в условиях госпитализации пациенты как будто вновь оживляют свое тело — а вместе с ним и психику — и, подобно новорожденным, проявляют внимание и любопытство к ощущениям, возникающим внутри них в состоянии относительного спокойствия.

Эта трансформация нестабильна; скорее, пациенты колеблются между фрагментарными, сенсорными ре-



жими функционирования и переживаниями психосоматической интеграции. Речь не идет ни о новой линии развития, ни о полном излечении за время краткой госпитализации. Скорее, это колебание между психическими состояниями подобно двери, осторожно открывающейся навстречу новым возможностям роста. Это движение имеет клиническую ценность.

Клинический опыт показывает, что работа с такими пациентами требует развития семиотической чувствительности, клинической интуиции и бдительного прислушивания к их коммуникациям во всех формах. Интеграция психоаналитического слушания бессознательных коммуникаций с психиатрической практикой сделала такую работу возможной.

Это также позволило разработать особый подход к слушанию и лечению психических срывов у подростков. Этот способ работы с пациентами, страдающими от тяжелых острых расстройств психики, будет проиллюстрирован клиническим примером и концепцией «говорящих действий» Ракамье.

## Роза

Роза — подросток, госпитализированный с тяжелой формой нервной анорексии. Крайне истощенную, ее забрали из дома и отвезли в больницу на скорой. Моя коллега, обнаружившая ее в таком состоянии накануне, организовала ее перевозку. Роза заперлась в спальне, которую делила с матерью и сестрой. Она лежала на кровати под грудой одеял и свитеров, в темной, грязной и небранной комнате. Тот факт, что психиатр специально пришла

к ней домой, проявив искреннюю заботу и участие, убедил Розу открыть дверь спальни «всего на минуту». Так моя коллега смогла ее увидеть, и на следующий день скорая забрала Розу в больницу.

Когда она поступает в отделение, встречающая ее медсестра с тревогой говорит, что Роза «похожа на труп», на «живой скелет». Роза словно играет роль Смерти, она действительно рискует умереть из-за сильнейшего истощения. Она крайне возбуждена и сердита и отказывается от госпитализации. Мне предстоит экстренный и сложный прием разъяренной, враждебно настроенной пациентки.

Когда я прихожу к Розе, она пребывает в состоянии сильного возбуждения и агрессии по отношению ко всем вокруг. Она никого не подпускает, прогоняя любого, кто пытается приблизиться к ней, пинками и руганью. Остальные пациенты собрались в маленькой общей комнате и выглядят испуганными; некоторые плачут. Она кричит, что хочет уйти и что ей нужна мать, и колотит своими костлявыми кулаками в запертую дверь отделения.

Подойдя ближе и взглянув на нее, я вижу маленького ребенка, сердитого и напуганного. Почти автоматически я хватаю ее за запястья. Роза поворачивается ко мне и с изумлением спрашивает: «Что вы делаете?!» Я думаю о том, какая она худенькая, и понимаю, что легко могу взять ее на руки, поэтому решаю поднять ее. Мне кажется, что Роза спонтанно следует моему порыву, позволяя мне это, хотя и с некоторым удивлением. Пока я несу ее в палату, расположенную на другой стороне коридора, я чувствую изменение мышечного тонуса. Вначале мы обе зажаты, скованны. Мышцы Розы сильно напряжены,

ее тело ощущается угловатым и твердым. Посреди отделения, в этой странной и непривычной ситуации, я замечаю медсестру, которая наблюдает за нами не вмешиваясь; я думаю о Розе, которая теперь молчит и словно дает мне телесное разрешение нести ее, и чувствую, как напряжение уходит из моего тела. Спустя несколько мгновений Роза расслабляется и становится «мягче». Тело Розы, которое раньше, казалось, опиралось только на ее кости и мышцы, теперь доверило свой вес мне. Роза начинает тихонько плакать, это плач, полный печали. Она шепчет: «Я одна, у меня никого нет». После первого полноценного контакта Роза начинает есть и разговаривать со мной. Она рассказывает об «атавистическом холоде», который пронизывает ее «до костей» (избавиться от него невозможно, даже лежа под кучей одеял и одежды) и изматывает, заставляя беспокойно ходить из угла в угол.

Поэтому я прошу медсестру, которая, как я знаю, может быть и ласковой и твердой, завернуть Розу в простыню и одеяло, как младенца, укутав также голову.

Затем я сажусь рядом, и Роза говорит: «Я выгляжу как египетский фараон!» Ей наконец становится тепло; она начинает рассказывать о себе и своей жизни «до болезни», когда она была хорошенькой, любила слушать музыку и красилась перед прогулкой с друзьями.

Она спрашивает: «Я чуть было не умерла, да? Мое сердце могло остановиться?» — словно этот жест обозначил *цезуру* между «до» и «после». Теперь, став другой, «нынешняя Роза» смотрит на «прежнюю Розу» так, словно всё это уже позади, словно она стала новой Розой, не имеющей ничего общего со смертью и с тревогой, которая переполняла нас раньше.

В первые дни ее пребывания в отделении я заметила, что Роза ищет меня взглядом и несколько секунд смотрит на меня, чтобы убедить себя съесть немного больше, или поговорить со своим отцом, или согласиться на действия медсестер. Этот особенный зрительный контакт, казалось, был ключом к ней. Теперь мне было позволено войти в ее мир, который она выстраивала заново.

Когда Розе стало лучше, мы смогли приступить к первым психологическим сессиям. Она предпочитала лежать на кушетке и всегда приносила с собой светло-голубое одеяло, то самое, которым мы укутали ее в первый день.

В течение месяца в больнице Роза говорит о желании превратиться в жидкость, умереть, медленно растворяясь. Это затопляющее желание, которое она переживала в недели, проведенные взаперти с матерью и бабушкой, иногда возвращается и теперь, по вечерам, когда ей бывает одиноко. Она рассказывает о том дне, когда моя коллега пришла к ней домой и спасла ее: «Когда дверь открылась и весь этот свет хлынул внутрь, что-то произошло... Я поняла, что ей не всё равно».

Роза смогла дать жизни еще один шанс и приняла (и поняла) необходимость остаться в терапевтическом реабилитационном центре, не возвращаясь домой после выписки, пока ей не станет лучше. В один из последних дней она рассказала сон: *«Я в большом доме... стены окрашены в мягкие цвета, персиково-розовые... Я не одна, рядом со мной люди, и я участвую в общем проекте. Мы должны что-то построить, не знаю, что именно... Я знакомлюсь с человеком, должно быть, он руководит всем этим, потому что у него есть план проекта, чтобы направлять работу»*. Роза связывает этот сон с планом ее

лечения в терапевтическом реабилитационном центре и испытывает чувство безопасности в присутствии мужчины, который будет вести работу с ней и группой.

Результаты лечения Розы, которое началось в больнице и продолжалось в реабилитационном центре, а затем в течение пяти лет психоанализа, были весьма удовлетворительными.

## Некоторые размышления *après coup*<sup>41</sup>

У психотических пациентов и нередко у пограничных слова не содержат никаких сообщений. Их смысловая пустота порождает скорее «мышление через действия», чем «мышление через мысли», и сами слова могут переживаться такими пациентами как потенциальный обман (Racamier, Taccani, 1999a).

По этой причине психотические пациенты часто ненавидят слова и, не в состоянии обходиться без них, стремятся их «расходовать» и истощать (Racamier, Taccani, 1999b).

При первой встрече в отделении кричащая и разъяренная Роза кажется облеченной в подобие *второй кожи*, способной звучать и защищающей ее от «бесформенного ужаса» (Ogden, 1989): она застревает на одном слове и повторяет его бесчисленное количество раз, словно пытаясь израсходовать все слова до конца. Крича и повторяя «хочу к маме», она, казалось, пыталась остановить мысли и прекратить чувствовать эмоции, стоящие за этой фра-

41 Последействие. Фрейд использовал термин *Nachträglichkeit* (нем.) (во французском *après-coup*, в итальянском *risignificazione*) для обозначения процесса, при котором эмоциональные события прошлого могут обрести новый смысл в свете текущего опыта. — Прим. ред.

зой, тем самым усиливая свою психическую неподвижность. Слова были связаны и с мыслями, которые она хотела и должна была отвергнуть, и ее повторяющиеся крики были способом израсходовать их, как бывает, когда непрерывно колотят по чему-то, пока вещь не выйдет из строя.

Перед Розой встала парадоксальная дилемма: общение — это риск смерти, отсутствие общения — это смерть. В контексте этой дилеммы слова скорее разделяют людей, чем служат средством коммуникации. Они обозначают отсутствие, а не присутствие, и действие, терапевтическое действие, может иметь более существенную ценность в отношении переживания присутствия и психической коммуникации.

Хокман (Hochman, 1974) и Ракамье (Racamier, 1998) предлагают определять терапевтические действия как говорящие действия, подчеркивая тем самым, что лечение, соответствующее потребностям психотического или пограничного пациента, происходит именно посредством говорящего действия. Только при союзе действия и слова становятся возможными смысл и значение. Говорящие действия призваны доносить сообщение. Они транслируют для пациента присутствие и понимание со стороны терапевта, позволяя почувствовать его рядом и пережить опыт понимания. Действие коллеги, когда она вошла в комнату Розы, открыв дверь, чтобы увидеть ее, и следующий жест, когда Розу обхватили за талию и взяли на руки, по-видимому, явились результатом настройки на довербальные, досимволические, примитивные, неонатальные потребности Розы. Это позволило осуществить первую коммуникацию, через тело, в то-

ническом диалоге «твердое-мягкое», «холодное-теплое», на который Роза естественным образом откликнулась. Это действие показало Розе, что она не одна, и позволило ей выразить свое экзистенциальное одиночество. Я полагаю, что сонастройка с Розой произошла на крайне примитивном уровне, в области сенсорных проприоцептивных переживаний. В движениях первой встречи с Розой мы можем мельком уловить переживание *первичной сенсорной близости*, позволившее пациентке заложить основы для обретения поверхности, на которую можно опереться, получить и организовать опыт пространства, времени и границ селф.

Укутанная в одеяло Роза начинает грезить о том, что она похожа на египетского фараона; мумия-смерть всё еще присутствует в этом образе, но приобретает менее конкретное значение и, во всем своем величии, отсылает к чему-то ушедшему очень далеко в прошлое. Восприятие времени меняется, и между нынешней Розой и прежней, кричащей Розой словно возникает *цезура*. Ужас смерти уходит в прошлое; Роза говорит об опасности (которая всё еще сохраняется) так, как будто это уже отдаленное воспоминание.

Психическое чувство безопасности сопровождается физическим ощущением чудесного спасения. В тот момент ужаса перед рассеиванием (или растворением) собственного селф в безграничном пространстве действие — бережное укутывание Розы в простыню и одеяло в присутствии нас с медсестрой — помогло ей почувствовать поддержку второй кожи. Таким образом, *говорящий объект* (Racamier, Taccani, 1999b) — одеяло — усилил предшествующее говорящее действие, предоставив па-

циентке осязаемую, плотную, защищающую и поддерживающую сенсорную и межличностную поверхность.

Кроме того, особый взгляд, которым Роза смотрела на меня позже, по-видимому, также выполнял формирующую и контейнирующую функцию, но уже на некоторой дистанции.

С момента встречи с нашей коллегой, которая, открыв дверь в спальню Розы, сделала первый шаг к разрушению симбиоза между девочкой и ее матерью, Роза постепенно смогла воспринимать рабочую группу в качестве «родительского» (одновременно отцовского и материнского) контейнера.

## Заключение

Результатом процесса, начавшегося со встречи с нашей коллегой в доме пациентки, стало то, что Роза смогла воспринимать рабочую группу как еще одну форму «материнского контейнера» (Bion, 1959). Вместе с тем я полагаю, что и действие, и группа выполняли также функцию отцовского контейнера и что с самого начала госпитализации Розе было предоставлено дифференцирующее окружение, сыгравшее основополагающую роль в лечении. Тонический диалог телесного взаимодействия с Розой, выразившийся в последовательности действий — входе в ее комнату-логово, захвате запястий, подъеме ее тела, а также в особом взгляде, одновременно сдерживающем и одобряющем, — воплощал и отцовскую функцию, которая разрывала симбиоз и открывала возможность встречи с другим, существование времени, пространства и границы.



Телесное взаимодействие с Розой открыло доступ к более широкому контейнированию, которое стало возможным благодаря терапевтическим отношениям, рабочей группе и больничному учреждению. Это расширение рамок позволило Розе постепенно трансформировать ее отчуждающие и чужеродные ощущения, ее телесные галлюцинаторные переживания в восприятия, которые смогли найти место в моей психике и в терапевтическом сеттинге, превращаясь затем в аффекты, а потом в мысли и значения.

Спустя год после госпитализации, когда Роза уже жила в терапевтическом реабилитационном центре, она попросила меня провести с ней психоаналитическую работу. Я предложила ей курс психоанализа по четыре сессии в неделю, и он продолжался в течение следующих пяти лет. Ее путь был долгим и порой омрачался трудностями даже после той первой встречи в больнице, но я убеждена, что именно цезура, представленная этим событием, позволила ей обрести личную надежду на жизнь. Так началось лечение Розы: возможность говорить ради коммуникации и возможность начать играть.

# Носки аналитика. Самораскрытие, границы и интерсубъективная игра

*Лука Николи*

## **Носки доктора Джекилла: любопытство и эмоциональная вовлеченность**

У доктора Джекилла, молодого терапевта, с которым мы работаем онлайн уже несколько лет, появилась новая пациентка, Луиза. Это глубоко верующая женщина, преданная своему крайне строгому отцу. Ее муж весьма педантичен, их отношения носят в основном интеллектуальный характер. Под всем этим, похоже, скрывается отщепенная часть, полная эротизма. Порой Джекилл ощущает себя соблазняемым или даже поглощаемым.

Уже некоторое время Луиза с удовольствием комментирует яркие носки психотерапевта. В ответ Джекилл улыбается, но ничего не говорит. На следующих сессиях пациентка продолжает обращать внимание на его носки, и Джекилл всё больше боится быть втянутым в вихрь

переноса, выхода из которого он не знает. Он чувствует себя преследуемым своей пациенткой и хотел бы дать интерпретацию, но боится оттолкнуть ее. Он уязв.

Меня позабавила эта сцена, особенно когда он показал мне с экрана свои носки. Мне приходят на ум школьники, которые демонстрируют друг другу обновки, и я спрашиваю Джекилла: «Почему бы вам не сказать пациентке что-то вроде: “Ага, необычные носки, правда?”»

Кажется, Джекилл чувствует облегчение, он отвечает, что теперь ему не так страшно. В течение следующего месяца он реагирует на комментарии Луизы более расслабленно и с юмором; женщина постепенно перестает акцентировать внимание на его носках, ограничиваясь лишь улыбкой.

Месяц спустя Джекилл возвращается на супервизию с новой проблемой: в этот раз пациентка сказала ему, что видела, как он парковался перед кабинетом, а он ее даже не заметил; он почти уверен, что она за ним следит.

«Что мне делать?»

Я отвечаю: «А вы спросили ее, хорошо ли вы припарковались?»

Доктор Джекилл, как и многие из вас (или из нас), обучался в традиции классического анализа, на основе моноперсональной модели: молодому терапевту, закончившему программу, в которой пропагандировались воздержание и нейтральность, трудно предстать перед пациентом как целостная живая личность. Четыре года назад, когда мы с ним начали работать, целью его взаимодействия с пациентами было побуждать их к размышлению о себе, а отношения между пациентом и терапевтом главным образом были направлены на возникновение пере-

носа и воспроизведение аффективной динамики детства. Прямые вопросы следовало интерпретировать, чтобы ситуация переноса не повторялась, а была затем вспомнена и переработана (Freud, 1914).

Такой подход полезен при работе с невротиками, если они способны выдерживать фрустрацию, но может реактивировать травму у тех пациентов, которые в детстве не чувствовали себя вправе задавать вопросы своим родителям и получать от них правдивые ответы (Ferro, Nicoli, 2017). Работа именно с такими пациентами побудила многих аналитиков рассматривать аналитическую сессию как встречу двух субъектов (Mitchell, Aron, 1999; Civitarese, 2016; Momigliano, 1984).

## **Между моноперсональной традицией и intersубъективным измерением**

Некоторые начинающие терапевты, сталкиваясь с трудностями при встрече с негативными эмоциями своих пациентов и руководствуясь стремлением к большей аутентичности, склонны поддаваться искушению прибегнуть к «реальности», даже если это в конечном счете ограничивает развитие символического измерения анализа (Davis, 2002; Ferro, 2008). Как и во всякий переходный период, литература, обучение и клиническая практика расходятся в разные стороны, возлагая на каждого аналитика задачу выполнить персональный теоретико-технический и стилистический синтез, чтобы разрешить этот конфликт (Gabbard, Ogden, 2009).

При этом нередко ощущается настоящий разрыв между тем, что «следовало бы сделать», согласно общеприня-

тым и идеальным канонам, и тем, что человек действительно делает, принимая на себя индивидуальную роль, что одновременно и освобождает, и создает риск.

В частности, многие молодые аналитики (и не только они) воспринимают личные вопросы как атаки на сеттинг или на них самих. Фраза Луизы «на днях я видела, как вы парковались» для Джекилла звучит как предупреждение мафиози, имеющее явный оттенок преследования: я слежу за тобой!

Классическим ответом было бы молчание. Его сложнее применить при встречах лицом к лицу, которые для многих из вас, мои читатели, являются основным форматом работы. Конечно, молчание остается возможным вариантом, если оно переживается как возможность исследования, без немедленной обратной связи от аналитика (Bolognini, 2010, 2016a).

Ощущение принятия или отвержения молчания зависит от того, насколько аналитик в состоянии выдерживать давление со стороны пациента, нуждающегося в признании. Именно аналитик может оздоровить поле или, наоборот, отреагировать на преследующую тревогу, подкрепляя ее.

Вместо этого можно прибегнуть к интерпретации, «верховному» инструменту психоанализа. Однако и в этом случае ее функция зависит от внутренних процессов терапевта.

Если аналитик ощущает преследование и угрозу своей профессиональной идентичности или роли (своего рода «атака на носки аналитика»), ему не составит труда перейти в защитную позицию, ссылаясь на внутренние конфликты пациента и динамику переноса. Я называю такие интерпретации «затыкающими рот»: эти аналити-

ческие интервенции тоже могут передавать «истинные» содержания, но их защитная функция настолько заряжена агрессией, что они фактически эквивалентны взбучке (Bolognini, 2010; Nicoli, 2020).

Вернемся к доктору Джекиллу и Луизе: какой бы ни была реакция аналитика на провокации/запросы пациента — молчание, интерпретация, прямой ответ или что-то еще, — она будет представлять собой репрезентацию способа, которым поле выражает интерсубъективную истину этого момента.

В данном случае первое контейнирование переживания преследования происходит в процессе супервизии (Ogden, 2008; Ferro, 2021). Благодаря супервизионной дистанции я могу представить себе ситуацию как сцену, где двое мальчишек демонстрируют друг другу обновки из торгового центра. Сновидение сессии — интерсубъективная конструкция, поскольку вводит в аналитическое поле ряд содержаний, не относящихся к интрапсихическому миру пациента, но возникающих в его отношениях с аналитиком и, во вторую очередь, с супервизором.

Здесь есть восхищение, соучастие, волнение.

В моем сегодняшнем понимании психоанализа терапевт помогает развернуть сновидение/игру/драму, которые пациент не может прожить самостоятельно (Bion, 1962; Winnicott, 1971; Ogden, 2004).

Цель моей интервенции не столько в том, чтобы предложить какую-либо интерпретацию (их может быть бесконечное множество), сколько в том, чтобы очистить поле от врагов близости (Nicoli, 2023a).

Первый враг — это риск эротизации аналитических отношений, возникающий тогда, когда аналитик не спо-

собен или не готов принять проявления инфантильного любопытства. Второй враг — риск, что анализантка вернется к роли «хорошей пациентки», занимая более приемлемую для терапевта позицию. Многие анализы — да пожалуй, все, с определенной точки зрения, — ограничены неспособностью аналитиков выдерживать дискомфорт выше привычного уровня (Ferro, Nicoli, 2017).

Я помог Джекиллу понять, что вовсе не обязательно — и, возможно, даже вредно — приводить на сессию свое внешнее «я», того, кто обожает носки, подаренные женой на Рождество, или кто вбегает, запыхавшись, в кабинет за несколько минут до начала сессии, потому что перед школой его дочери образовалась пробка. Как мы увидим чуть позже, открытое предъявление элементов собственной жизни или собственного способа функционирования не соответствует потребностям пациентки в контакте.

Чтобы объяснить ситуацию с технической точки зрения, я иногда прибегаю к метафоре: я предлагаю, чтобы доктор Джекилл (или доктор Николи, или доктор Смит...) полностью погружался в происходящее, в то время как мистер Хайд (или Лука, или Джейн...) оставался бы на расстоянии около метра позади кресла, в безопасности, в своем личном пространстве существования и мышления.

## **Сохраняя приватность аналитика: на метр позади кресла**

Конкретная реальность, которую мистер Хайд переживает за пределами сессии, не более подлинна, чем intersубъективное «здесь и сейчас» доктора Джекилла с Луизой. В этой метафоре доктор Джекилл — это персонаж, совместно соз-

даваемый и заново изобретаемый во взаимоотношениях с каждым пациентом (Ferro, Civitarese, 2015; Ogden, 2025), своего рода марионетка, которую в аналитической игре можно мучить, не понимать, оскорблять, не разрушая при этом самое приватное чувство «я» аналитика.

Мистер Хайд же, напротив, хранит наиболее деликатные и личные переживания «я»: пространство *rêverie*, собственное аналитическое функционирование, но также воспоминания о нежности и эмоциональные ассоциации, связанные с его носками. Это то пространство, которое мы ощущаем как «наше собственное», независимо от того, насколько оно трансформируется и деформируется встречами с другим в неизбежном эмоциональном и субъективном взаимопроникновении. Это место, где мы можем быть наедине с собой, даже в присутствии другого (Winnicott, 1958, 1971).

Глубинный смысл моего предупреждения заключается в необходимости оберегать наиболее приватные области нас самих, которые неуместно и не полезно разделять в открытую с конкретным пациентом, если мы хотим сохранить большую свободу в пространстве совместно проживаемого вымысла аналитической игры (Winnicott, 1965; Ogden, 2018b; Civitarese, 2021).

В отличие от нарративного пространства, несущего совместно создаваемую в сессии с пациентом истину, я предлагаю проявлять осторожность в раскрытии элементов жизни и приватных мыслей мистера Хайда, Луки или Джейн. Это пространство, оберегаемое сеттингом, тем более значимо, чем интенсивнее становятся отношения; пространство, имеющее отношение прежде всего к другим связям — с самим собой и с другими, — где персонаж покидает сцену, уступая место личности.



Пациенты жаждут живого присутствия аналитика, которое формируется в совместно проживаемом с ними опыте, а от прямолинейного, «сырого» рассказа они редко что-либо выигрывают. Личная биография вступает в сессию не как автобиографическая история, а как психический материал, который питает чувствительность, отзывчивость и способность осмыслять поле (Ogden, 1994; Civitarese, 2005; Ferro, 2009).

Самораскрытие зачастую мотивировано потребностью аналитика снизить эмоциональное и переносное напряжение в работе с пациентами, и разделение собственных переживаний становится легким способом расслабиться (Freud, 1912; Jacobs, 1999).

Кроме того, мы не можем знать, как пациенты будут употреблять (и злоупотреблять ими) эти ценные фрагменты нас самих в последующие месяцы или годы, и сколько страдания это может нам причинить; поэтому разумно сохранять их в безопасном месте.

Наконец, следует помнить, что любая откровенность необратима, так что мы никогда больше не сможем работать с пациентом, который не знает этой стороны нас.

Итак, как нам тогда начинать сессию по-новому, не подвергая себя излишним рискам?

## **Ненасыщенные реакции и ирония: инструменты аналитического поля**

Наряду с классическими вариантами, не утратившими своей ценности, сегодня, когда молчание кажется не лучшим выбором, я предлагаю использовать ненасыщенные, ироничные реакции, способные передавать аффект и ле-

гитимизировать любопытство, а не давать окончательных, объективных ответов, которые скорее закрывают, чем раскрывают поле.

Если мы принимаем тот факт, что мы можем быть податливыми как персонажи, марионетки, субъективные или переходные объекты, то вопрос, раскрывать себя или нет, отходит на второй план: «Самораскрытие — это не выбор, а неизбежность» (Aron, 1991; Greenberg, 1995; Levine, 2007).

Вирджиния рассказывает мне о своей пациентке, иностранке Веде. Та делится чрезвычайно болезненными историями, которые глубоко трогают Вирджинию: Веда — молодая женщина, принадлежащая культуре, в которой детей принято наказывать очень жестоко и в которой сексуальное насилие — явление нередкое и социально приемлемое. Вирджиния боится не справиться с эмоциональной нагрузкой и нарушить профессиональную асимметрию: «Не представляете, каких усилий мне стоит сдерживать слезы».

Я спрашиваю ее, правда ли ей нельзя плакать, и она отвечает: «А что мы будем делать, если заплачем обе?» Я говорю, что одна из них может плакать из-за отчаяния, а другая из-за сочувствия: так она может показать, что эмоции не разрушают терапевта.

— А если пациентка будет шокирована и спросит, почему я плачу?

— Вы всегда можете ответить, что вам что-то попало в глаз.

Смысл этого разговора не в том, чтобы подсказать Вирджинии, что ей следует говорить пациентке, а в том, чтобы помочь ей понять, каким образом она может предложить ей часть своего подлинного «я», не проваливаясь при этом в ситуацию, где эмоции перестанут быть управляемыми.

После того как я легитимизировал ее слезы, Вирджиния стала чувствовать себя свободнее в присутствии пациентки, не испытывая необходимости сдерживаться.

«На самом деле я почти никогда не плакала, — замечает она. — Но мы обе почувствовали, что теперь у нас стало больше пространства для контакта. Она прочитала мне письмо, которое написала много лет назад, когда подумывала о самоубийстве. Мы обратили внимание, какая дистанция разделяет ту Веду и Веду сегодняшнюю. И уже какое-то время она слышит внутри себя мой голос, который ее утешает. Я чувствую облегчение, но в то же время боюсь быть поглощенной».

Затем Вирджиния обращается ко мне с пронзительным вопросом: «Вы часто говорили мне о подлинности, и теперь я хочу узнать: вы уверены, что эта сильная реакция боли — моя, что она подлинная? Или вместо этого я играю роль, которую она навязывает мне посредством симбиотической связи?»

С точки зрения интерсубъективных и полевых теоретических моделей, на вопрос Вирджинии невозможно найти простой ответ в терминах дуализма «подлинное/неподлинное». Подлинность — это не некое изначальное отдельное «я», это признание того «я», которое формируется в отношениях.

## **Ложь и преходящие истины: игра с пылью**

Мария Луче говорит, что ей есть что рассказать, но, возможно, лучше не поднимать эту тему, чтобы потом не было больно, учитывая, что скоро у нас перерыв на отпуск. Лучше отложить это на потом.

— Хотите замести пыль под ковер?

— Доктор, у вас ведь больше нет ковра.

— Возможно, это не случайно, — отвечаю я, улыбаясь.

— Есть много других мест, где можно что-нибудь спрятать, — возражает Мария Луче, оглядываясь вокруг.

— Вот почему я так забочусь о чистоте этой комнаты: чтобы можно было увидеть, где пыльно.

— Док, вы что, сами делаете уборку в кабинете? — спрашивает она, округлив глаза.

— Разумеется! — отвечаю я уверенно.

— Ни за что бы не подумала! Учитывая, насколько вы заняты, я бы предположила, что уборку делает кто-то другой.

— А как я смогу следить за пылью, если уборкой займется кто-то другой?

Мария Луче начинает рассказывать о своей тяжелой работе, а потом признаётся, что боится: если она позволит себе подробно описать тридцать лет мучительного труда, унижений и сексуального насилия, то во время летнего перерыва останется одна, без моей помощи. Затем она снова оглядывается по сторонам, улыбается и повторяет, что не может поверить, что я сам убираю в кабинете.

— Должен же у вас быть кто-то заслуживающий доверия? — говорит она.

— Заслуживающий доверия, это вы правильно сказали.

— Кто-то, кому вы сможете объяснить значение пыли, — продолжает Мария Луче.

— Это должен быть очень чувствительный человек, с хорошей интуицией.

— Думаю, вы его еще не нашли.

Потом она удовлетворенно улыбается и заключает: «Мне нравится эта игра с пылью».

Прежде чем вы спросите об этом: нет, я не занимаюсь уборкой в кабинете. Это делает Абигейл. Мне очень нравился персидский ковер на полу в моем кабинете, но аллергия на пыль оказалась сильнее, и я от него избавился.

Я мог бы рассказать обо всем этом моей пациентке: мы могли бы поговорить о персонаже Энрико, о моей прогрессирующей непереносимости пыли, о необходимости «поддерживать поле в чистоте». Суть в том, что вся эта информация ни в коей мере не более истинна, чем ложь, которую я ей поведал. Она, конечно, более реальна, но не более истинна.

Дело в том, что мой внутренний настрой не был обманым: я не хотел оттолкнуть любопытство пациентки, скрыв правду. Это, как мы уже видели, можно сделать разными способами: храня молчание, предлагая интерпретацию, «затыкающую рот», обманывая. Это не психоаналитично, но иногда мы поступаем так, чтобы восстановить свое безопасное пространство, когда впадаем в невыносимую симметрию.

Поэтому я провожу различие между обманом и ложью: я считаю, что это разные полярности.

Как говорит Гротстейн, ложь — это «злой близнец» сновидения: она имитирует его структуру, порождая образы и повествования, но искажает его трансформирующее назначение — приближать психику к истине (О).

Я же считаю, что ложь выполняет для истины защитную функцию, когда интенсивность эмоций угрожает сокрушить психику как отдельного человека, так и аналитической пары. Я смотрю на нее как на кухонные

прихватки, с помощью которых можно брать за самые раскаленные содержания, не обжигаясь, и постепенно работать с ними по мере того, как они остывают и становятся более мыслимыми.

Мне не хотелось, чтобы Мария Луче возвращалась к своей обычной позиции послушной маленькой девочки, что могло бы произойти, если бы моя реакция показалась ей отстраненной. В то же время я подумал тогда: я знаю каждый предмет в своем кабинете, я сам разместил его именно там, и не без причины. Пациентке это известно, ее заводят картины и предметы декора, она фантазирует о них, поэтому я почувствовал, что мое высказывание открывает и эту конкретную истину. Одновременно Мария Луче чувствует ко мне благодарность за те годы, в течение которых я с полным принятием слушал ее рассказы о насилии и мучениях, которые она перенесла за свою жизнь, и в тот момент мой образ становился также свидетельством конфиденциальности наших долгих доверительных разговоров: мы всегда вдвоем, лицом к лицу с ее кошмарами.

Как видите, если взаимодействие ненасыщенное, оно способно передавать не одну, а несколько истин; это истины с маленькой буквы, мимолетные, многоликие и постоянно трансформирующиеся. В этом отношении Бион пишет в *Transformations* (Bion, 1965, ch. 4): «Ненасыщенная интерпретация не исчерпывает область потенциальных значений; она оставляет открытой возможность дальнейших трансформаций».

Истина постоянно меняется, как и отношения, лежащие в ее основе, и мы, как вовлеченные стороны, не можем быть ее точными толкователями; скорее, мы совместно создаем ее, не осознавая этого.

Чтобы не замечать пыль под ковер в этом обсуждении, добавлю, что Мария Луче работает уборщицей в медицинском учреждении, и я признаюсь, что в тот момент какая-то часть меня была готова стать более похожей на нее — кем-то вроде Золушки в мужском обличье, — лишь бы не выглядеть одним из тех заносчивых докторов, о которых она иногда рассказывает. Это также было попыткой уменьшить асимметрию, которую я переживал как проявление высокомерия. Мы можем рассматривать «Золушку-мужчину» как переходного персонажа между высокомерным знанием (колющее<sup>42</sup> К идеализированного отца-деспота Марии Луче, известного и чрезвычайно строгого врача) и заботой, которая становится служением.

Несомненно, интерпретации выполняют двойную функцию: они выявляют неоформленное, а также регулируют отношения внутри аналитической пары (Freud, 1915; Ferenczi, 1932; Winnicott, 1989; Aron, 1996; Ferro, 1999). В нашей «игре с пылью» мы с Марией Луче исследовали отношения двух людей, способные удерживаться сами по себе, без «помощников по дому». Отношения, в которых есть доверие, но также и риск соблазнения. Мне предстоит способствовать вступлению в поле нежности, а не эротизма.

Это величайший дар психоанализа и в то же время его проклятие: смелость смотреть правде в глаза, даже когда она неудобная, частичная и неопределенная, но также необходимость взять на себя полную ответственность за грядущие последствия.

42 Итальянское слово *puntuta* имеет также значение «заостренная, остро-конечная». — Прим. пер.

## **Заключение: носки, слезы и разделяемые сновидения**

Сегодня мы не обсуждали конкретную реальность: если аналитик воспринимает слова пациента как объективные данные, начиная с носков и заканчивая пылью, то он участвует в коллапсе символического измерения аналитической встречи. Когда я слышу, как некоторые коллеги говорят о «чересчур конкретных пациентах», я повторяю, что их задача состоит в том, чтобы содействовать развитию у аналитической пары способности сновидеть эту конкретную реальность, то есть символизировать ее и играть с ней.

Как и во сне, в сессии сновидящий не находится за пределами сцены, он ее неотъемлемая часть: он пугается, волнуется, удивляется, разочаровывается. Более того, он может иметь крылья, быть немым или замедленным, узником или мертвецом.

Креативность и эмоциональная мощь сновидений, как ночных, так и в сессии, пропорциональны нашей готовности разрешить себе проникнуться сновидческой атмосферой. Становиться марионетками, как я предложил выше, страшно, но это может быть и захватывающим, если позволяет нам внести вклад в совместно проживаемое повествование (Ferro, Nicoli, 2023).

А потом, в конце сессии, мы можем вернуть себе свою личную идентичность (неизбежно помятую в аналитическом взаимодействии), которая всё это время надежно хранилась в метре позади нашего кресла.



## Часть 3. Уязвимость

# Присутствие сквозь шум сирен

*Полина Черкас*

В этом городе снова падает снег,  
Мои руки замерзли, но моя душа нет.  
И когда на кухне у тебя горит свет,  
Он важнее для меня, чем сотни комет.

Есть события, которые делят жизнь на «до» и «после». Мы едем по ночной трассе от озера Кинерет до дома. Моя группа, в которой я клиент, начинается через час, и я понимаю, что не успеваю.

— Здравствуйте! Я сегодня не приду на группу, не успеваю доехать из поездки. В следующий четверг должна быть.

— Полина, добрый вечер! Принято. (Переписка в чате с ведущим 12 июня 2025 года.)

Я откладываю телефон и, прислонившись виском к окну в машине, смотрю, как солнце садится в горы.

За следующие двенадцать дней я ни разу не пожалео о своем решении пропустить группу в угоду тому, чтобы с друзьями съездить в черкесскую деревню, искупаться в Кинерете, посидеть в итальянском ресторане в первом кибуце и увидеть этот прекрасный закат.

Именно воспоминания о том, что жизнь бывает еще и такой, дадут мне силы пережить следующие три дня.

Так спасают не только терапевтические группы, но и те, которые окружают нас ежедневно: семья, друзья, незнакомые люди, разделяющие с тобой защищенное пространство во время воздушных тревог, несущих с собой страх смерти. Реальной смерти.

И даже на любой из других планет  
Я найду тебя сквозь миллионы лет,  
А у тебя всё так же горит свет,  
И если ты со мной, то значит, смерти нет.

Этой же ночью мы встанем по тревоге. В 02:59 13 июня, быстро спускаясь по лестнице, я пытаюсь перевести сообщение, которое высвечивается на экране моего телефона, онлайн-переводчиком. Уведомление почти целиком написано на иврите, и всё, что я понимаю, — два слова на английском в самом верху: «экстрим алерт» — экстренная тревога. За окном — сирена.

Оказывается, что израильтянка, которая без проблем может прочитать текст этого сообщения целиком, понимает не больше нашего. И в этой неопределенности, в подвале нашего дома, мы сидим с нашими животными, понимая один четко написанный неоспоримый факт, который вслух произносит для нас соседка:

— Мы пошли против Ирана.

Есть моменты в этой жизни, которые делят ее на «до» и «после». И, похоже, это знакомо каждому из нас. Вы можете вписать туда любое событие, которое провело черту где-то глубоко внутри вас. Подумайте о чем-то, после чего вы уже не были прежним.

Продолжали ли вы работать?

«Здравствуйте! У меня, к сожалению, сегодня чрезвычайные обстоятельства, в связи с которыми не смогу провести сессию, поэтому вынуждена ее отменить. Буду ждать вас в следующий раз по расписанию», — утром я отправляю два таких сообщения клиентам, сессии с которыми назначены на 13 июня.

Мне везет. Если, конечно, можно так сказать в сложившихся обстоятельствах. Первые три дня войны у меня нет ни групп, ни клиентов. Работаю я по расписанию российского, и на эти даты выпадают праздники. Так моя русская идентичность спасает израильскую.

Что я не смогу работать в это время, мне становится кристально понятно утром 13 июня, когда я отменяю эти две сессии. Состояние неопределенности, депривация сна, постоянно срабатывающие воздушные тревоги.

Есть опыт, о котором лучше прочитать в книгах. Теоретизировать. Размышлять на супервизиях. Шерстить по справочникам. Умными словами говорить о «симптомах» и «проявлениях».

За первые три дня я приобретаю опыт переживания острого стрессового расстройства. Не теоретический. Эмоциональный. И иногда, сидя в миклате<sup>43</sup>, вздрагивая

от грохота из-за вылета ракет-перехватчиков, я вспоминаю Биона и его «мыслить под обстрелом».

Задача, красиво звучащая теоретически. И невыносимая, когда становится буквальной.

Но мы попытались.

И даже на любой из других планет  
Я найду тебя сквозь миллионы лет,  
А у тебя всё так же горит свет,  
И если ты со мной, то значит, смерти нет.

Люди, с которыми я работаю, находятся в другой реальности. И каждому из них, будь то индивидуальный клиент или группа, мне теперь необходимо рассказать о своей. Потому что теперь моя реальность не мифическая. Она не остается за пределами нашего виртуального кабинета, а буквально становится его частью.

Каждый раз, когда срабатывает сигнал тревоги и я вынуждена прервать сессию. Каждый раз, когда кто-то из клиентов читает новость о попадании ракеты в Тель-Авив. Хайфу. Беэр-Шеву. Каждый раз, когда в начале сессии от клиента звучит вопрос «как вы». И на него нельзя ответить в рамках психоаналитической техники: «похоже, вам тяжело начать говорить о себе» или «у вас есть какие-то фантазии о том, что со мной происходит?». Потому что единственно верный ответ в этой ситуации, на мой взгляд, человеческий.

И со временем он начинает звучать, возможно, по мнению многих коллег, совсем не аналитично. Но очень искренне:

— Лучше, чем вчера.